为广泛的国际性探索。尊重原则、不伤害原则、有利原则和公正原则被较为广泛的国家和地区的医学组织视为医师执业的行为依据，成为相对成熟的国际医学伦理基本原则。

一、尊重原则

（一）尊重原则的含义

尊重原则（principle of respect）是指医务人员尊重患者的伦理原则，要求尊重患者的道德权利，允许具有民事行为能力的患者自主选择医疗方案。自主是尊重原则的重要部分，欧美一般称尊重原则为自主原则，即对自主的人及其自主性的尊重。知情同意、要求保守秘密和保护隐私等均是患者自主性的体现。广义上的尊重原则还包括医务人员尊重患者及其家属的生命、人格和尊严。

（二）尊重原则的主要要求

1. 尊重患者的生命　生命是人存在的基础，是人的根本利益所在。尊重患者生命首先要尽力救治患者，维护其生命的存在，这是对人的生命神圣性的尊重。其次，要通过良好的医疗照护提高患者的生命质量，以维护其生命价值，这是尊重人的人格生命的具体体现。尊重人的生命及其生命价值是医学人道主义最根本的要求，也是医学道德的基本体现。

2. 尊重患者的人格尊严　尊重患者人格尊严，一是要尊重患者作为独特个体的生命存在，重视他生命的质量，体悟他因病痛所忍受的痛苦，将减少对患者的身体伤害和缓解痛苦作为伴随患者救治过程的道德主旨；二是要尊重患者的内心感受和价值理念，重视社会和心理因素对患者的影响，肯定患者对自我生命的理解和抉择；三是要肯定患者生命存在的价值和意义，承认生命个体得到善意和被尊重的权利，而无论其生命体处于何种状态。

3. 尊重患者的隐私　《中华人民共和国民法典》规定，隐私是自然人的私人生活安宁和不愿为他人知晓的私密空间、私密活动、私密信息。除权利人明确同意外，任何组织或者个人不得侵扰他人的私人生活安宁、侵入私密空间、侵犯私密信息。医疗职业的特点决定了医师常常可以了解到患者的某些隐私，涉及患者从未向他人谈到或暴露过的身心领域。医师有义务为患者保守秘密，以免泄露信息给其带来伤害。同时，医师也有义务在为患者实施检查治疗时保护其身体不被他人随意观察。

4. 尊重患者的自主权　自主主要指自我选择、自由行动或依照个人的意愿自我管理和自我决策。患者自主权（patient autonomy）是指具有民事行为能力并处于医疗关系中的患者，在医患有效沟通交流之后，经过深思熟虑，就自身有关疾病和健康的问题作出合乎理性的决定，并据此采取负责的行动。这是患者享有的一种重要权利，与其生命价值和人格尊严密切相关。

尊重患者自主权意味着患者自己作出选择和决定，这需要具备一定的前提条件。患者实现自主性的条件包括：医师应为患者提供正确、适量、适度且患者能够理解的信息；患者必须具有一定的自主能力，丧失或缺乏自主能力则无法作出选择和决定；患者的情绪必须处于稳定状态，过度紧张、恐惧、冲动会影响患者的自主决定；患者的自主决定必须是经过深思熟虑并和家属商量过的，如果患者的决定过于草率，则无法反映其真实的自主性；患者的自主决定不会与他人、社会的利益发生严重冲突，也就是说患者的自主决定不会危害到他人和社会的利益，否则需要加以限制。

（三）尊重原则在医疗实践中的应用

在医疗实践活动中，知情同意、医疗保密等医务人员遵守的行为规范和伦理准则反映了尊重原则的基本理念。

1. 知情同意

（1）知情同意的起源与发展：知情同意在医学科研和医学实践两个领域有各自独立产生和发展的历程。医学科研中的知情同意原则源于《纽伦堡法典》，文件中明确规定“受试者的自愿同意绝对必要”，并对受试者同意的合法能力、对信息的理解、自愿参加、自由退出等方面作了规定。1964 年世界医学会通过的《赫尔辛基宣言》、1978 年美国国家保护生物医学和行为研究受试者委员会发布的《贝尔蒙报告》，以及 1982 年国际医学科学组织委员会和世界卫生组织制定的《人体生物医学研究国

际伦理指南》,都对生物医学研究知情同意各方面的问题作出了详细的阐述和规定。

医疗实践中知情同意原则是在普通法(common law)的侵权理论基础上,由美国的一系列司法判例来确定的。这些案例最初确定的是患者同意权,然后开始注意保护患者的知情权,并因此演变成为知情同意权。1957 年,美国的一起医疗诉讼案件,首次使用了“知情同意”一词。在之后的案例判决中,逐渐增加了应用通俗的语言向患者告知疾病性质、治疗、替代疗法、后果等内容,使得临床中知情同意的规定更为详细和科学,推动了知情同意原则的不断完善。临床实践必须尊重患者的知情同意权,逐渐得到了世界各国医学界的普遍认可。知情同意原则在我国实行 30 多年来,在医患关系中逐渐形成了民主平等的价值观。

从本质上来说,医疗实践中知情同意的产生和发展体现了医患关系从家长主义时代到自主时代的历史演进。在西方医学发展过程中,家长主义持续数千年,其前提是对医师的技术与职业道德的信任,以患者依从与医师主导为典型特征。在医患关系中,家长主义强调对患者的照护,而不是患者的意愿和权利;强调医师的道德权威而不是患者的自主或自我决定。第二次世界大战后,随着人们人权意识的觉醒以及之后广泛的政治与社会运动影响,医患关系进入患者自主时代,在医疗活动中,强调患者自主和知情同意。

(2)知情同意的内涵:知情同意的内涵可以概括为有民事行为能力的人在信息充分提供的条件下对所参与事情的自愿同意。包括信息、理解和自愿三个要素,涉及“知情”与“同意”两部分内容。“知情”是指以患者可以理解的方式全面而充分地告知其与疾病诊疗有关的信息;“同意”是指患者在充分理解相关信息的基础上,不受任何威胁、恐吓和引诱等外力的影响而作出自己的诊疗决定。

在知情方面,告知信息应当是真实、准确、全面和充分的,医师应尽可能将专业术语转化为通俗易懂的语言,以便于患者及其家属理解。医师需要对患者及家属的理解能力作出判断,并且在患者及家属作出重要医疗决策之前,确定他们确实已经理解相关信息。信息的告知应贯穿于医疗全过程的每一个环节,不应简化为单一的一次性流程。

同意必须在知情、充分理解和自愿基础上进行。医方以某种利益欺骗、诱惑或施以某种影响引导患者或家属的同意,或者家属向患者施以某种影响或压力的同意都是不能接受的。知情同意书是知情同意的重要形式,但并不是知情同意的全部,签署知情同意书这一形式必须与知情同意的实质相一致。

(3)知情同意与医师干涉权:医师作为医疗行为的主体有权决定采取何种医疗措施,患者作为身体的主人享有自主决定权。两者在通常情况下是一致的,但有时可能发生矛盾,就一般情况而言,不能随意否定患者的自主权,取缔知情同意。而在某些特殊情况下,医师可以恰当行使干涉权。

首先,恰当行使权利,维护急救患者利益。医师要尊重患者的知情同意和知情选择的权利,对于缺乏或丧失自主能力的患者,应尊重其家属或监护人的此项权利。当患者病情危急需要立即进行处置和抢救,家属不在场,来不及获取患者及其家属知情同意的时候,医师出于对患者负责和患者利益的考虑,应该恰当行使干涉权,作出对患者有利的决定。

其次,医师要履行帮助、劝导患者及其亲属的责任。一是要帮助患者及其亲属,为其提供应有的信息并帮助其理解,以利于其选择,并帮助其作出符合自身利益的决定;二是要劝导患者及其家属。如果患者及其家属的选择与医师有利于患者的医疗决策不一致,且有可能给患者带来伤害,医师应劝导患者及其家属,而不要采取听之任之、出了问题责任自负的态度。

最后,对患者及其亲属的选择采取必要的限制。如果患者的选择与他人、社会的利益发生矛盾,有可能损害他人和社会利益时,医师应首先协助患者进行调整,以履行对他人和社会的责任,并使对患者的损害降到最低。如果患者的选择对他人的生命和健康构成威胁或者对社会利益造成危害,医务人员对患者的选择进行必要的限制是符合道德的。对于不能独立表达自己意见的患者,如果其法定代理人的选择与医师的主张不同,且这种选择有违患者的健康利益并可能危及患者生命时,医师应在取得医疗机构负责人或医院伦理委员会的同意后,坚持正确的治疗方案以维护患者的健康,抢救患者的生命。

2. 医疗保密

（1）医疗保密的概念：医疗保密（medical confidentiality）通常指医务人员在医疗过程中不向他人泄露有关患者疾病的隐私信息。其中，“有关患者疾病的隐私信息”主要包含患者依据医师诊断的需要所提供的有关个人行为、生活、生理、心理等方面的隐私，以及医师在诊断过程中了解到的有关患者疾病性质、治疗方式、预后等方面的信息；“不向他人泄露”，主要指不向与患者治疗无关的人员泄露。

（2）医疗保密的伦理意义

1）体现了对患者隐私权的尊重：医疗保密与隐私保护、特许交流这两个概念有着紧密的联系，均包含限制他人对自我信息接近的意味。隐私受法律的保护，不许他人在未经许可的情况下对个人进行干涉，在信息的交流传达中不许第三方的介入；特许交流是指那些受法律保护而不许透露的机密交流，如某个人透露给配偶或某些特定职业者（医师、律师、精神分析医师等）的个人信息，除非有相应的授权特许，其他人对这些信息的接近是受限制的。医师和患者在医疗服务过程中进行的交流属于特权信息，除非得到患者的同意或法律另有规定，否则不得向第三方披露。《中华人民共和国民法典》第一千二百二十六条规定：“医疗机构及其医务人员应当对患者的隐私和个人信息保密。泄露患者的隐私和个人信息，或者未经患者同意公开其病历资料的，应当承担侵权责任。”

2）维护医患信任关系：保密（confidentiality）设定了一种基于信任和诚实的关系。在这种关系中，患者会披露其医疗所需的信息，相信医师的专业能力，并在治疗过程中与医务人员合作。而医师必须利用他们的专业知识对患者进行准确的诊断和有效的治疗。当患者为寻求医疗保健而同意进行体格检查、接受各种测试，陈述生活史或病史时，他们便对有关医务人员放弃了某些个人隐私。基于医疗保密而存在的信任和诚实关系是患者对自己的主治医师放弃隐私的基础，保护患者隐私会加强信任关系，而泄露患者的隐私，无论是有意的还是无意的，都必然会破坏医患之间的信任关系。

（3）医疗保密的伦理条件：在医疗实践中，保密并不是无条件的，保守医疗秘密需要满足以下伦理条件。

1）医疗保密以不损害患者自身利益为前提：如果医师的保密行为有可能伤害到患者的健康和生命利益，则不应为其保密。例如一个有自杀意向并且有能力付诸行动的患者，要求医务人员对其自杀意向进行保密。此时，医务人员应意识到恪守医疗保密原则会与患者自身的生命和健康利益相冲突，出于患者利益的考虑而不作出无条件保密的承诺，具有道德上的合理性。

2）医疗保密以不伤害他人的利益为条件：如果医师满足患者的保密要求会给无辜的第三者带来伤害，则不应无条件为其保密。

3）医疗保密以不损害社会利益为条件。如果为患者保密会带来必然的损害社会利益的后果，则应以社会利益为重，拒绝患者的保密要求。

4）医疗保密以不违背现行法律法规为条件。如果医疗保密与现行法律法规相冲突，则应放弃保密义务，与法律法规保持一致。

3. 知情同意与医疗保密的关系　在医疗实践中，需要处理好知情同意与保密的关系。在履行知情同意过程中，医师应注意遵守保密要求，不随意扩大知情范围，例如：未经患者同意，不随意公开患者治疗或接受试验过程中的有关情况及信息。如果将病情告知患者可能对其产生不利影响，甚至会影响救治、加重病情，应取得家属的同意而对患者暂时保密；当患者的民事行为能力受限，如意识不清等，需要将患者病情告知家属时，如果将患者某些隐私告知家属后可能影响患者的家庭关系，而不告知并不会影响对患者的医疗决策，也不会危害他人和社会利益，应为患者保密而不告知家属。

二、不伤害原则

（一）不伤害原则的含义

不伤害原则（principle of nonmaleficence）是指医务人员在诊治过程中，其动机和结果均应避免对

患者造成生理上和心理上的伤害，更不能人为地制造伤害。

（二）医疗伤害的种类

依据不同标准，医疗伤害可以划分为多种类型。例如依据伤害的性质可分为正当伤害与不当伤害；依据伤害的客体可分为躯体伤害、精神伤害与经济损失；依据伤害的影响长短可分为近期伤害与远期伤害等。在临床医疗实践中，根据与医方主观意志及其责任的关系，可以作出如下划分：①有意伤害与无意伤害。有意伤害是指医务人员出于主观故意对患者的身心健康造成伤害。例如医务人员不负责任，没有采取必要的医疗措施；或者出于不义目的，为患者滥施不合适的诊治手段等。无意伤害是指非医方主观故意，而是实施正常诊治所带来的间接伤害，例如手术治疗带来的伤害。②可知伤害与不可知伤害。可知伤害是指医务人员在实施医疗措施之前通过预测评估可以预先知晓也应该知晓的对患者的伤害。不可知伤害是指医务人员虽经预测，但仍对患者造成的难以预料或无法预估的意外伤害。③可控伤害与不可控伤害。可控伤害是指医务人员在现有医疗条件下可以控制的伤害，例如严格实施无菌操作以避免患者发生感染。不可控伤害指超出医务人员控制能力的伤害，例如孕妇在医院产检过程中，发生主动脉夹层破裂导致心脏压塞，尽管医务人员全力抢救，但没有成功，患者死亡。④责任伤害与非责任伤害。责任伤害是指与医务人员的责任相关的医疗伤害，由于医务人员没有尽到应尽的职责，消极推诿、疏忽大意或过于自信等导致的伤害。有意伤害、可知可控却未加预测和控制的伤害均属于此类情况。非责任伤害指并非由医务人员的责任心不强所导致的对患者的伤害，如无意伤害、可知而不可控伤害、意外伤害等。发生责任伤害通常应追究医务人员的法律责任。对于非责任伤害，应意识到其不可避免性，通过必要的医疗手段将伤害最小化。

（三）不伤害原则的伦理要求

为预防对患者的有意伤害或将伤害降到最低限度，医务人员应做到：①树立不伤害的意识，在医疗活动中首先想到不伤害患者，杜绝有意伤害和责任伤害，把不可避免但可控的伤害控制在最低限度，使伤害最小化；②培养为患者健康和利益着想的意向和动机，尽力提供最佳的诊治手段；③权衡利益和伤害，对有危险或有伤害的医疗措施进行评价，选择利益大于危险或伤害的措施。

三、有利原则

（一）有利原则的含义

有利原则（principle of beneficence）是指医务人员的诊治行为以保护患者利益、促进患者健康、增进其福祉为目的的伦理原则。有利原则也称为行善原则。

在《希波克拉底誓言》中，明确提出并阐明了“为病家谋利益”的行医信条。2017 版的《日内瓦宣言》提出：“在我被吸收为医学事业中的一员时，我严肃地保证将我的一生奉献于为人类服务”“我的患者的健康和福祉将是我首先考虑的”，这些都体现了有利原则。

（二）有利原则的伦理要求

有利原则要求医务人员：①首先考虑患者的利益，做对患者有益的事，努力维护患者的生命健康，当患者利益与医师的经济利益发生冲突时，将患者的利益放在首位；②准确诊断、有效治疗，努力提高医疗业务能力，为患者提供最为准确的诊断和最为有效的治疗，通过高超的医疗技术提高患者的生命质量，满足患者的健康需求；③提供最优化服务，对利害得失全面权衡，选择受益最大、伤害最小的医学决策；④坚持公益原则，将有利于患者同有利于社会健康公益有机地统一起来。

四、公正原则

（一）公正原则的含义

公正（justice）即公平、公道、正义。在人类社会发展的不同阶段，公正的内涵并不完全相同。在我国古代，公正指为人正直，行为处事不偏不倚，不含私心。例如，《韩非子·解老》中的“所谓直者，义必公正，公心不偏党也”。

古希腊时期的柏拉图（Plato）将公正视为人的一种品行，即每个人在社会中发挥其适当角色的行为。公正就是每个人按照自己的能力和地位在自己的位置上各司其职，互不越权。在柏拉图看来，公正既是一种美德，也是其他美德实现的最高境界。亚里士多德（Aristotle）将公正视为一种中庸之道，是对平均值的追求，是根据每个人的功绩和价值分配资源，是对不同人应有的待遇进行区分和判断，亦即有关方面相同的情况相同对待，不同的情况不同对待，也就是说“给人应得”。无论在西方还是中国，从法律或伦理角度，公正所强调的核心都是对人的权利的维护。

公正可以理解为相互补充的两层含义：一是完全平等，即平等对待、一视同仁，如平等对待每一位患者；二是比例平等，即根据某些因素合理区别对待，例如给予急诊患者优先救治。

公正原则（principle of justice）是指以形式公正与内容公正的有机统一为依据分配和实现医疗和健康利益的伦理原则。形式公正是指分配负担和收益时，相同的人同样对待，不同的人不同对待。在医疗实践中，此项原则是指类似的个案以同样的准则加以处理，不同个案以不同准则加以处理。内容公正是指依据某些因素来分配收益和负担，即依据什么来判断谁是应得者，应得什么，应得多少。例如，现阶段我国稀有卫生资源分配所依据的相关标准。

公正原则首先强调基本健康权人人平等，保障人们的基本医疗保健需求，即应人人同样享有。1946 年 7 月 22 日颁布的《世界卫生组织宪章》规定：“享有可能获得的最高标准的健康是每个人的基本权利之一，不因种族、宗教、政治信仰、经济及社会条件而有区别。”对于公民所具有的基本的合理的医疗护理以及获取健康的权利要予以保障，体现人人平等。要坚持基本医疗卫生事业的公益性，通过完善制度、扩展服务、提高质量，让社会公众享有公平可及、系统连续的预防、治疗、康复、健康促进等健康服务。在基本医疗卫生服务领域政府要有所为，将公平可及和群众受益作为医疗改革和发展的目标。同时，公正原则并非意味着平均分配，应承认非基本健康需求的合理差别，对于患者超越基本健康权的医疗需求也应予以适当满足。随着我国经济和社会发展，公众对医疗服务的质量和水平有了更高需求，对于某些超越基本医疗范围的需求，在条件允许的情况下予以满足也是符合公正原则的，能够得到伦理辩护。但此类医疗服务主要依靠市场调节，通过释放市场活力提供不同层次的医疗服务，满足不同群体的健康需求。

（二）公正原则的伦理要求

这一原则要求医务人员：①公正地分配医疗卫生资源。医务人员既有分配医疗宏观资源的建议权，又有微观医疗资源的分配权，因此应该公正地运用自己的权利尽力保证患者享有的基本医疗和护理等平等权利的实现；②在医疗态度上平等待患，特别是对老年患者、年幼患者、残疾患者、精神病患者等要给予足够的耐心和尊重；③公正地处理医患纠纷、医疗差错事故，坚持实事求是。

思考题

1. 简述我国医学伦理指导原则的内容。
2. 尊重原则对医务人员的伦理要求有哪些？
3. 不伤害原则对医务人员的伦理要求有哪些？
4. 有利原则对医务人员的伦理要求有哪些？
5. 公正原则对医务人员的伦理要求有哪些？

（梁　莉）

本章数字资源

第六章 医疗人际关系伦理

医疗人际关系是在医疗活动中所结成的人与人之间的关系，包括医患关系、医际关系、医社关系等。这些关系是否和谐，不但直接影响着医疗服务质量的提升、医务人员的工作热情，还影响着医疗机构的声誉和形象，是医学伦理学研究的重要内容。

第一节 | 医患关系伦理

医患关系作为医疗活动中主要的人际关系，有其内在的规定性和特殊性，不应按照处理一般人际关系的方法处理医患关系。和谐医患关系的构建，不仅需要医护人员选择和遵循合适的医患关系模式，还需要医患之间彼此尊重并维护对方的权利，切实履行自身的义务，做到爱患尊医。

一、医患关系的含义及模式

(一) 医患关系的含义

美国医学史学家西格里斯特(Sigerist)认为："每一种医学行动始终涉及两类当事人：医师和患者，或者更广泛地说，医学团体和社会，医学无非是这两群人之间多方面的关系。"在这里，作者指出了医患关系的"狭义"和"广义"两种情形。

所谓狭义的医患关系，特指医师与患者之间的相互关系。广义的医患关系，是指以医师为中心的群体(以下简称"医方")与以患者为中心的群体(以下简称"患方")，即"医方"与"患方"在治疗或缓解患者病痛过程中所建立起来的人际关系。在这里，"医方"既包括医师，也包括护理人员、医技人员、药技人员、医院管理人员及后勤服务人员等，有时甚至是指医疗卫生机构；"患方"既包括患者，也包括与患者利益相关的亲属或监护人、代理人、单位组织等。尤其是患者失去或不具备民事行为能力时(如昏迷休克的患者、婴儿等)，患者的利益相关人往往直接代表患者的利益。而且，医患关系中的"患"未必就是患有疾病的人，也包括健康者，因为有求医行为的人或者说到医院的就医者如参加正常体检者、接受预防疫苗接种的儿童等，未必就是罹患疾病者，但相对于医方而言，他们可统称为"患者"。

医患关系作为一种特殊的人际关系，其实质是以诚信为基础的具有特殊契约性的信托关系。首先，医患关系以诚信为基础。一方面，医者要对患者诚信，拒绝过度医疗、防御性医疗，要尽力提供最优化的诊治方案；另一方面，患者也要对医者诚信，如实陈述病情甚至包括相关的隐私等信息。其次，医患关系是一种特殊的医疗契约关系。医疗契约关系与一般的契约关系不完全相同，例如医疗契约没有订立一般契约的相关程序和条款、承诺内容未必与要约内容完全一致、契约对患方没有严格的约束力、医方负有更重的注意义务，以及急危重症时强制的缔约义务等。再次，医患关系是一种信托关系。在这种关系中，患者由于医学知识和能力的缺乏对医师职业和医疗机构抱着极大的信任，将自己的生命和健康交托给医务人员和医疗机构。因此，这种关系不同于商品交换关系或陌生人之间的关系。

但是，医患之间的信托关系又与一般的信托关系不完全相同。从信托客体来说，在一般的信托关系中信托的客体是财产，而在医患关系中信托的客体是生命和健康；从受托权利来说，在一般信托关系中除了信托文件和法律的限制外，受托人享有以自己的名义处分财产所必要的一切权利，而在医患

关系中医务人员在以自己的名义对患者的生命和健康进行管理处分时，需要经过患者的知情同意；从意愿的达成来说，在一般的信托关系中受托人管理处分信托财产必须按照委托人的意愿进行，而在医疗活动中医务人员只能按照患者和家属的意愿尽力而为，并不能确保一定能达成患者和家属的意愿。

因此，医患关系既不同于一般的契约关系，也不同于一般的信托关系，而是以诚信为基础的具有特殊契约性的信托关系。

（二）医患关系的特点

1. 明确的目的性和目的的统一性　在一般人际交往中，交往双方并非都具有明确的目的性。而在医患交往中，其目的明确且只有一个，即为了诊治疾病，提高患者的健康水平，而且这一目的是医患双方所共同期望的。患者就医，目的是消除或减轻自身的病痛，提高健康水平；医务人员为患者提供医疗服务，根本目的也是为了消除或减轻患者的病痛。因此，医患交往不但具有明确的目的性，而且表现出高度的统一性。

2. 利益的相关性和价值实现的统一性　恩格斯指出："每一个社会的经济关系首先是作为利益表现出来的。"利益是经济关系的集中表现，也是道德问题的直接根源。人们之间正是有着共同的根本利益，才可能形成统一的道德原则和规范。医患双方的利益关系是社会整体利益的反映，体现了社会整体利益的一致性，即消除疾病、维持和促进人类的健康发展。但是，由于医患双方受其他利益的影响，各自的某些利益可能出现不一致。

3. 人格权利的平等性和医学知识的不对称性　在医患关系中，医患双方的人格尊严、权利是平等的，任何一方的人格尊严、权利受到对方的不尊重或者侵犯，都会受到医学道德的谴责，甚至法律的制裁。但是，医务人员拥有医学专业知识和技能，而大多患者对医学一无所知或一知半解。因此，医患双方在医学知识和能力方面存在着事实上的不对称性。

4. 医患冲突的敏感性和不可避免性　由于医疗卫生服务涉及千家万户，是一个面向公众的窗口行业，社会关注度、期望值较高。但是，由于医患双方对医学知识的理解、价值观念、医疗期望等方面存在差异，加之社会对医疗卫生保健的经费投入有限，医疗机构的管理尚有待完善，医患双方的自律意识尚待加强等原因，发生矛盾或冲突在所难免。

以上表明，医患关系具有一般人际关系所不具有的内在规定性，故而在医疗活动中医务人员不应当用处理一般人际关系的方法处理医患关系。

（三）医患关系模式

医患关系模式（physician-patient relationship model）是对不同情形的医患关系进行概括和总结的基本式样。对医患关系模式的理论分析，不能脱离医患关系的技术性即技术关系。技术关系是指医患之间在诊疗护理过程中通过技术而建立起来的行为关系，它表现在医患双方医疗技术实施过程中彼此的地位、作用等方面。不同的医患关系模式体现着医患之间不同的技术性和非技术性关系。不同的学者曾对医患关系模式给予了不同的表述。

1. 帕森斯模式　美国医学社会学家帕森斯（Parsons），通过比较医患关系与亲子关系，认为二者有相似之处。其一，两种情况都涉及一个人（孩子或患者）受另一个被社会承认有合法社会控制权利的人（父母或医师）的社会控制；其二，在两种情况下，虽然父母或医师都必须表现出某种程度的感情中立状态，但事实上，两种情况又都充满了浓重的感情色彩；其三，两种关系都把注意力集中在相似的目标上，即在一段时间内使孩子或患者变成能力健全的社会成员。

帕森斯关于医患关系的分析，强调了疾病的社会性质和人际交往，认为疾病是对社会正常行为的偏离，必须由医师对其进行社会控制，从而突出了医患关系的不对称性，帕森斯模式为人们了解医患之间的技术关系提供了有益的启示。但是，这种模式却淡化了患者生理症状在医患关系中的作用，而生理症状恰恰是医患关系中最重要的影响因素之一，医患关系的技术性质直接与患者就医时的生理症状有关，在症状严重的情况下可以用帕森斯的不对称模式。但是，正像一些批评者指出的，这种模式并不具有广泛的适用性。其一，并不适用于所有性质的疾病。例如在慢性病的情况下，患者并不总

是依赖于医师，他们有较大的自主性，对病情有较全面的了解。其二，传统的“一医一患”关系已被打破，随着社会环境的变化、医师数量及可供选择的医疗保健服务的增多，医患之间的不对称性会逐渐减弱。其三，随着医学专业分化越来越细，一个患者往往要与多个医务人员打交道，而且由于家庭成员的参与，患者对医师的依赖性也大为减弱；其四，随着健康概念的扩展，社会心理因素逐渐受到重视，心理治疗师、社会工作者等日益增多，这也使医师的控制作用逐渐减小。基于上述批评，人们分别提出了多种改进建议，其中影响较大的是萨斯-荷伦德的框架。

2. 萨斯-荷伦德模式　1956年美国学者萨斯（Szasz）和荷伦德（Hollender）两人在《内科学成就》上发表了《医患关系的基本模式》，依据在医疗措施的决定和执行中医师和患者各自主动性的大小，提出将医患关系分为主动-被动模式、指导-合作模式和共同参与模式。

（1）主动-被动模式：在这种模式中，医患双方不是双向作用，而是医师对患者单向发生作用，医疗方案、处置措施完全由医师决定，医师的责任是“为患者做什么”。在此，医师的权威性得到了充分肯定，处于主动地位；患者处于被动地位，并以服从为前提。就医患双方的作用和能力而言，这种模式类似于父母与婴儿的关系，因婴儿无自主能力需要父母为其决定一切。这种模式适用于昏迷、休克、精神病患者发作期、严重智力低下以及婴幼儿等一些难以表达主观意志的患者。这种模式有益于发挥医师的积极性，但对于具有自主能力的患者来说则不利于发挥其主观能动性，进而可能会影响诊治效果。

（2）指导-合作模式：在这种模式中，患者被看作是有意识、有思想的人，具有一定的主动性，能够主动述说病情，反映诊治情况，配合检查和治疗。但对医师的诊治措施既提不出异议，也提不出反对意见，医师仍具有权威性，仍居于主导地位，这种模式类似于父母与少年的关系，适用于大多数患者，医师的责任是“告诉患者做什么”。这种模式与主动-被动模式相比，有助于发挥患者的积极性，提高诊治效果，也是目前普遍采用的。

（3）共同参与模式：在这种模式中，医患双方共同参与医疗方案的决定与实施。这种模式适用于具有一定医学知识背景的患者或已长期患病的慢性病患者，它类似于成人与成人的关系，医师的责任是“帮助患者自疗”。从理论上讲，这种模式是最理想的，不但可以提高诊治水平，而且有利于建立和谐的医患关系。但是，并不是所有患者都具有参与的能力或意愿，即使具有自主能力的患者也往往因缺乏必要的医学知识而难以真正实施。

萨斯-荷伦德模式是在帕森斯模式的基础上提出的，并毫无保留地接受了前者的观点，又针对不同的疾病和患者进行了详细的区分，将单一的父母-孩子关系细分成了：父母-婴儿关系、父母-儿童（少年）关系、成人-成人关系。因此，严格意义上后者并没有超越前者，仅仅做了部分调整。而且，正如其批评者指出的：“坚持认为一种模式比另一种模式好是错误的和使人误解的。更确切地说，这是一个哪种模式对某种特定情况更适用的问题。”该模式的缺陷在于它仅仅考虑了医患之间的技术差异，是依据患者对医学问题的理解能力及疾病状况构建的，而忽视了医患之间的情感互动、文化差异及患者消费观念的改变、权利意识的增长等因素所引起的医患关系的变动性及多样性问题。

尽管以上三种模式在其特定的范围内都是正确、有效的，但对大多数患者来说应当按照指导-合作模式或共同参与模式来组织诊疗。尤其是随着公众受教育程度的提高及医学知识的普及，共同参与模式将成为更为理想的模式。

二、医患双方的权利和义务

（一）医方的权利和义务

1. 医方的权利　医师和护士是医疗活动的主体。目前，我国关于医疗机构从业人员的权利与义务的明文规定，主要针对这两个群体，具体包括《中华人民共和国医师法》《护士条例》。其中，《中华人民共和国医师法》以法律的形式规定了医师的下列权利：在注册的执业范围内，按照有关规范进行医学诊查、疾病调查、医学处置、出具相应的医学证明文件，选择合理的医疗、预防、保健方案；获取劳

动报酬，享受国家规定的福利待遇，按照规定参加社会保险并享受相应待遇；获得符合国家规定标准的执业基本条件和职业防护装备；从事医学教育、研究、学术交流；参加专业培训，接受继续医学教育；对所在医疗卫生机构和卫生健康主管部门的工作提出意见和建议，依法参与所在机构的民主管理；法律、法规规定的其他权利。

医师的以上法定权利，同时也是医师的道德权利。除此之外，医师的道德权利还包括要求患者及其家属配合诊治、对患者的不当行为或选择进行特殊干涉等。医师的特殊干涉权只有在患者的行为涉及自主权与生命健康权、有利与不伤害、个人利益与社会公益等发生根本冲突时才具有合理性，其目的在于限制患者某些自主权利，以确保患者自身、他人和社会的更为重要的权益免受损害。医师特殊干涉权适用的主要情形有：①精神障碍、自杀未遂等患者拒绝治疗或者想要自杀、正在自杀时，可强制治疗或采取医学措施控制其行为；②对甲类传染病和按照甲类传染病管理的乙类传染病患者进行隔离；③在进行人体试验性治疗时，虽然患者已知情同意，但在出现高度危险的情况时，医师中止试验以保护患者（受试者）利益；④危重患者要求了解自己疾病的真相，但当了解后很可能不利于诊治或产生不利后果时，医师可以根据《中华人民共和国民法典》关于“不能或者不宜向患者说明的，应当向患者的近亲属说明，并取得其明确同意”的规定，对患者进行适当且必要的告知，以实施保护性医疗。医疗机构其他从业人员的权利在此不再赘述。

2. 医方的义务　医师的义务是指医师应尽的责任，包括医师对患者的义务和对社会的义务两个方面。

（1）医师对患者的义务。根据《中华人民共和国医师法》《医疗机构从业人员行为规范》等，医师有以下义务：树立敬业精神，恪守职业道德，履行医师职责，尽职尽责救治患者，执行疫情防控等公共卫生措施；遵循临床诊疗指南，遵守临床技术操作规范和医学伦理规范等；尊重、关心、爱护患者，依法保护患者隐私和个人信息；努力钻研业务，更新知识，提高医学专业技术能力和水平，提升医疗卫生服务质量；宣传推广与岗位相适应的健康科普知识，对患者及公众进行健康教育和健康指导；法律、法规规定的其他义务。此外，还包括：不得拒绝急救处置；在履行告知义务时，应避免对患者产生不利后果；不得利用职务之便获取不正当利益等。具体内容主要有：①严格遵守规章制度和技术操作规程的义务。医师除了要遵守国家一般的法律法规之外，还应遵守医疗卫生管理法律、行政法规、部门规章和诊疗护理规范、常规。这是医师在诊疗服务中的最主要义务，同时也是医师应当履行的最基本职责。②如实记载和妥善保管病历的义务。病历不仅是解决医疗纠纷时认定责任有无的最直接、最有力的佐证，也是记载患者病史资料，进行医学观察、研究或提供医学证明的重要依据。《医疗事故处理条例》第八条规定，“医疗机构应当按照国务院卫生行政部门规定的要求，书写并妥善保管病历资料。因抢救急危患者，未能及时书写病历的，有关医务人员应当在抢救结束后 6 小时内据实补记，并加以注明。”③如实告知和说明的义务。根据我国有关法律法规的规定，医疗机构及其医务人员应当履行的告知义务包括但不限于：就诊医疗机构和医务人员基本情况和医学专长等；医院规章制度中与其利益有关的内容；医疗机构及其医务人员的诊断手段、诊断措施；所采用的治疗仪器和药品等措施的疗效、副作用；手术的成功率、方法、预期效果、手术过程中可能要承受的不适，以及手术的风险等。④抢救及转诊的义务。《医疗机构管理条例》第三十条规定：“医疗机构对危重病人应当立即抢救。对限于设备或者技术条件不能诊治的病人，应当及时转诊。”抢救急危患者，是医师执业时经常会遇到的情况，如果处理不好，会影响到对患者的救治，也可能造成医疗纠纷。⑤尊重和保护患者隐私的义务。《医疗机构从业人员行为规范》规定医疗机构从业人员应当“尊重患者的知情同意权和隐私权，为患者保守医疗秘密和健康隐私。”在医疗活动中，患者主动或被动地向医护人员介绍自己的病史、症状、体征、家庭史以及个人的习惯、嗜好等隐私和秘密，这些个人的隐私和秘密应当受到保护。《中华人民共和国民法典》第一千二百二十六条规定：“医疗机构及其医务人员应当对患者的隐私和个人信息保密。泄露患者的隐私和个人信息，或者未经患者同意公开其病历资料的，应当承担侵权责任。”但是，当保护患者的医疗秘密、隐私与维护患者的生命、他人或社会的利益发生矛盾的时候，应当以患者的

生命及大局利益为重，不得有损于他人、社会的利益。

（2）医师对社会的义务。医师对社会的义务具体包括：①开展预防保健的义务。主动宣传普及医药卫生知识，提高公众自我保健和预防疾病的能力；支持和参与卫生防疫和环境治理活动等。②提高人类生命质量的义务。积极开展医学遗传咨询和优生优育宣传教育及计划免疫工作，提高人类健康素质；开展关爱生命与安宁疗护的教育工作，促进社会的文明和进步。③参加社会现场急救的义务。对突发性的自然灾害以及工伤、车祸等意外事故，在需要时医师应立即奔赴现场，尽力抢救；在遇到传染病暴发或流行时，要服从组织的统一安排，积极投身防治现场和医疗第一线等。④发展医学科学事业的义务。医师应刻苦钻研新理论、新知识、新技术，具有献身和求实的精神，为促进医学科学的进步而努力。

一般来说，医师对患者和社会的义务是一致的，但也会存在矛盾和冲突。当二者产生矛盾时，医师必须首先进行多元利益的对比分析和优化选择，确保根本利益不受损害，合理兼顾多方利益；如若不顾一切满足患者会严重损害社会利益时，则要以社会利益为重，说服患者让渡个人利益维护社会利益，但同时应该最大限度降低对患者个人利益的损害，并给予适当补偿。

（二）患者的权利与义务

1. 患者的权利　在医疗活动中，患者权利主要包括法律权利和道德权利，法律权利是有关法律规定的患者权利，道德权利则是一种道义上的、以道德力量来维持的权利。道德权利的实现受医务人员的道德水平、医疗卫生和医学科学发展水平等诸多客观因素的制约，脱离和超出社会现实条件，是不可能得以普遍实现的。根据我国法律法规及相关道德规范，患者享有的权利主要如下。

（1）基本医疗权：世界卫生组织（WHO）明确提出，“健康是人的基本权利”，任何人都有权享有必要的、合理的、最基本的诊疗，以保障自身健康。根据《中华人民共和国宪法》第二十一条规定，保护人民健康的最根本途径就是确保公众患病时能够得到必要的、合理的、平等的、最基本的诊治。任何医疗机构或个人不得以任何理由推脱、阻碍这种基本权利的实现。《中华人民共和国刑事诉讼法》规定，即使对被判有期徒刑和拘役的罪犯，如果有严重疾病需要保外就医的，也可以暂予监外执行。这充分体现了对公民基本医疗权的尊重。

（2）知情同意权：所谓知情同意，是指在诊疗过程中，医务人员为患者作出诊断和治疗方案后，应当向患者提供包括诊断结论、治疗决策、病情预后以及诊治费用等方面的真实、充分的信息，尤其是诊疗方案的性质、作用、依据、损伤、风险以及不可预测的意外等情况，使患者或其家属经过深思熟虑自主地作出选择，并以相应的方式表达其接受或者拒绝此种诊疗方案的意愿和承诺。在得到患方明确承诺后，才可最终确定和实施拟定的诊治方案。知情同意权包括知情权和同意权两个方面。知情权是指患者有权了解和认识自己所患疾病，包括检查、诊断、治疗、处理及预后等方面的情况，并有权要求医师作出通俗易懂的解释；有权知道所有为其提供医疗服务的医务人员的身份、专业特长、医疗水平等；有权查看医疗费用，并要求医方逐项作出说明和解释；有权查阅医疗记录，知悉病历中的信息，并有权复印病历等。同意权是指患者及其家属有权接受或拒绝某项治疗方案及措施。但是，在患者履行拒绝治疗权利时，医务人员应注意以下问题：其一，当患者或其家属拒绝治疗时，应要求患者或其家属在病历中签字，以示其对自己的拒绝治疗负责。其二，对于急救患者，建议患者家属慎用拒绝权并做好解释说明工作。因为医师提出的急救措施往往直接关系到患者的生命安全。家属由于医疗知识所限，不容易作出准确判断。其三，当医务人员明知患者或其家属的拒绝对患者的诊治有较大损害时，应进行充分的告知和劝解，在劝解无效时，应报告有关的负责人同意后再决定具体的处理措施。

患者知情同意的理想状态是患者或其家属的完全知情并有效同意。完全知情是指患者获悉其作出承诺所必需的一切医学信息，即通过医方翔实的说明和介绍、对有关询问的必要回答和解释，患者全面了解诊治决策的利与弊，例如诊治的性质、作用、损伤、风险等。医方使患者知情的方式一般是口头的，必要时则辅以书面文字。有效同意是指患者在完全知情后，自主、自愿、理性地作出负责任的承诺。患者或者其家属作出有效同意的必要条件是：具备自主选择的自由，患者或其家属有权随时收

回、终止和要求改变其承诺；符合法定的民事责任年龄和民事行为能力。关系重大的知情同意还应遵循特定的程序，即签订书面协议、备案待查，必要时还需经过公证。此外，正确对待代理知情同意问题也是实现知情同意权的重要内容。代理知情同意的合理性和必要性取决于以下因素：①代理人受患者委托代为行使知情同意权；②特殊患者（婴幼儿患者、智力障碍患者、精神障碍患者等）或需要实施保护性医疗措施的患者，因本人不能行使或不宜行使知情同意权，而由其家属或其他适合的代理人代行此权；③代理人的意见能够真实反映患者的意志。在我国，法定代理人的顺序一般是具有完全民事行为能力的配偶、成年子女、父母、其他近亲属如兄弟姐妹、祖父母、外祖父母等。

（3）隐私保护权：医务人员的职业特点决定其有权了解患者与病症诊治有关的一些隐私，但是患者也有权维护自己的隐私不受侵害，对于医务人员已经了解的患者隐私，患者享有不被擅自公开的权利。

（4）医疗损害索赔权：在医疗活动中，因医疗机构及其医务人员违反医疗卫生管理法律、行政法规、部门规章和诊疗护理规范、常规，造成患者人身损害或财产损害时，患者及其家属有权提出赔偿要求，并追究有关人员或单位的法律责任。《中华人民共和国民法典》第一千二百一十八条规定："患者在诊疗活动中受到损害，医疗机构或者其医务人员有过错的，由医疗机构承担赔偿责任。"

（5）医疗监督权：在就医过程中，患者及其家属有权对医疗活动的合理性、公正性等进行监督；有权检举、控告侵害患者权益的医疗机构及其工作人员的违法失职行为；有权对保护患者权益方面的工作提出批评、咨询和建议等。

（6）医疗选择权：该项权利是患者自主权的延伸，也是知情同意权的具体体现之一。不同患者的医疗服务需求不同，医疗服务应满足患者的多样化需求，尊重患者自主择医的权利，包括自主选择医院及医师、选择门诊或急诊治疗、选择家庭病床、选择治疗方式、选择转院等。

（7）社会免责权：健康是每个人的追求，患病是每个人都不愿意发生的，疾病或多或少地会影响患者的正常生理功能或心理状态，从而使其承担社会责任和义务的能力有所减弱。因此，患者在获得医疗机构的证明文书后，有权依据病情的性质、程度和对功能的影响情况，暂时或长期、主动或被动地免除相应的社会义务，免除或减轻一定的社会责任，有权获得休息和康复，并得到社会、家庭或他人的支持和谅解。

（8）照顾与探视权：在诊疗过程中，患者有权获得医务人员、护工、家属、亲友等人员的照顾，有权得到家属、同事及亲友的探视。医院有义务创造条件，维护和满足患者的这种权利。但是，这种权利要以患者及其家属尊重医务人员和遵守医疗机构规章制度为前提，尤其是在患者家属探视时，不能影响医疗机构的正常工作秩序，要按照医疗机构规定的时间、地点等探视。

2. 患者的义务　医患关系的维系也需要患方践行自身的义务。在医疗过程中，如果忽视了患方的配合与合作，同样不利于医患关系的和谐与维系。根据我国法律法规及有关道德规范，在医疗活动中，患者应履行的主要义务如下。

（1）保持和增进健康的义务。健康不仅是每个人的权利，也是每个人的义务，它直接关涉个人、家庭的幸福，也关涉人类种族和社会的发展。每个人都有义务保持或恢复自身健康，维护良好的健康环境，并为自己、他人和社会作出健康贡献。《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》规定，公民是自己健康的第一责任人。因此，每个人都有义务树立和践行对自己健康负责的健康管理理念，主动学习健康知识，提高健康素养，加强健康管理。倡导家庭成员相互关爱，形成符合自身和家庭特点的健康生活方式。

（2）配合诊疗的义务。在医疗实践中，要想取得对疾病治疗的满意效果，医师正确的诊断和治疗固然重要，但患者及其家属的密切配合也必不可少。因此，为了早日恢复健康，患者有义务配合医方的诊疗，如在医疗过程中，应如实陈述病史、病情、按医嘱进行各项检查并按医师的指示接受治疗等。

（3）遵守医院规章制度，尊重医务人员及其劳动的义务。为发挥医院职能，提高医疗质量和工作效率，保障正常工作秩序，患者必须自觉遵守医疗卫生机构各种规章制度，尊重医务人员的辛勤劳动，

尊重医务人员的人格尊严，如住院患者不能随意离开医院，患者应该遵循医嘱等。

（4）给付医疗费用的义务。医疗费用包括诊疗、处方、检验、药品、手术、处置、住院等各种费用。从某种意义上说，医疗服务是一种特殊的商品，它并不以治疗是否有效或是否成功作为收取费用的前提，即使治疗失败，只要医务人员付出了劳动，并且尽职尽责不存在过错，在医保承担相应费用外，患者及其家属就应交纳应该承担的医疗费用，不得拒绝交费。但是，对于急危重症患者，医务人员具有强制诊疗义务，不得因患者不能及时交纳费用而拒绝治疗。另外，如果医务人员在诊疗时未尽到告知说明的义务，患者有权拒绝交纳未告知事项所产生的相关费用。

医患双方的权利和义务是多方面的，法律权利义务必然是道德权利义务，但道德权利与法律权利又有所不同。一个人尽到了自己的义务，就可以依法行使一定的权利。但一个人履行道德义务并不以享有权利为前提，不能认为没有权利就放弃责任。如果把得到某种权利作为尽义务的前提，就不是真正的履行道德义务。

三、和谐医患关系的构建

（一）尊重与理解

医患之间的彼此尊重，相互理解不仅是医患交往的基础，也是化解矛盾、消除隔阂、达成和谐状态的基本原则。医疗活动作为一种人道的服务，应将人道主义精神根植于医务工作者的内心深处，以内心对患者的尊重为基础。如果没有这种对人尊重的内在精神，只是表面上或口头上的迎合，很难让人产生真正被尊重的感觉。尊重是相互的，一个人要想得到他人的尊重，必须首先自尊，一个人只有自尊才能产生提高自身修养的需要。相互尊重能够给人心理以强化作用，使交往双方因对方对自己的肯定行为而增进其与对方交往的需要。在医患交往中，只有医务人员尊重患者，患者才会信任医师。而且，对患者的尊重，还包括对其平等权利的认同。当然，患者也必须尊重医务人员的人格和劳动，必须自尊、自爱，履行自己的健康道德义务和承担相应责任，积极配合医师诊治。

理解也是加强医患沟通，协调医患关系的基础。医患双方在交往中相互传递的信息是多种多样、十分复杂的。而医患双方的内心活动又受复杂外界的影响，使动机、行为、结果常常处于矛盾的状态中。在这样一种情况下建立和发展医患关系，理解显得格外重要。医患关系的建立源于彼此利益的需要，患者需要医者的技术帮助自己康复，医者需要通过患者的配合实现自身的价值。但是，医患关系如果仅仅靠利益来维持是难以保持和谐的，和谐的医患关系需要广泛的理解和认同。尤其在彼此出现分歧、发生冲突时，更需要双方的理解，需要双方能够站在对方的立场和态度去思考问题。孔子说："己所不欲，勿施于人。"这说明了换位思考的重要性。信任和理解是医患合作的必要条件，疾病越复杂、病情越严重、诊治时间越长，就越需要双方的信任和理解。

（二）求同与存异

医患交往需要遵循求大同存小异、彼此相容的原则。事实上，差异性是人际交往的前提，如果两个人之间没有差异，知识、技能、立场、观点、生活习惯等各方面完全同一，那么他们之间就很难在交往中得到自我需要的满足。人与人之间只有存在差异，才有互补，只有互补才能在交往中得到自我需要的满足。医患之间正是存在知识、能力、需要等方面的差异，才有交往的必要。因此，在医患关系的调适中，我们首先应该正视差异，承认差异的存在。强调和谐，并不是要消除差异，而是要达到双方利益的一致，这种一致并不是绝对的统一。在医患交往中，双方应该看到根本目的的高度一致性，这也是医患关系与一般人际关系的根本区别。医方不应因患方提出了与自己不同的意见、想法而加以排斥，患方也不应因医方没有完全满足自己的需要而妄加指责。即使是在双方尖锐对立的观点中也应该寻找接近点，允许彼此保留相异点，这样双方的交往才能继续下去。否则，去同持异，以一方压服另一方，双方的交往就可能中断。而此时，双方所需要的就是宽容。

《省心录》云："和以处众，宽以接下，恕以待人，君子人也。"宽容是中华民族在处理人际关系上的一种美德。医务人员应以宽容的胸怀满足患者的利益需求，以宽厚的精神去调节医患关系，这是医务

人员的职业要求。患者由于身受病痛的折磨，在心理、行为等方面可能表现出异常之举，甚至提出一些无礼要求，这就需要医务人员不能像对待常人那样去要求患者。当然，宽容不是懦弱。医务人员对患者的宽容是其人格高尚的表现，是崇高敬业精神的展示，是对处于病痛折磨中患者的种种病态表现的包容，是不苛求患者在人际交往礼节方面像常人一样周全，不苛责患者言词举动的异样。宽容是一个人开朗、豁达，有气量、有自信心、有坚定意志、有远大目标和理想，为了团结人，可以减少不必要的争执，并不是怕事，也不是没有力量去反击。心理学证明，自信心越强的人，宽容度就越高。毋庸置疑，对患者的宽容和对患者无理取闹现象的纵容是有本质区别的。

在医患交往中，要做到宽容对方，需注意以下两点：其一，有理谦让。即在医患交往中应有理、有利、有节。无理不让人，是无理取闹，其结果是引起矛盾；有理不让人，可谓得理不饶人，结果是激化矛盾。可见，二者的结果是一样的，即恶化医患关系。所以，在医患交往中，无理者应该道歉认错，有理者也应该谦让，这样即使是本来较为紧张的医患关系也会得到逐步缓和。其二，严于律己、宽以待人。唐代文学家韩愈说："古之君子，其责己也重以周，其待人也轻以约。"这句话的意思是，古代有修养的人，待人很宽厚，要求自己却十分严格而全面。在医患交往中，必须大力提倡严于律己、宽以待人的风尚，这是构建和谐医患关系的重要途径。

（三）诚实与守信

诚实与守信即"诚信"，是中华民族的传统美德，其含义是无欺、守诺、践约。它要求做到言不背实、口不违心、心口统一、言行一致、始终如一。我国传统文化历来倡导"一诺千金""言必信，行必果"。古人强调"与朋友交而不信乎？"这是重诚信的表现。北京某老字号制药企业有两句用以自律的古训："炮制虽繁必不敢省人工，品味虽贵必不敢减物力"，也就是以不偷工、不减料，诚招天下客。

对医方而言，诚信是立业之本，只有对患方诚信才能赢得更多的患者，只有得到患者的支持才能有事业的发展。当今，各行各业都免不了竞争。诚实是最好的竞争手段，守信是最吸引人的品德。"诚信"一方面要求医院应竭诚为患者服务，要做到"以患者为中心"，另一方面要求医院应"承而有信"，而不能"诺而不承""承而不力"。承诺必须切合实际，而不能假、大、空，否则就不能取信于民。

（四）以德与依法

中国传统交往理念是重情轻法，人情至上，从而产生了各种行为标准和道德规范。做人要有情有义，做事要符合"人之常情"。这种传统的交往原则，有其精华之处。但"人之常情"却是个十分模糊，没有确切定义的标准。每个人站在自己的立场，有自己认为充足的情由。"公说公有理，婆说婆有理"，而这"理"又都是"人之常情"，常常无法判断出对错。医患关系不同于一般的人际关系，它具有鲜明的法律属性，是一种特殊的法律关系。因此，构建和谐的医患关系不仅要凭借道德规范，还必须依照有关法律法规行事，依照法律合理地享有自己的权利，履行自己的义务，用法律来处理矛盾和分歧。

然而，法律的约束力总有其"控制不到"的领域。例如，我国卫生领域相关法律除对某些传染病和特殊疾病（如躁狂型精神障碍者等）进行了明确的规定外，对于大多数患者的就医行为主要还是运用道德进行规范，需要其自觉调整不利于健康的行为，形成健康的生活方式，消除疾病，恢复健康。因此，在处理医疗关系的过程中，既要充分利用法律的手段，又要充分利用道德的手段。只有将二者有机地结合起来，才能构建和谐的医患关系。

第二节 | 医际关系伦理

医际关系作为医疗活动中医务人员之间的业缘关系，具有主导性与平等性的统一、协作性与竞争性的统一、差异性与同一性的统一等特点。医护关系是医际关系中最主要的表现形式，在不同的救治情形和条件下，应遵循不同的医护关系模式。和谐医际关系的构建，需要医疗卫生机构各类从业人员的共同努力。

一、医际关系的含义及模式

（一）医际关系的含义

所谓医际关系，是指在医疗活动中不同医务人员之间所形成的业缘关系，包括医师与医师之间的关系、医师与护士之间的关系、医师与医（药）技人员之间，以及护士与护士之间、护士与医（药）技人员之间的关系等。医务人员是医疗活动的中坚力量，是医疗机构的主体，其技术水平、道德修养、沟通能力等综合素质的高低，直接决定着医疗机构的服务质量及服务水平，关涉医疗机构的对外形象和声誉，影响着医患关系的和谐。

医务人员作为特殊的具有高度专业性的群体，他们之间的关系与一般的人际关系不完全相同，有着其特殊的规定性，这主要表现在以下方面。

1. 主导性与平等性的统一　在医疗活动中，由于专业分工和职责的要求，医师对医疗方案的制订具有最终的决定权，他们有权根据患者病情的需要决定检查项目、药品配伍、治疗手段等，其他医务人员甚至患者本人在实施中尽管可以提出自己的看法或意见，但一般不得擅自修改或变更，即使需要修改或变更也应征求经治医师的同意，这是捍卫医师的自主诊治权及其权威性所必须的，也是要求医师为其诊治方案负责的前提。但是，这并不是说护士、医（药）技人员只能处于服从的、被支配的地位。事实上，如果其他医务人员发现医师的诊治方案中存在不适当的问题，有权建议或要求其进行修改或变更。医师的主导作用主要是由其执业特点、岗位职责决定的，更多的是一种责任而不是权利。不同的医务人员之间并不存在地位的高低、价值的大小，或支配与服从的关系。现实的医疗活动需要各个学科之间、不同的专业人员之间密切配合，相互支持，优势互补，只有这样才能发挥医疗团队的整体合力。因此，在医疗活动中医师的主导作用离不开其他医务人员的平等合作，主导性与平等性是完全统一的。

2. 协作性与竞争性的统一　在现代医学高度分化与高度综合的背景下，患者的诊治往往需要诸多科室的医务人员共同参与和配合，如一台手术，除了手术医师，还有护士、麻醉医师、检验医师、药剂师等多方人员共同努力才能完成，缺少了其中的任何一方，手术都难以成功实施。没有其他医务人员的配合，再高明的医师也将一事无成。但是，医疗活动中的这种协作又是以竞争为动力的。现代医学技术的飞速发展，要求所有的医务人员都不能满足于已有的知识和技能，只有在比、学、赶、帮、超的人际关系环境中，才能保持知识和技术上的先进性，否则就会跟不上与他人协作的步伐，就会被时代所淘汰。竞争的根本目的是一致的，均在于提高医疗护理质量、技术水平、科研能力，并最终为患者健康服务。当然，在竞争中也可能产生不正当的竞争现象，这无论对于医务人员之间的协作，还是对于患者都是不利的，需要正确的引导和教育。

3. 差异性与同一性的统一　在医疗活动中，医务人员之间由于专业的不同、分工的不同，有着各自不同的工作内容和任务，每一个医务人员都应当严格按照其执业范围、执业内容开展执业活动，而不能相互替代。但是，他们之间又有着一个共同的工作目标，每一位医务人员都应以救死扶伤、防病治病为己任，为满足患者的健康需要而工作。就此而言，他们又是完全同一的，不存在根本的利益分歧，只有在确保患者利益的前提下，才能实现各自的利益追求。

（二）医护关系的主要模式

在医际关系中，最主要的关系是医师与护士之间的关系即医护关系。在不同的历史时期，受医学发展水平及人们的医学认识能力、社会经济条件等因素的影响，医护关系存在着不同的模式。

1. 主导-从属型　在医学史上，早期的护理工作并不具有医疗的性质，护士主要承担着为患者提供生活上的照料的职责。在近代医学取得进展后，护士作为医务人员的组成部分，承担着部分的治疗处置工作，此时护理的地位是从属于医疗的，护士的工作只是机械地执行医嘱，护士并不直接对患者负责，而仅对医师负责。医护关系是一种支配与被支配的关系。所谓“功能制护理”是指以疾病为中心，让护理工作依附于医疗，护士只是简单地执行医嘱，机械地完成分工任务，对患者的病情、疗效、心

理状态缺乏全面系统的了解，影响了护理工作的协调性与连续性，经常产生脱节现象。

2. 并列-互补型　随着生物-心理-社会医学模式在临床的影响日益扩大，以及系统论等理论的发展，护理学作为一门独立的学科，从单纯执行医嘱的疾病护理，发展到以人的健康为中心的整体护理，因此医护关系从主导-从属型转变为并列-互补型。所谓并列，即护理与医疗两个要素之间无主次、从属之分，二者在诊治疾病的过程中发挥着同等重要的作用。所谓互补，即医护之间互相协作、互为补充。虽然护士与医师的工作重点与技术手段不同，但他们面对的是共同的患者，其医学的目的是相同的。在这种模式中，医护双方要相互尊重，共同维护患者的利益。护士应严格认真地执行医嘱，如果发现问题，及时与医师沟通、协商，以尽快解决问题；作为医师应尊重护士的劳动与意见，协助护士做好患者的心理疏导工作。医疗与护理两者密不可分，没有医师的诊断治疗，护理工作就无从谈起；没有护士的整体护理工作，医师的诊断治疗也无法落实。

3. 相对独立型　现代整体护理模式要求护士对患者进行评估，作出护理决策，制订护理计划，实施护理措施，而绝非单纯地执行医嘱。为保持护理工作的连续性，责任护士有权开出护嘱，让协作护士遵照执行。协作护士有权对责任护士制订的护理计划和护嘱提出修改意见。在这种模式中，护士在执行医嘱及完成整体护理活动中，具有相对独立性，就护理活动而言占有主导地位。而医师的主导地位主要表现在疾病的诊断和治疗中。

以上不同的医护关系模式各有其特点，不能简单地认为一种模式就一定优于另一种模式。在临床医疗和护理工作中，面对不同的患者、不同的救治情形和条件，各有其适用的价值。

二、和谐医际关系的构建

和谐医际关系的构建，不仅需要医疗卫生机构营造和谐的医院文化，形成积极向上的共同愿景，还需要医、护、技各类医务人员的共同努力和精心经营，恪守处理医际关系的基本伦理要求。

（一）患者至上，维护公益

《黄帝内经》指出："天覆地载，万物悉备，莫贵于人。"坚持患者至上，维护患者的生命和健康，捍卫患者的正当权益，这是所有医务人员的共同义务和天职，也是协调医务人员之间关系的思想基础和道德要求。因此，医务人员在医疗卫生保健活动中，对于维护患者利益的言行要予以肯定、支持和帮助，而对于损害患者利益的言行要敢于抵制和提出批评。当医务人员之间出现意见分歧时，首先从患者的角度思考问题，以是否有利于患者的生命健康和医疗服务质量的提高为标准，要撇开科室、个人之间的偏见和恩怨，共同维护患者的利益。但是，在医疗卫生保健活动中，有时患者个人的利益与社会公益会发生矛盾或冲突，如稀有卫生资源的分配、对传染病患者（甚至疑似传染病患者及与传染病患者密切接触者）实施隔离等，此时医务人员应向患者或家属耐心解释或说明，希望他们服从社会公益，甚至行使特殊干涉的权利，同时应使患者的利益损失降低到最低限度。

（二）彼此平等，互相尊重

在维护患者利益和社会公益的共同目标下，虽然医务人员之间分工不同、有职称之别及领导与被领导之分，但是在人格尊严、身份地位上没有高低贵贱之分，彼此是平等的，不应把领导身份、技术专长作为骄傲的资本，医务人员之间只有平等相待才能形成相互的并列互补关系。在医疗活动中，每一个人都有被尊重的权利，也有尊重他人的义务，医务人员之间应当把同行视为朋友、伙伴，相互尊重，而不应当相互诋毁或猜忌。医务人员之间只有相互尊重，才能得到患者的尊重，密切合作。反之，不能正确对待自己，不尊重他人的劳动，就会引发诸如嫉妒他人，诋毁同行，搬弄是非，抬高自己等背离医德的行为，其结果必然是使医务人员之间的关系遭到破坏。同时，医务人员之间还应当拥有平等的发展机会，医院、科室领导只有为医务人员提供均等的机会才有利于调动大家的积极性。但是，平等绝不是平均主义的"大锅饭"，而是公平、公正，多劳多得，按劳取酬，并应在同一起跑线上奖励和晋升那些作出优异成绩的医务人员。在平等的基础上，医务人员还要互相尊重，包括尊重他人的人格、才能、劳动和意见，保护他人隐私等。当然，强调医务人员之间互相尊重，绝不是相互吹捧，也不是搞一

团和气，否则就可能形成庸俗的医际关系。

（三）彼此独立，互相支持

在现代医学科技背景下，任何人都不可能精通所有领域、所有学科，即使在同一门学科内也总有未知的知识和问题，面对浩瀚的知识海洋和飞速发展的现代医学科技，任何人都没有骄傲的资本。在临床工作中，医务人员之间不同的专业岗位使其工作具有相对的独立性，彼此都要承认对方工作的专业性和重要性，不要以自我为中心而认为别的学科、专业都依附于自己的学科、专业而存在。同时，在工作的相互联系中，要尽力为对方提供方便、支持和帮助，当然这种支持和帮助不能理解为无原则、讲情面，以及相互间的包庇错误和医疗差错事故等。总之，医务人员只有坚持彼此独立、互相支持才能建立良好的关系，才有利于共同目标的实现。

（四）彼此信任，互相协作

医务人员之间的彼此信任是互相协作的基础和前提。医务人员之间要达到彼此信任，首先要立足于本职工作，在自己的专业岗位上发挥积极性、主动性和创造性，以自己工作的可靠性和优异成绩去赢得其他医务人员的信任。同时，自己也要对其他医务人员的能力、品格等有正确评价，评价过低难以产生信任，评价过高而产生的信任也难以持久。其次，医务人员要达到彼此信任还必须加强沟通交流，将容易引起不信任的因素及时化解，而不要私下议论和张扬。唐代孙思邈强调从医之人不得“议论人物，炫耀声名，訾毁诸医，自矜己德。偶然治瘥一病，则昂头戴面，而有自许之貌，谓天下无双，此医人之膏肓也。”在彼此信任的基础上，医务人员才能产生协作的愿望和达成富有成效的合作。

医疗活动是一项群体性活动，需要不同医务人员之间的通力合作，每一个医务人员都应在为患者服务的理念下，互相支持，密切配合，勇挑重担，主动为同行分忧解难，在认真履行自己的职责的同时，分工协作，互相帮助。力避互不通气、相互推诿、互相拆台、以邻为壑、各自为政的错误倾向。特别是当同行出现差错等问题时，要从患者利益和友爱精神出发，既实事求是、客观公正地给予批评指正，更要给予善意的帮助和关心，绝不能幸灾乐祸甚至落井下石。医务人员之间要互相谅解、服从大局，友好协调，化解矛盾，决不能因为同事之间的恩怨或纠纷，而影响工作。医务人员之间的协作是医疗、教学、科研的客观需要，医疗只有协作才能提高服务质量，科研只有协作才能产出高水平的成果，教学只有协作才能培养高素质的人才。但是，医务人员之间的协作是相互的、互利的，要采取积极主动的态度，这样才能达到实质上的协作而不是表面上、形式上的协作，医务人员之间才能建立良好的关系。

（五）互相学习，共同提高

临床实践不仅需要医学知识，更需要临床经验，需要知识与经验的结合。医务人员之间要取人之长，补己之短，相互学习，共同提高。既要虚心学习他人的优点和长处，也要向他人无私地传授自己的业务专长和经验，做到既不故步自封，自以为是，也不垄断技术，压制他人。明代医家陈实功强调：“凡乡井同道之士，不可生轻侮傲慢之心，切要谦和谨慎，年尊者恭敬之，有学者师事之，骄傲者逊让之，不及者荐拔之。”互相学习，可以促进医务人员的博学多识，有利于开展综合性研究和疑难病的攻关；互相学习和组合，还可以产生合力而实现技术互补。总之，医务人员之间互相学习可以达到共同提高，但共同提高绝不是不允许“冒尖”，而是鼓励发挥各自的技术特长、专业优势，为维护和促进人类的健康作出更大的贡献。

（六）求同存异，公平竞争

在医疗活动和医学科研中，不同医务人员之间可能在思想观念、工作方法、学术观点、医疗方案等方面存在或多或少的分歧，只要这种分歧不影响对患者的正确诊治，不影响正常工作的开展，便无伤大雅。医务人员之间要秉承求同存异的理念，以百花齐放、百家争鸣的科学作风，尊重他人的学术见解和学术自由，不能搞“一言堂”、唯我独尊或学术霸权，要允许不同声音的存在，包容反对的意见。也只有在这种包容、协作中竞争，才能避免针锋相对、互相攻击的竞争局面，把竞争当作动力和激励，真正建立团结友善的工作环境。

三、协调好医际关系的意义

正确处理医际关系，不仅是当代医学发展的客观需要，也有利于发挥医疗卫生保健机构的整体效应，有利于医务人员成才和建立良好的医患关系。

（一）当代医学发展的客观需要

一个人的精力和寿命是有限的，任何人都不可能精通所有专业的知识。为了适应这种状况，一方面医务人员要尽力“以博促专”，注重自己专业知识与其他自然科学的广泛结合以及与社会科学相互渗透，同时加强专业间的学术交流。另一方面不同专业的医务人员之间必须加强协作和互相配合，否则，会影响正常诊疗活动的进行和医疗质量的提高。这种协作和配合需要靠医务人员的自觉和建立在共同医学道德基础上的良好医际关系。

（二）有利于整体效应的发挥

医疗卫生保健机构作为一个有机整体，其功能的发挥与每一个医务人员的积极性、主动性和创造性，以及心理状况、工作兴趣等密切相关，只有在和谐的人际关系状态下，其功能才能得以充分发挥。在和谐的人际关系状态下，再通过群体之间的互补、互助和配合，使每个人的潜力得以充分展现，从而使群体产生一种超乎个体能力简单相加的集体力，这种集体力具有任何个体所不具备的性质和功能，是一种质的飞跃。而且，这种飞跃是在医疗卫生保健机构不增加投入和人员等硬件的条件下进行的，它能够促进医疗卫生保健机构在医疗、教学、科研、预防、管理等方面的整体效应的提高。相反，医务人员之间关系紧张、松散就会矛盾丛生，是非不断，协作受阻，这样不但不会产生超乎个体能力总和的集体力，反而会增加内耗，每个医务人员的积极性也因感到压抑而调动不起来，其个人的潜力也会发挥受限。因此，要发挥医疗卫生保健单位的整体效应，提高各项工作的效益，正确处理医务人员之间的关系是至关重要的。

（三）有利于医务人员的成长

医学人才的成长依赖于社会的宏观条件、单位的微观条件以及个人的主观条件。在社会的宏观和单位的微观条件中，人际关系是很重要的，尤其是单位内的医务人员之间的关系是医学人才成长的重要环境。很多真实案例说明，良好的医际关系是自己在同行中保持主动和获得信任、支持、帮助的前提，它有助于事业的进步、心理健康和才能的发挥，由此带来的积极作用成为医学人才健康成长的良好土壤。不可否认，也有少量医务人员以自我为中心，对个人得失斤斤计较，使自己与其他医务人员之间关系不够和谐，由此带来的消极作用制约了个人技术、才能的发挥，在成长的道路上设置了一个个障碍，最终可能是“英雄”无用武之地。因此，在一个整体中，不仅每个医务人员都应经常反省自己的人际关系，从组织上来说还要加强协调并促进人才流动，使医务人员能够健康成长。

（四）有利于和谐医患关系的构建

在医疗卫生保健实践过程中，医务人员之间的相互联系和交往是以患者为中心进行的。医务人员之间的相互支持和密切协作，有利于患者疾病的诊治和康复，因此也有助于医患之间和谐关系的建立。相反，医务人员之间发生矛盾，出现冲突，彼此之间联系会存在障碍，行动不能很好协调，那么正常的医疗卫生保健活动将受到影响，甚至难以进行，比如后勤氧气供应不及时，手术难以进行；边缘性或复合性疾病各科相互推诿，就会延误患者疾病的诊治时机等。其结果是危及患者的生命健康，引起医患之间的矛盾或纠纷，从而恶化医患关系。所以，良好的医际关系有助于融洽医患关系的建立，不良的医际关系是引起医患矛盾和纠纷的根源之一。

第三节 | 医社关系伦理

医社关系作为医学及其从业人员与社会及公众之间的关系，受多种因素所影响。尤其在发生医患纠纷时，不仅要充分考虑患方的感受，还应充分关注公众、媒体等社会舆论的影响，要认真、客观地

面对媒体，公正地处理医患矛盾，力争得到公众、媒体的理解和支持。

一、医社关系的含义

所谓医社关系，是指医学及其从业人员与社会及公众之间的相互作用，是在社会发展过程中，出于对人类生命健康的维护，在医学从业人员、医疗卫生单位乃至整个医学界与社会公众、社区乃至政府之间发生的，具有道德意义的社会关系。包括以下两个层面的关系。

首先，医学与社会及公众之间的关系。一方面，医学的发展离不开社会的支持，社会及公众生命健康的需要是医学发展的动力，经济基础是医学发展的物质条件。医学研究和实践需要以人类的生命健康为中心，不断地吸纳社会各方面的意见和建议；医学研究和实践只有不断地与社会互动，才能更好地服务社会。医学科研只有以影响人类生命健康的问题为重点，不断揭示生命健康的本质、规律和理论，关注威胁人类生命健康的疾病问题，才能体现其价值和功能。而且，医学研究离不开科技的支撑，医学发展是科技不断进步的结果。在医疗实践中，医务人员只有通过不断地倾听患者的意见和反馈，才能更好地为患者提供优质的医疗服务。另一方面，社会的进步也需要医学的创新和发展，医学的创新和发展将促进人类社会的进步。医学是保障人民健康的重要手段，公众作为重要的生产力要素，其生命健康的维持离不开医学，需要医学为疾病的防治、患者的康复提供理论和技术支撑。因此，医学的发展和进步需要社会的支持和公众的理解，而社会的发展和进步也离不开医学科技的支撑，只有医学与社会良性互动，才能促进社会的健康和繁荣。但是，由于医学科技是负载价值的，其创新发展和应用需要法律和伦理的规制，否则也可能给社会及公众带来负面的作用。1997 年英国的科学杂志《自然》报道了克隆羊多利（Dolly）出生的消息后，欧洲各国及美国政府立即开展了对克隆技术的伦理学讨论。时任美国总统克林顿要求国家生命伦理咨询委员会进行一项紧急调查，以弄清该技术对伦理和法律的潜在影响。同时，禁止联邦政府向克隆人研究项目提供基金支持。这表明，医学的进步与社会发展是息息相关的。但是，医学对人类和社会的影响最终是通过人，尤其是医学从业者的作用实现的，在医疗实践中医务人员是医学活动的主体，医学与社会的关系主要通过医学从业人员与社会的关系呈现出来。

其次，医学从业人员尤其是医务人员与社会、公众的关系。一方面，医学从业人员作为社会成员的重要群体之一，其赖以生存、生活和发展的物质基础来源于社会大众，是由社会大众创造的，其自身价值的实现离不开社会大众的理解和支持，也只有在为公众服务的过程中才能实现自身的价值。医学必须深入人们的社会生活中去，从生活的方方面面为人们的健康服务，而不是仅仅局限在医院这个有限的场所中。医师也必须开阔自己的视野，更多地着眼于对有害健康的因素的研究，而不是只执着于对恢复健康的方法的探求。另一方面，医学从业人员作为专业技术人员，是医学知识的传播者和医学技术服务的提供者，社会大众生命健康的维护需要医学从业人员的知识和技术支撑，人类生命质量的提升、疾病的防治和康复离不开医学从业人员的努力和奋斗。就此而言，医学从业人员只有与社会大众保持和谐、融洽的人际关系，才能更好地彼此促进和发展。

此外，医社关系还表现在医学从业人员在为患者提供服务的同时，应考虑到患者家属、社会的利益。传统的美德论、义务论要求医务人员要不惜一切代价地救治患者，即使有一分的希望也要尽百分之百的努力，这是医务人员的神圣使命。但是，随着人类社会的进步和高新医疗技术的应用，相对于人们的卫生健康实际需求，卫生资源日显不足。人们逐渐认识到不仅要重视生命的神圣，还要重视生命的质量和价值，并提出了许多提高生命质量和生命价值的伦理问题，例如先天性残疾并存在严重缺陷的新生儿是否有治疗的意义？某些不可逆转的濒死患者是否应不惜代价救治？面对这一系列的问题，如果医务人员仍囿于传统的医学人道主义，把自己的责任定位于救治一位普通的患者，势必影响公众的社会利益及后代人乃至全人类的长远利益。因此，在当代医学已发展成为庞大的社会事业的情况下，医务人员应当改变以往医师与患者之间的线性关系，在对某一位患者负责的同时，也要考虑其他患者及公众的利益，既要承担起对患者的责任，也要负起对社会的责任，既要重视医疗行为的动

机，也要重视医疗行为的效果，要将生命神圣、生命质量和生命价值有机地统一起来，而不能完全舍弃与患者相关者的正当利益。医学从业人员的天地绝不应仅仅在病房里，应当走进社区，走进家庭，与社会建立更加密切的关系。

医社关系的和谐受多种因素的影响，其中媒体的宣传报道至关重要。对医学从业人员正面的、积极的报道有利于树立医者的良好形象，促进医社关系的和谐，负面的、消极的报道则可能影响社会大众对医者形象的认同和评价，甚至不利于和谐医社关系的构建。这就需要医学从业人员增强自律意识，杜绝行业不正之风，在学好专业知识和医疗技能的同时，还要学会处理与社会大众包括媒体之间的关系，将积极向上的姿态展示给公众和媒体。尤其在发生医患纠纷时，要认真、客观地面对媒体，公正地处理医患矛盾，以得到媒体的理解和支持。

二、医学职能的社会化

随着社会经济的发展，物质生活水平的提高和人们预防保健意识的逐渐增强，人们已不满足于丰衣足食，开始注重精神享受、营养保健。人们追求的目标已不仅是单纯的躯体健康，健康的心理、和谐的社会关系及延长健康预期寿命越来越受到重视。医学已从传统的以治疗为中心转向以健康为中心，这将使医学的服务对象不再限于有病的人，而是包括患者、亚健康者及健康人在内的一切人类个体和群体，医学知识将渗透到社会生活的各个方面，每个人都有权利和需要得到基本的医疗卫生服务。而且，医学的服务职能将更加广泛，如医疗美容、减重等都将成为医学的职能，甚至诸多的社会偏离行为如酗酒、暴力等也可能被解释为医学问题，用遗传、基因的概念去分析。正如《健康社会学》一书的作者沃林斯基（Wolinsky）所指出的："医学正在成为一个主要的社会控制机构。医学正在把法律和宗教的传统机构撇在一边，……正在变成新的真理宝库，……医学成为权威机构这件事，不是靠医师手中所掌握的或能施加影响的政治权力，而是靠把大部分日常生活'医学化'，靠把医学和'健康''有病'的标签贴在人类生活中日益增长的部分而完成的。"社会生活的医学化趋势必然导致医学服务对象的增多，医患关系将不再专指医务人员与患者之间的关系，一切具有医疗卫生需求者或可能被认为具有医学问题者与医方所发生的人际关系都可称为医患关系。由此，将改变传统的医患关系模式，推动医患关系向多元发展。尤其在预防性医疗服务领域，具有医疗服务需求者不会像处于疾病治疗状态时的患者一样对医师具有高度的依赖性。相反，由于他们并非真实的患者，他们就没有明确的义务感和求医心态去遵守医师推荐的方案。同时，由于预防性医疗服务的目标通常针对的是社会群体，并不具体到某个人。因此，在大部分预防性医疗服务情形中，几乎不存在患者对预防性医疗服务提供者的技术性依赖，这样医务人员必须极大地依靠说服力来进行工作，从而改变了传统医患关系中医者主动-患者被动的人际关系。

三、医社关系的理想模式

和谐的医社关系不仅是社会的需要，更是医学本身的需要。医学的目的是促进健康，减少病痛，提高人类生命质量，就此而言，医学是最有温度的科学，以人的生命和健康为中心是医学的本质要求，人文关怀是医学的内在价值。因此，医学的目的和职能，与社会及公众的利益诉求是完全一致的，提高生命质量，促进健康幸福，维持生命的延续和繁衍是人类一切活动的终极目标。而这一目标的实现，就需要医学从业人员对医学专业精神的坚守和追求，通过医学从业人员的艰辛探索，不断提高医学科技水平，规范医学科研行为，避免医学科技的负面效应和滥用，切实维护医学的纯洁和神圣，也只有这样才能使医学造福于人类。但是，由于科技发展水平的限制，医学科技探索、医疗卫生服务具有一定的不确定性和风险性，面对异常复杂的疾病，医学科技并非万能，尤其临床诊疗与经验密不可分，带有经验性和局限性，目前尚有诸多无法解决和治愈的疾病。这就需要公众理解医学、支持医学的研究和发展，自觉为医学科技的创新提供力所能及的贡献，包括作为受试者参与生命科学和医学研究、积极配合疾病的防控和流行病学调查，自愿无偿捐献血液、器官及遗体，在诊疗效果不理想时保持客

观、冷静的态度，科学、理性地对待而不求全责备等。

总之，理想的医社关系应当是公众理解医学、尊重医学从业人员的劳动和尊严、支持医学科技的研究和发展，以及医学从业人员坚守专业精神、捍卫医疗卫生行业的荣誉与崇高、积极促进医学健康发展的良性互动，是能够满足人们期望的、和谐的医社关系。

思考题

1. 为什么说医务人员不能按照处理一般人际关系的方式处理医患关系？
2. 如何理解和谐医际关系的构建需要医患双方与社会各界的共同努力？
3. 学习和理解医社关系对于医学生的培养有何现实意义？

（刘俊荣）

第七章 公共卫生与疾病防控伦理


本章数字资源

公共卫生与疾病防控伦理主要关注和研究政府、公共卫生机构以及医疗机构等在预防疾病和损伤、促进人群健康等公共卫生与疾病防控方面的行为规范，侧重社会的整体价值和群体健康，从宏观方面探讨公共卫生与疾病防控领域中的公平、社会公正和人权等问题。公共卫生与疾病防控伦理还关注突发公共卫生事件、传染病防控、慢性病的防控、职业病的防控、地方病的防控等领域，重视公共卫生与疾病防控伦理有利于更好地推动公共卫生事业发展，促进全人群健康。

第一节 | 公共卫生伦理

公共卫生伦理是运用伦理学的理论、原则和方法，探讨和解决公共卫生工作中的实质伦理和程序伦理问题，预防疾病和损伤、促进人群健康的行为规范和实践活动。公共卫生实践与临床医学实践有所不同，这决定了公共卫生工作具有区别于临床工作的性质、特点和难题，同时公共卫生工作也要求处理好公共卫生事件伦理问题。

一、公共卫生工作的性质与特点

（一）公共卫生工作的性质

公共卫生（public health），又称公共健康，该概念是相对于注重个体健康而言的传统的疾病治疗医学而提出的。医疗卫生事业的发展扩大了医学活动对象的范围，现代医学不仅关注个体健康问题，还给予群体和社会公众的健康以同等的关注，因而公共卫生亦可以称为人口的健康、群体的健康。1988 年，美国医学研究所（Institute of Medicine，IOM）在其研究报告《公共卫生的未来》（*The Future of Public Health*）中提出“公共卫生”的定义，即“通过保障人人健康的环境来满足社会的利益”。2001 年出版的《哥伦比亚百科全书》（*The Columbia Encyclopedia*）将公共卫生定义为：“公共卫生是由政府机构提供的，旨在预防疾病，促进公民身体健康的医药保健领域的公共服务。”公共卫生服务的最终目标是保障全体公民的健康，特别是延长预期寿命。

随着细菌学知识的完善和消毒技术的普及，以及 20 世纪免疫接种技术和抗生素的发现与广泛使用，烈性传染病得到一定控制。人口的快速增长和城市化速度加快也丰富了公共卫生概念的内涵：通过有组织的教育和卫生促进活动，改善公众的身体素质和健康水平，延长寿命。预防除传染病以外的其他流行性疾病，也成为公共卫生的新目标。1916 年，第一所公共卫生学院在美国约翰斯·霍普金斯大学医学院成立，标志着公共卫生独立于医学实践。随后，美国的其他大学也相继成立公共卫生学院。这种公共卫生人才的教育模型在 20 世纪逐渐成为培养公共卫生人才的标准模式。

（二）公共卫生工作的特点

1. 工作对象的群体性 虽然历史上有过经典的预防思想，如《黄帝内经》提出“不治已病治未病”思想。然而，在现代公共卫生知识形成和技术成熟之前，临床医学大多只能将出现健康问题的个体作为工作的对象。公共卫生工作则真正实现了“不治已病治未病”的理念，将有效预防疾病发生、促进健康的理论与方法，以具体的措施在社会层面实施，以提高全体成员的整体健康水平。公共卫生实施过程一定会落实到个体，但其关注的核心是群体的健康水平。

2. 工作效果的统计性 当针对个体实施疾病治疗时，无论有效还是无效，效果都只在个体层面

显现。公共卫生针对群体实施干预，其结果虽然对提高大部分个体的身心健康有意义，但是最终结果只能显示在群体层面。如采用预防接种的方式预防传染病，可以有效地预防传染病在群体内流行，并以前后统计结果的对照变化验证其效果。

3. 工作过程的公众性　公共卫生工作如果要产生实际的效果，则需要参与的公众按照专业指引，主动地参与并保持相应的行为模式且持续相当长的时间。如果没有多数社会成员的积极参与，没有全社会的共识与支持，很难实现其目标。例如开展戒烟运动，目前的研究结果显示，戒烟能降低相关疾病发病率、提高社会健康水平，这需要全体人员共同参与。

4. 工作目标的超前性　医学从诞生开始，就重点关注已经出现在个体身上的身心痛苦，即对已经发生的问题，如何能消除或减轻其不利影响。公共卫生工作的目标与此不同，是以将来为工作导向，其目的是减少将来可能发生疾病的概率，从整体上改善群体的健康状况。

公共卫生工作的目标体现了道德关怀的超越性，所关注的是人类未来的痛楚。这种超越，前提是人类对健康和疾病的发生与发展规律的认识和控制技术的进步，从而真切地实现了人类对群体和他人将来身心健康的关切与改善。

5. 价值体现的社会性　公共卫生的最终价值体现在社会层面。公共卫生工作的受益者是相对多数的社会成员，但不一定能确保每一个社会成员都避免受到疾病的影响。从总体看，有效的公共卫生工作确实能减少疾病的发生，提高社会成员的健康水平。

6. 目标评估的滞后性　从工作目标的实现时点看，公共卫生工作的效果显现具有滞后性特点，该项工作具有巨大的社会、经济等效益，但并不具有立竿见影的效果。天花曾经是人类最严重的传染病之一，数千年来导致千百万人死亡或毁容。1796 年，英国人琴纳（Jenner）试种牛痘成功，最终发明了有效预防天花的牛痘疫苗。直至 1979 年 10 月 26 日，世界卫生组织（World Health Organization，WHO）在肯尼亚首都内罗毕宣布，全世界已经消灭了天花病，并且为此举行了庆祝仪式。天花是人类完全控制的第一个烈性传染病，这一成就背后的科学价值、社会影响和经济利益等，在当时是无法计算的。直到 184 年后，接种牛痘疫苗预防天花的道德价值才得以完全显现与肯定。

公共卫生价值评估的滞后性特点，在一定程度上影响着某些公共卫生工作的开展。因为并不是所有人都能以理性的态度对待公共卫生政策与活动，所以需要通过提高全民的知识水平，建立相对完善的公共卫生制度，以确保公共卫生工作的有效开展。

二、公共卫生工作的伦理矛盾与伦理原则

公共卫生工作的开展可能会遭遇某些伦理矛盾和伦理难题，需要识别、剖析这些伦理矛盾和伦理难题，确定破解矛盾和难题的伦理原则。

（一）公共卫生工作中存在的伦理矛盾

1. 政府强制与个人自由之间的矛盾　公共卫生是政府义不容辞的责任。政府采取的公共卫生措施多种多样，比如检疫、隔离、免疫、接触者流行病学调查和追踪随访、环境治理、食品安全管理、卫生设施建设、碘盐推广、害虫和寄生虫控制、污染控制，以及某些传染病、职业病、癌症、性传播疾病、某些先天性代谢缺陷和其他遗传失调的筛查等。政府为公共健康而行使职权完成使命，也提出了重要的伦理问题：政府实施的某些强制性干预措施的合理性及其干预限度的辩护问题，以及平等对待公民的问题等。由于公共卫生代表了公共利益，与关注个体患者利益的临床医疗不同，两种利益之间的冲突是普遍存在的，尤其当政府采取上述某些强制性干预措施时，就会涉及限制公众个人的自由。显然，政府采取某些强制性干预措施和公众个人自由的限制是必要的，能够得到伦理辩护，但问题的复杂性在于政府强制与个人自由之间的关系如何平衡，以及政府强制干预和公众个人自由限制的程度如何确定。

2. 公共利益与个人利益之间的矛盾　公共卫生工作对象的群体性和整体性特点，意味着公共卫生工作主要着眼于健康人群和亚健康人群，并以人群、社会为切入点，去探索和研究公共卫生的工作

规律，采取相应的公共卫生措施，从而使受益人数增加。目前，公共卫生服务大都是基本卫生服务，面向大众，着眼公共健康利益，这不同于普通临床医疗服务，满足患者个体防治疾病的多样化需求。而社会医疗卫生资源总是有限的，这就难免出现公共卫生与普通临床医疗在卫生资源分配上的矛盾，以及基本公共健康利益与多样化个人健康利益之间的矛盾。

3. 个人利益与他人利益之间的矛盾　在公共卫生服务的过程中，时常会发生患者个人利益与他人利益之间的矛盾。例如，一位经性途径传播的 HIV 感染者，公共卫生工作人员对他实施单线联系，他请求不要将他感染 HIV 的情况告诉他的妻子和家人，并承诺会采取必要防护措施，防止通过性途径传播疾病。工作人员深知这位丈夫有可能把 HIV 传染给妻子，如果不将实情告诉妻子，对这位妇女是不公平的。但同时意识到如果医务人员将该情况告诉他的妻子，将损害其家庭，他可能以绝望之心去传播 HIV，报复社会，使更多的人蒙受其害。显然，在公共卫生服务中，为了维护相关他人的利益，患者个人的某些利益受到限制是必要的，但问题的关键是患者个人利益与他人利益之间的关系如何平衡，患者个人利益限制的程度如何把握。

4. 健康利益与其他利益之间的矛盾　人们接受公共卫生服务是为了防治疾病，维护健康。但在接受公共卫生服务，维护健康利益的同时，还有其他利益诉求。例如，维护知情权、自主权、隐私权、行动自由权，追求平等对待而不受歧视等，一般情况下，维护健康利益和上述其他利益诉求是一致的，但有时难免会发生矛盾和冲突。例如，传染病患者的隔离治疗会限制患者的行动自由，流行病学调查和追踪随访会干扰人们的日常生活等。因此，在接受公共卫生服务的过程中，人们的健康利益与其他利益之间的矛盾决定着在提供公共卫生服务的过程中，应该平衡健康利益与其他利益之间的关系。

5. 眼前利益与长远利益之间的矛盾　公共卫生工作目标的超前性与工作效果的迟滞性特点意味着，一方面，公共卫生工作的着眼点放在疾病发生之前，防患于未然；另一方面，公共卫生工作的效果往往不能马上得以体现，需要经过较长的一段时间才能显现。一般而言，公众的医疗卫生需求都是着眼于当前，基于当下罹患的疾病，为了恢复健康。大多数公众并不关注长远健康利益，或者说对长远的健康维护需求并不迫切。对于普通民众，甚至某些政策决策者来说，公共卫生就存在着平衡眼前利益与长远利益之间关系的问题。

（二）公共卫生工作的伦理原则

2002 年，美国公共卫生学会正式提出十二条“公共卫生伦理实践的原则”，这些原则指明了公共卫生的性质与特点、公共卫生机构及其从业人员的责任和义务、公共卫生方案和政策应遵循的核心价值和理念等；澳大利亚生命伦理学家辛格（Singer）也从多伦多的严重急性呼吸综合征（SARS）防控教训中总结出了十条公共卫生伦理原则：个人自由原则、保护公众不受损害原则、比例关系原则、互惠原则、透明原则、隐私原则、保护社区名誉不受损害原则、提供医护责任原则、平等原则和团结原则。学者们在公共卫生伦理原则方面所做的初步工作，建构了现阶段公共卫生伦理原则的基本框架。在此基础上，结合我国的国情，概括出下面五条公共卫生伦理原则。

1. 全社会参与原则　全社会参与原则要求公共卫生工作树立“大卫生观”。公共卫生工作应该面向社会大众，同时应该动员全社会参与。全社会参与原则是由公共卫生工作对象的群体性和整体性、工作过程的社会性和公众性等特点所决定的，该原则可以化解公共利益与个人利益之间的矛盾、个人利益与他人利益之间的矛盾，以及眼前利益与长远利益之间的矛盾等伦理难题。例如，全社会应该保护环境，每一位公民应养成良好的生活方式等，这样才能最大限度维护健康。

2. 社会公益原则　社会公益原则，要求公共卫生工作善于平衡不同工作主体的不同需求和利益，力求使公共卫生工作在保障个人权利和利益的同时，提高社会或集体的总体健康福利。不同于临床医疗工作，临床医学工作对象往往是单个患者，单个患者的疾病得以诊治就是其工作效果。公共卫生工作的服务对象尽管有个体，但更看重群体和整体，主要着眼于健康人群和亚健康人群，其工作效果往往不能马上得以体现，需要经过一段较长的时间才能显现，而且这种效果往往不是有形的，而是无形的、效益巨大且不容易估量。公共卫生的复杂性，决定着公共卫生工作应该平衡公共卫生利益主

体之间的关系，使社会公益置于优先考虑的位置，并兼顾个人权利与健康福利，个人利益服从于社会利益，局部利益服从于全局利益，眼前利益服从于长远利益。

3. 社会公正原则　社会公正原则，要求公共卫生工作公平合理地对待不同服务对象，所有社会成员都应获得同等的公共卫生资源。公共卫生工作不仅涉及患者个体与社会群体之间的关系，还需要处理群体中社会成员之间的关系，在处理社会成员之间的公共卫生服务关系时，需要遵循公平公正原则。因此，在公共卫生工作中，无论是公共卫生政策的制定、资金的筹措、资源的分配还是公共卫生相关信息的公开等，都要坚持社会公正原则。公共卫生应当提倡和努力赋予每一个社会成员基本的健康资源和必要的健康条件，尊重社会中每个人的基本权利，尊重社区内不同人群的价值观、信仰和文化，促进社会人群的健康。这样才能体现公共卫生对人群、社会负责的宗旨，并确保公共卫生政策的合理性和公平性。

4. 互助协同原则　互助协同原则，要求公共卫生工作领域内的人员之间应该互相帮助，共同发展公共卫生事业。公共卫生工作涉及的范围广，从职业病防治、环境治理、传染病防治到对研究对象的保护、免疫政策、儿童健康与保护、供水系统安全、食品安全和药物安全、禁烟、精神卫生、健康教育、预防和控制地方病等，牵涉的人员也多，要完成一项公共卫生工作，不同领域中的人员之间必须互助与协作。一方面，公共卫生机构应该加强人员招募与培训，由具有专业知识的人员从事相关工作；另一方面，公共卫生机构及其从业人员也要学习如何与政府、媒体、社区、医疗保健机构等部门协同工作，为完成公共卫生任务、建立公众信任机制而努力。

5. 信息公开原则　信息公开原则是指尊重公众的知情权与保证信息及时公开透明，建立和维持人们对政府的信任。在公共卫生工作中，要尊重公众的知情权，政府应做到信息透明，以获得社会公众的信任，尤其在突发公共卫生事件的处理过程中，国家建立突发事件应急报告制度，任何单位和个人对突发事件不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。国务院卫生行政部门负责向社会发布突发事件的信息，必要时，可以授权省、自治区、直辖市人民政府卫生行政部门向社会发布本行政区域内突发事件的信息。信息发布应当及时、准确、全面。但是，一般临床医疗工作仅关涉患者个人疾病的诊治，而公共卫生涉及社会群体内部成员之间关系，在信息公开的同时要注意尊重患者的隐私权，不得泄露和利用患者的隐私，不应该任意剥夺患者行动自由的权利，不能歧视患者。再如，为了公众健康利益，可以在一定程度上侵犯个体权益，但其前提必须是采取的公共卫生行动有效，且侵犯不可避免、必要和合理，同时尽可能确保侵犯的性质最轻、程度最小、时间最短。这就要求公共卫生工作严格掌握标准，最大程度保护个体权益，不能以维护公共健康利益为借口，忽视与践踏个体人权。

三、突发公共卫生事件伦理

突发公共卫生事件不仅给常规的公共卫生体系带来巨大挑战，同时在应急处置过程中也会面对一些伦理困境。处理突发公共卫生事件需要结合治理中的特点，确定应急处置的基本伦理原则。

（一）突发公共卫生事件的概念

突发公共事件（public emergencies）是指突然发生，造成或者可能造成重大人员伤亡、财产损失、生态环境破坏和严重社会危害，危及公共安全的紧急事件。突发公共卫生事件是突发公共事件中的特殊类型。《国家突发公共事件总体应急预案》规定，突发公共事件根据发生过程、性质和机理，主要分为四类：自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件，其中的公共卫生事件主要包括传染病疫情、群体性不明原因疾病、食品安全和职业危害、动物疫情，以及其他严重影响公众健康和生命安全的事件。依据此规定，突发公共事件按照其性质、严重程度、可控性和影响范围等因素，一般分为四级：Ⅰ级（特别重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）和Ⅳ级（一般）。

（二）突发公共卫生事件的特点

1. 突发性　对突发公共卫生事件发生的时间、地点、暴发方式、程度等，人们往往都难以准确把握。

2. 复杂性　当突发公共卫生事件发生后，其影响表现在诸多方面，处理解决起来非常不易。如果处置不当，可能导致损失扩大、影响范围扩大，甚至发展为社会问题。

3. 破坏性　突发公共卫生事件不仅会带来直接的人员伤亡和财产损失，还会对人们造成强烈的心理冲击，进而导致社会生活各个层面的损失。

4. 持续性　在人类历史上，突发公共卫生事件时有发生，并未杜绝。就某个具体的突发公共卫生事件而言，一旦发生，一定存在一个持续的过程，一般分潜伏期、暴发期、高潮期、缓解期、消退期几个阶段。

5. 可控性　人类基于已有的知识、经验和技术，通过努力可以一定限度地降低突发公共卫生事件发生的频率和次数，减轻其危害程度，使之不超出一定的范围。这是人类在认识与改造自然方面进步的必然结果与重要标志。

（三）处置突发公共卫生事件的伦理要求

1. 预防为主、防治结合　当突发公共卫生事件发生之后，给予受害者及时有效的治疗，是基本的伦理要求。尽管突发公共卫生事件不可能完全避免，且发生之后将带来更多的问题，但还是应该建立相对完备的机制预防其发生，或在发生后及时控制其影响范围与程度，这是更重要的伦理要求。“预防为主、防治结合”是处置突发公共卫生事件的重要伦理要求。只有积极预防、常备不懈，才能最大限度减少突发公共卫生事件带来的不利影响。

2. 政府责任第一、个人义务并行　在现代社会，应对公共卫生事件的主要责任者是政府及其相关部门。政府负有领导调度、制定预案、监测和预警、决策、指挥、信息通报、资源储备与调配、经费筹措、急救医疗网络建设等系列责任。政府相关部门应通力协作，引导公众行为，指导社会预防。涉及事件的个人，应承担对自己和他人的健康义务。例如传染病感染者和疑似患者、密切接触者，应当配合进行相应的医学隔离治疗与观察措施，并主动采取避免传染的卫生行为。政府和个人共同负责，形成互补。

3. 患者利益第一、兼顾医者利益　突发公共卫生事件发生后，医务人员必须根据预案或安排，在严重威胁自身健康的突发事件面前，冲锋在前，切实负起对患者和公众的责任，给予受害者以最佳的救治，最大程度地保障受害者的健康和生命安全。在保障患者利益的同时，应最大程度地保障医务人员不因本职工作而导致身心健康问题，或者出现其他方面的损失。首先，应确保医务人员有足够的卫生防护措施。医务人员是突发公共卫生事件应急处理的主力军，其在应对过程中承担着极大的风险。如果医务人员因其职务行为而受损害，全社会将失去有效的防护机制。其次，对确实遭遇不幸的医务人员，政府应给予本人或家属优抚与补偿。

4. 集体利益第一、兼顾个人利益　集体利益与个人利益是辩证统一的，而且集体利益高于个人利益，必要时个人应为集体利益作出不同程度的牺牲。在突发公共卫生事件中，有时为了保全公众的最大利益，个人应放弃自己的部分甚至全部利益，尽自己努力防止突发事件负面影响的扩散；在处理突发事件时，个人有义务和责任，自觉地接受和配合有关部门采取的必要紧急措施。

当然，在这一过程中，个人的基本权利应该得到尊重与保护。如对感染者、疑似感染者、密切接触者，采取隔离治疗与观察等措施时，应提供足够的生活便利，采取有利于其及早治愈和恢复、促进身体健康的得力方案。应杜绝任何歧视、拒绝治疗和帮助等行为。

第二节 | 传染病防控伦理

防控传染病始终是公共卫生工作的重要内容。20 世纪中叶，人们在控制天花、麻疹、伤寒和鼠疫等传染病方面取得很大成功，但仍陆续出现诸如艾滋病、SARS、禽流感、埃博拉出血热、新型冠状病毒感染等新的传染病，而原来被人们认为已经得到控制的传染病也时有复发。这就需要我们不断加深对传染病的认识，加强对传染病的有效防控，遵循传染病防控，尤其是性病和艾滋病防控的伦理要求。

一、传染病的含义

传染病（communicable diseases）是由各种病原体引起的能在人与人、动物与动物或人与动物之间相互传播的一类疾病。病原体中大部分是微生物，小部分为寄生虫，寄生虫引起的疾病又称寄生虫病。法定传染病是指发现后必须按照规定及时向当地疾病预防控制机构报告，疾病预防控制部门需要及时掌握其发病情况，及时采取对策的传染病。目前，中国的法定传染病有甲、乙、丙3类，共41种。

传染病可经过多种途径传播，可由直接接触已感染的个体、感染者的体液及排泄物、感染者所污染的物体传播，此外还有空气传播、水源传播、食物传播、土壤传播、垂直传播、粪口传播等。

不同于一般疾病，传染病有病原体，具有传染性和流行性，感染后常有免疫性，有些传染病还有季节性或地方性。传染病的传播和流行必须具备三个环节，即传染源（能排出病原体的人或动物）、传播途径（病原体传染他人的途径）及易感人群（对该种传染病无免疫力者）。如果能完全切断其中的一个环节，就可防止该种传染病的发生和流行。传染病可以按病原体分类，也可以按传播途径分类。传染病的预防应采取以切断主要传播环节为主导的综合措施。不同传染病的传播环节有所不同，在防控中应具体分析、充分利用，除主导环节外对其他环节也应采取措施，更好地预防和控制各种传染病。

二、传染病的防控内容

传染病防控是各级疾病预防控制机构的主要业务工作内容，即运用法律、行政、技术手段消除和管控传染源、切断传播途径、保护易感人群，预防、控制和消除传染病的发生与流行。

国家通过制定有关法律，要求各级政府按照预防为主的工作方针，确定不同时期的防控重点，动员群众，整合资源，针对重点地区和重点人群，组织全社会共同参与防控工作，主要应做到以下两点。

（一）坚持预防为主的积极防疫理念

与一般疾病相比，传染病的预防十分重要，同等重要的还有对易感人群的保护，控制其流行范围，避免社会灾难。人类通过接种天花疫苗彻底消灭天花；通过预防接种，部分烈性传染病尤其是易发于儿童的烈性传染病得到了有效的控制，明显降低了传染病的发病率。

（二）严格执行隔离消毒措施和操作规程

传染病的危害性，除了损害患者本人的身心健康之外，还在于传染他人，形成群体感染。人类在经过了极其惨痛的教训之后，才总结出一系列预防控制传染病流行的方法。隔离和消毒是传染病管理与防治工作中最重要的环节，也是公共卫生工作者与传染病斗争的重要内容。

隔离是通过物理阻断的方式，防止传染病扩散。隔离包括三种：一是对传染病患者的隔离，即将已经确诊的具有传染性的患者进行隔离治疗；二是对疑似传染病患者的隔离，即在传染病流行期间，将疑似传染病的患者进行隔离观察；三是对医务人员的隔离，即对与传染病患者、疑似患者、传染病动物、疑似动物接触的医务人员，也必须采取必要的隔离措施。

消毒主要是采取有效措施杀灭传染病患者可能散播的细菌、病毒或其他传染源，对象包括居住的场所、日常用品、排泄物、分泌物、接触使用过的医疗器械等。与传染病接触的医务人员，在离开病区时，必须采取消毒措施，避免将传染源带出病区。

公共卫生工作人员和医务人员必须以高度的道德责任感，按照科学的方法做好各种预防措施，绝不能因自己的疏忽，给公众健康带来威胁。

三、传染病防控的伦理要求

在传染病防控中应遵循的总的伦理要求包括：积极开展传染病的防控，对广大群众的健康负责；认真做好传染病的监测和报告，履行其道德和法律责任；尊重科学，秉持奉献精神；尊重传染病患者的人格和权利；勇于克服困难，秉持献身精神等。对于一般性传染病防控、性病防控和艾滋病防控的伦

理要求又各有侧重。

（一）一般性传染病防控的伦理要求

1. 尊重传染病患者的权利　在人类历史上，传染病患者曾经被视为灾星，在当今社会，传染病患者也容易受到歧视和排挤，有时甚至发生惨剧。医务人员应该认识到传染病患者是传染病的受害者，任何指责、歧视、排挤传染病患者的做法都是错误的。在工作中，公共卫生工作者应尊重传染病患者及疑似患者的各项正当权益。

2. 遵守国家法律规定　我国已经建立传染病防治体系，用以及时发现、隔离、治疗各种传染病。相关的医务人员应按照国家法律规定，及时发现、报告疫情。这既是法定义务，又是最基本的公共卫生道德要求。

（二）性病防控的伦理要求

1. 尊重性病患者，消除其心理顾虑　部分性病患者因性关系混乱而染病，尽管患者本人并没有故意染病，但该类患者往往承受巨大道德与舆论压力，他们既担心治疗的时间、费用、后遗症等问题，又担心亲戚朋友知道真相后自己难堪、受歧视，更担心传染家人，内心充满恐惧、后悔、自责、焦虑不安等负面情绪。公共卫生工作者在处理相关事务时，应与对待一般传染病患者一样，热情、细致、耐心、周到，维护其尊严，获得其主动配合。严禁对患者有嘲笑、挖苦、讽刺、歧视等行为。

2. 主动采取预防控制措施，防止扩散　性病是传染病，危害患者家人和公众的健康。公共卫生工作者和医务人员在发现性病病例之后，有责任按规定向有关机构和部门报告，还应建议患者通知其性伴侣及时到医院进行详细检查治疗。

为患者保守医疗秘密是医务人员的基本道德义务，在性病防控和治疗过程中也不例外。但保密有一个前提和限度，即不能危害他人和公众利益。因此，在性病防控和救治过程中，正确处理保密与维护他人和公众利益之间的关系十分重要。

3. 传授正确知识，预防可能引发的心理问题　只要采取科学措施，性病可防可治。许多患者不了解预防性病的科学方法，结果多次被感染，或患病后不主动采取预防措施，将疾病传播给其性伴侣。因此，公共卫生工作者应积极向社会宣教防控性病的知识，以及常见的、由性病引起的心理问题的调适方法，另外还应积极进行性道德、性态度、性行为等方面的知识的宣教。

（三）艾滋病防控的伦理要求

1. 协调艾滋病检测信息保密与公开之间的冲突　我国实行艾滋病自愿检测制度；血站、单采血浆站应当对采集的人体血液、血浆进行艾滋病检测；采集或者使用人体器官、组织、细胞、骨髓等时，应当进行艾滋病检测；医疗卫生机构应当按照国务院卫生行政部门制定的预防艾滋病垂直传播技术指导方案的规定，对孕产妇提供艾滋病防治咨询和检测，及时采取艾滋病病毒母婴阻断措施。《艾滋病防治条例》规定：艾滋病病毒感染者和艾滋病患者有义务将感染或者发病的事实及时告知与其有性关系者；但同时规定，未经本人或者其监护人同意，任何单位或者个人不得公开艾滋病病毒感染者、艾滋病患者及其家属的姓名、住址、工作单位、肖像、病史资料以及其他可能推断出其具体身份的信息。因此，公共卫生工作者是否有义务告知艾滋病病毒感染者和艾滋病患者的性关系者可能感染的信息，是一个需要破解的伦理难题。

2. 协调行为指导与个体保护的冲突　有效控制艾滋病的传播需要对高危人群的行为进行指导，这是被实践证明的行之有效的措施。在对易感人群进行有效指导时，不能简单地进行道德评判，合法性与否需要司法机关或其他权威机构作出判断。

第三节 | 慢性病、职业病和地方病防控伦理

慢性病、职业病和地方病防控也是公共卫生工作的重要内容。随着我国经济社会的发展变化，慢性非传染性疾病（简称慢性病）的患病率逐年升高，职业病和职业性损害日益突出。我国某些地区的

地方病仍需要进行积极防控。这就需要我们认清慢性病、职业病和地方病的概念、特征及防控形势，确定积极防控的伦理准则。

一、慢性病的防控伦理

慢性非传染性疾病已经成为严重威胁我国公民乃至全球公民健康的一类疾病。我们要深入认识慢性非传染性疾病，认清慢性非传染性疾病防控的严峻形势，遵循慢性非传染性疾病防控的伦理要求。

（一）慢性病及其防控内容

慢性病的全称是慢性非传染性疾病，不是特指某种疾病，而是对一类起病隐匿，病程长且病情迁延不愈，缺乏确切传染性生物病因证据，病因复杂，且有些尚未完全被确认的疾病的概括性称谓。在临床实践中，具有代表性的慢性病主要包括心脑血管疾病、糖尿病、恶性肿瘤、慢性阻塞性肺疾病、精神障碍等。慢性病病程长、严重影响患者的生命质量、加重家庭和社会经济负担、严重损害社会劳动能力，也是导致死亡的主要原因，所以预防与控制慢性病十分重要。

近年来，我国的慢性病防控效果显著增强。国家已建立慢性病和慢性病危险因素监测网络；老年人健康管理和高血压、糖尿病患者管理等作为国家基本公共卫生服务免费向公众提供；国家实施脑卒中和心血管疾病高危筛查、口腔疾病综合干预、癌症早诊早治等项目。例如，2023 年 10 月，国家卫生健康委员会发布《健康中国行动—心脑血管疾病防治行动实施方案（2023—2030 年）》，明确到 2030 年建立覆盖全国的心脑血管疾病综合防控和早诊早治体系；各级医疗卫生机构的心脑血管疾病防治能力和质量进一步改善，人民群众心脑血管相关健康素养显著提升，心脑血管疾病防治技术取得较大突破；心脑血管疾病发病率及危险因素水平上升趋势得到有效控制，心脑血管疾病死亡率下降到 190.7/10 万以下。同时还明确，要“实施危险因素控制，降低发病和死亡风险”“强化关口前移，创新心脑血管疾病同防同治路径”；加大基层医疗机构血压、血糖、血脂“三高共管”力度；到 2030 年，高血压、糖尿病患者基层规范管理服务率均应达到 70%，治疗率、控制率在 2018 年基础上持续提高，35 岁以上居民年度血脂检测率达到 35%；探索将冠心病、脑卒中患者的二级预防和康复治疗纳入家庭医生签约服务范围。《健康中国行动—癌症防治行动实施方案（2023—2030 年）》提出，到 2030 年，癌症防治体系进一步完善，危险因素综合防控、癌症筛查和早诊早治能力显著增强，规范诊疗水平稳步提升，癌症发病率、死亡率上升趋势应得到遏制，总体癌症 5 年生存率达到 46.6%，患者疾病负担得到有效控制。

（二）慢性病防控的伦理要求

1. 全面贯彻三级预防理念与措施　三级预防是在社会层面防控慢性病最有针对性的方法。

第一级预防称为病因预防，是预防慢性病发生的第一道防线，包括三方面：一是针对个体的预防措施，二是针对环境的预防措施，三是针对社会致病因素的预防措施。公共卫生应特别关注健康的社会决定因素，即除了直接导致疾病的因素外，社会分层和条件的差异导致人们在居住、饮食、卫生和工作环境等方面的差异，并间接决定疾病在不同个体间的发生概率也存在差异。可见，社会决定因素是导致疾病发生的根源。

第二级预防称“三早”预防，即早期发现、早期诊断、早期治疗。在疾病初期采取预防措施，可有效延缓慢性病进程，提高患者生活质量，减少社会损失。这一阶段的公共卫生工作，应加强慢性病“三早”预防的知识和技术宣传普及，并通过普查、筛检和定期健康检查，以及教育公众进行自我监测，及早发现疾病初期患者，并提供及时治疗。

第三级预防称康复治疗，是疾病进入后期阶段的预防措施。由于机体对疾病已失去调节代偿能力，可能出现伤残或死亡的结局。此时应采取对症治疗，并辅以各种康复治疗，减少痛苦，延长生命，力求病而不残，残而不废，促进康复。此阶段，应通过建立公平的医疗费用负担机制和医疗服务获取机制，实现慢性病预防与控制目的。

2. 加强对患者和家属相关知识的教育指导　慢性病患者往往长期带病生活。他们寻求医学帮助的基本模式往往是“症状驱动式”，即患者在已经不能承受疾病症状之苦时才寻求治疗，但实际上很多慢性病可以通过采取恰当的行为与生活方式控制症状，而患者及其家属因为缺失相关知识和方法而无法实现。因此，应重视第二级预防，加强对患者及其家属的相关知识教育和健康行为指导。

3. 关注慢性病患者的心理需求并提供社会支持　慢性病患者长期承受疾病的痛苦及多种压力，如担心失去工作能力与机会、担心个人被家庭和社会抛弃、给家庭带来负担、缺少医疗费用而失去治疗机会等。这些担心与压力本身就是值得关注的心理问题，而且还是慢性病发展变化的新的致病因素之一。所以，应给予慢性病患者足够的心理和社会支持，改善其心理状态，增强其战胜疾病的信心，分担个人与家庭的生活压力，改善慢性病患者的生活质量。

二、职业病的防控伦理

随着工业化、城镇化和经济全球化的不断推进，职业病危害问题也日渐突出，职业病防治形势严峻。在概念上职业性损害比职业病更宽泛。我们要正确认识职业病及职业性损害，遵循职业病防控的伦理要求。

（一）职业病及其防控内容

《中华人民共和国职业病防治法》（以下简称《职业病防治法》）规定，职业病是指企业、事业单位和个体经济组织的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病。职业病的构成有四个条件：①患病主体是企业、事业单位或个体经济组织的劳动者；②必须是在从事职业活动的过程中产生的；③必须是因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等职业病危害因素引起的；④必须是国家公布的职业病分类和目录所列的职业病。卫生部在 1972 年首次公布 14 种职业病，2013 年国家卫生计生委等 4 部门公布的规定职业病共有 10 类 132 种。随着社会的发展，职业病及职业性损害越来越多。这与人类对自然的控制和改变程度密切相关，例如大工业生产中有毒有害因素增多，以及精细的职业分工等。上述法定职业病是严格意义上的职业病。

广义上说，凡是因特定职业活动引起的特定疾病也应予以关注，如长期强迫体位操作，局部组织器官持续受压等，典型诊断如网球肘、鼠标手（腕管综合征）等。广义的职业病，是公共卫生问题，也可以通过恰当的公共卫生工作预防和控制。

职业病防治事关劳动者的身体健康和生命安全，事关社会的经济发展和稳定大局。随着政策调整、经济发展和科技进步，我国在职业卫生领域取得了长足发展，但也存在一定问题。自《职业病防治法》实施以来，我国职业病防治体系逐步健全，相关宣传更加普及，全社会防治意识不断提高，有效控制了职业病的增长。工业化进程的不断推进为实现后工业化时代的职业病防控目标提出了新的要求。

第一，以《国家职业病防治规划》为指导，推进职业病防治体系建设。建立健全用人单位负责、行政机关监管、行业自律、职工参与和社会监督的职业病防治工作格局。

第二，对于煤炭行业、有色金属行业等职业病高发行业，以及职业性耳鼻喉口腔疾病、物理因素所致职业病、职业性传染病等相关职业人群，需进一步增强职业病防治法律意识，普及职业病防治知识，改进生产工艺，增强用人单位的职业危害防治观念。

从公共卫生实践的角度看，在概念上职业性损害比职业病更宽泛，所有在生产过程、劳动过程和生产环境中存在的各种职业性有害因素对劳动者健康产生的危害，均可称为职业性损害。

（二）职业病防控的伦理要求

1. 坚持“预防为主、防治结合”的工作态度　职业病预防重于治疗。随着相关知识的增长和技术的进步，相当一部分职业病已经有了成熟的预防方法。公共卫生工作者应以《职业病防治法》为指导，贯彻“预防为主、防治结合”的职业病防治方针，积极主动地宣传职业卫生知识和技术，加强对特定职业劳动者的健康保护。

2. 坚持“深入一线、监督指导”的工作方式　公共卫生工作者要深入一线，从相关劳动场所的设计审查、竣工验收，到开工后的经常性监督检查；从对相关劳动者进行培训和职业病预防行为指导、及时开展体检，到发现职业病问题后及时报告与进行治疗，都要开展第一手工作，取得第一手资料。既对生产单位又对劳动者进行监督和指导。另外，公共卫生工作者还应对社会发展中新出现的职业病问题开展研究，以深化对职业病的认识，促进职业病预防与控制工作。

三、地方病的防控伦理

我国的地方病问题不容忽视。地方病防控是健康中国的重要行动之一。我们应明确地方病的概念以及防控内容，明确地方病防控的伦理要求。

（一）地方病及其防控内容

地方病又称水土病，是由水源、土质等原因引起的具有地域性的疾病。其特点是发生在某一特定地区，同特定自然环境密切相关，在一定地区长期流行，且有一定数量的患者表现出共同的病症。在中国分布较广泛的地方病有碘缺乏病、水源性高碘危害、地方性氟中毒、地方性砷中毒、大骨节病和克山病等。

地方病主要分为化学元素性、自然疫源性、与生活习惯相关性和原因未明性地方病四大类。化学元素性地方病病因是当地水或土壤中某种（些）元素或化合物过多、不足或比例失常，再通过食物和饮用水作用于人体所产生的疾病。其中元素缺乏性地方病主要是碘缺乏病、地方性克汀病等；元素中毒性地方病主要是地方性氟中毒、地方性砷中毒、地方性硒中毒、地方性钼中毒。自然疫源性地方病病因为微生物和寄生虫，是一类传染性的地方病，包括鼠疫、布鲁氏菌病、乙型脑炎、流行性出血热、血吸虫病、疟疾、棘球蚴病等。与生活习惯相关性地方病主要是燃煤污染性地方性氟中毒、砷中毒和大量饮用砖茶导致的饮茶型氟中毒。原因未明性地方病主要是大骨节病、克山病等。

近年来，我国的地方病流行趋势得到有效控制。截至 2021 年底，全国 2 799 个碘缺乏病县、379 个大骨节病病区县、330 个克山病病区县、171 个燃煤污染型氟中毒病区县、12 个燃煤污染型砷中毒病区县、122 个饮水型砷中毒病区县或高砷区县均达到控制或消除标准。

根据《“健康中国 2030”规划纲要》《健康中国行动（2019—2030 年）》《关于实施健康扶贫工程的指导意见》，我国依法全面落实地方病防治措施，建立了与经济社会发展水平相适应的长效工作机制，加大贫困地区地方病防控工作力度，稳步推进地方病控制和消除工作，巩固防治成果，持续控制和消除重点地方病危害。为充分发挥卫生行政部门、疾病预防控制机构（包括地方病防治机构）、基层医疗卫生机构和医院在地方病预防控制工作中的作用，明确各相关单位的职责、任务和工作内容，规范防治工作流程和考核标准，提高防治效果，有关部门制定了《地方病预防控制工作规范（试行）》（以下简称《规范》）。

《规范》围绕碘缺乏病、水源性高碘危害、地方性氟中毒、地方性砷中毒、大骨节病和克山病等，从机构、职责和人员，工作计划和实施方案，监测与调查，干预与管理，信息管理，能力建设，综合评价 7 个部分对卫生健康行政部门、疾病预防控制机构、基层医疗卫生机构、医院的职责、任务和基本工作流程进行了规定。

各地在实施《规范》过程中，要紧密联系地方病相关规划、方案，有效衔接预防和治疗等各环节，分工协作，各负其责，最大程度地提高地方病防控效果。同时，卫生健康行政部门要与其他部门密切协作，创造有利于健康的社会、经济、生活环境，落实综合预防措施，有效控制和消除地方病危害。地方各级卫生健康行政部门可以根据《规范》基本要求，结合当地实际情况，制定本地区的地方病防治实施细则。

（二）地方病防控的伦理要求

1. 吃苦耐劳的工作精神　地方病多发生在经济不发达，交通不方便，生活条件差，卫生保健条件落后的地区。在开展地方病的预防保健与疾病控制工作过程中，公共卫生工作者要能够吃苦耐劳，主

动深入条件艰苦的地区，坚持在一线发现问题，现场指导与解决问题。

2. 强化相关知识教育与专业指导　地方病的预防与控制，需要生活在特定地区的每一个社会成员都了解地方病的预防与控制知识，熟练掌握相应的预防与控制技术，并采取恰当的行为方式以避免疾病的发生。因此，公共卫生工作者应广泛开展认真细致的教育与训练工作，并检查受教育者的行为表现，核实教育效果。教育与训练工作不能只走形式，而是要落实到每一个居民的具体生活之中。

3. 加强公共卫生体制与制度建设　在地方病发病地区，加强当地的公共卫生体制建设，才能将地方病的预防与控制转为经常性的工作。除了建立专门的地方病预防与控制体系之外，通过已有的社会体制实施公共卫生活动也十分重要。如依托已有的教育体系，强化有关知识教育和技术培训；依托已有的行政体系，强化预防与控制措施的落实；依托已有的医疗卫生体系，强化地方病的监测与治疗。

思考题

1. 简述公共卫生工作的伦理原则。
2. 突发公共卫生事件处置应遵循哪些伦理原则？
3. 慢性病的防控中，患者和家庭需要注意哪些伦理问题？
4. 职业病预防与控制的道德要求有哪些？
5. 地方病的预防与控制的道德要求有哪些？

（常运立）

本章数字资源

第八章 临床诊疗伦理

临床诊疗工作是医务人员在治病救人的过程中最主要也是最重要的内容，包含了临床诊断和临床治疗两部分。临床诊断伦理是医务人员在疾病诊断各环节中应遵循的道德准则；临床治疗伦理是医务人员在治疗疾病不同方式的选择和实施中应遵循的道德准则。遵循临床诊疗伦理原则有利于医务人员充分发挥医学科学技术优势，最大程度解除或减小患者痛苦；也有利于医务人员适应新的医学模式，积极构建和谐医患关系。

第一节 | 临床诊疗伦理概述

临床诊疗伦理是医学伦理学课程的核心内容。面对复杂多变的临床实际问题，临床诊疗伦理在理论层面为医务人员提供了常见伦理问题的思考、分析及处理方式。它具体涵盖了对疾病的诊断及治疗过程，包括了问诊、体格检查、辅助检查及药物治疗、手术治疗、心理治疗、康复治疗等。生物-心理-社会医学模式的确立，要求临床诊疗必须以患者为中心，医务人员要将医术与医德有机融合，遵循临床诊疗工作中的伦理规范，提高诊疗水平，才能最大程度地减轻患者痛苦，促进康复。

一、临床诊疗伦理原则

临床诊疗伦理原则是医学伦理原则在临床实践中的具体应用，包括患者至上、知情同意、最优化和保密守信等。

1. 患者至上原则 患者至上原则要求临床诊疗应该关注患者，而非仅仅关注疾病本身，要关注患者最为看重和需要的。对于医学应该更多地关注疾病，还是关注患有疾病的患者这个问题，西方医学之父希波克拉底早有论断："了解你的患者是什么样的人比了解他们患了什么病重要得多。"随着疾病谱的变化，医学技术有限性的凸显，患者权利意识的增强，传统生物医学模式"以疾病为中心"的缺陷日渐明显，1977 年美国医学家恩格尔（Engel）提出了"生物-心理-社会"医学模式，得到医疗行业和社会的普遍认同，这一新的医学模式核心就是以患者为中心，即关注人本身。

"患者至上"的实现，要清楚患者需要什么。根据马斯洛（Maslow）的需求层次理论，人的需要依次是：生理需要、安全需要、归属与爱的需要、尊重的需要和自我实现的需要。首先，患者是人，所以就医过程中也有最基本的五种需要；其次，患者英文表述是"patient"，意指遭受苦难的人，所以解除其生理、心理的苦难，是实现"患者至上"的目标。从一项基于大量患者的调查结果来看，诊疗效果、医疗花费、个人尊严等是患者最为看重和需要的。因此，准确的临床诊断、有效的临床治疗、可负担的医疗花费、有效沟通以维护患者尊严，是临床医护人员应该关注的焦点。再次，患者多样性的需求既不能背离患者自身的健康利益，也不应与他人及社会利益产生冲突。医学是一门特殊的学科和职业，医护人员与患者之间存在知识壁垒，同时因现实中出现医患矛盾的负面影响，在具体的临床决策中，可能会出现医护人员与患者有不同的价值选择，医护人员要进行自我评估，确认诊断、治疗的方法是否以维护患者的健康为中心。

2. 知情同意原则 知情同意原则要求临床诊疗要告知患者病情及有关信息，诊疗方案得到患者同意方可实施。美国生命伦理学专家芳登（Faden）和比彻姆（Beauchamp）在《知情同意的历史与理论》一书中指出，知情同意原则在医疗实践和医学科研两个领域有着各自独立又相互影响的发展历

程。医学科研中的知情同意原则有一系列著名的法典文献，对其作出明确的阐述；医疗实践中的知情同意原则的起源则更为复杂，很大程度上是随着一系列重要的法院判决的宣告而逐步成形的。

从20世纪80年代开始，知情同意原则被引入中国，有关法律对其进行了规定。无论是具体的临床诊断抑或治疗，都要求尊重和维护患者及其家属的知情同意权。产生于西方文化背景下的知情同意原则，是美国生命伦理学尊重原则的直接体现。比较美国和中国知情同意原则的不同可见，前者更多强调个人自由，而后者更多注重家庭观念。因此，以维护患者利益为出发点的知情同意原则必须实现中国化，应当协调知情同意的个人主义与中国传统的家庭主义之间的文化冲突，实现知情同意的道德要求与中国传统伦理精神的契合。

3. 最优化原则　最优化原则要求临床诊疗要力争实现患者利益的最大化。正如胡弗兰德《医德十二箴》所言："应尽可能地减少患者的医疗费用。当你挽救他生命的同时，又拿走了他维持生活的费用，那还有何意义？"临床诊疗方案的选择应该力争做到对患者而言疗效最佳、损伤最小、痛苦最轻和耗费最少。其中"疗效最佳"是指诊疗效果在当时医学发展水平上或在当地医院的技术条件下，应该是最好的、最显著的。"损伤最小"是指在疗效相当的情况下，临床工作应该力争安全度最高、副作用最小、风险最低、伤害最少。正如人们常说的：能口服不肌注，能肌注不输液。"痛苦最轻"是指在确保治疗效果的前提下选择给患者带来痛苦最小的治疗手段。"耗费最少"是指应当在保证诊疗效果的前提下，选择卫生资源耗费最少，患者、家属、社会经济负担最轻的诊疗措施。

4. 保密守信原则　保密守信原则是指医务人员在对患者进行疾病诊疗的过程中，要时刻注意保守患者的隐私和秘密，遵守诚信的伦理准则。其中，保守隐私具体包括：一是对患者的疾病史、检查化验结果、疾病的诊断和治疗方法以及其他患者不愿向外界泄露的隐私，医务人员有义务保守秘密，不能随意泄露和传播，更不能作为与别人的谈资；二是患者的不良诊断和预后要注意保密，避免给患者带来刺激和心理压力。此外，发生在其他患者身上的医疗差错意外等信息，容易使患者丧失对医务人员的信任进而影响自己的治疗效果，一般情况下也应保守秘密。

患者出于对医务人员的信任和治疗的需要，将自己的内心秘密告知了医务人员，医务人员也应该同样尊重患者的尊严和权利，尽职尽责、尽心尽力地做好对患者的诊疗，不能背信弃义，更不能触犯法律和道德的底线。

二、特殊诊疗伦理问题

临床诊疗伦理是医务人员临床诊疗活动的价值导向，也是彰显医学初心使命的"窗口"，医务人员在具体的诊疗行为中，尤其要注意正确处理有关特殊诊疗伦理问题，以避免对患者造成多样性的伤害。

（一）避免医源性疾病的伤害

1. 医源性疾病概念　医源性疾病（iatrogenic disease）是指患者在预防或诊治疾病的过程中，由于医学方面的原因（包括药物、诊疗措施及医者的行为和言语不当，以及错误的医学理论或试验导致的疗法等），所引起的原有疾病以外的另一种或多种疾病。

医源性疾病在世界各国的发生较为普遍，应当引起重视。但是，人们对医师的诊治工作能够引起疾病，成为某些疾病的原因往往缺乏足够的认知。

2. 医源性疾病成因的伦理分析

（1）医源性疾病与医务人员的诊断有关：例如，医师在综合判断力有限的情况下发生的误（漏）诊。当患者出现严重焦虑导致的失眠，并伴有饮水时情绪紧张、呼吸困难，以及吹风时产生被迫妄想、需要躲在黑暗环境中才能感到安全等症状时，很容易让医师判断患者患有精神性疾病，而如果医务人员熟练掌握狂犬病发作的特点，如恐水、怕风、怕光等，就可能得到准确和及时的疾病诊断。

（2）医源性疾病与药物使用有关：医源性疾病常由不合理用药引起，有时合理用药也可发生药物

不良反应，例如，对氨茶碱过敏的支气管哮喘患者要禁用氨茶碱。

（3）医源性疾病与手术有关：例如手术适应证的判断或手术方法的错误、操作失误，将导致健康组织或器官损伤，此外还有术后处理不当问题。

（4）医源性疾病与器械有关：如在使用腔道内镜或导管等技术中，引起组织器官损伤或各种并发症；以及非创伤性处理不当，如止血带使用过久、石膏绷带包扎过紧，均可造成损伤。

（5）医源性疾病与放射或理疗有关：包括 X 射线、γ 射线、核素及各种理疗方法，如使用不当、照射量过大、防护不周，将可能引起损伤。

（6）医源性疾病与用语有关：医护人员使用医学用语不恰当可能引起患者心理创伤。

（7）医源性疾病与预防措施有关：如免疫制剂使用和接种方法不当，将可能引起损伤。

3. 减少医源性疾病发生的伦理对策

（1）增强责任心：医务人员工作疏忽、责任心不强是引起医源性疾病最普遍、最基本的原因。有资料显示，在发生的医源性疾病中，约 80% 的医疗事故是由责任心不强导致的。

（2）遵循最优化原则：真正做到最优化，才能减少医源性疾病的发生。尤其要注意药物配伍中首选药物的最优化、外科手术方案的最优化、晚期肿瘤患者治疗的最优化等。

（3）杜绝片面追求经济收益：单纯追求经济收益是当前医源性疾病上升的一个重要原因。例如随意扩大手术范围、过量用药、过度的实验室检查和影像检查，以及部分医师的逐利思想和行为等，导致了本不该发生的医源性疾病。

（4）注重培育医务人员的同理心和道德素养：提升同理心和道德素养，才能使医师在诊疗疾病时，做到对患者关爱同情、认真负责、一视同仁、积极救治等，这对减少医源性疾病的发生至关重要。

（二）减少药源性疾病的伤害

1. 药源性疾病概念　药源性疾病（drug-induced disease）是指由于药物不当、用药不当（包括用药过量、用药不对症）、个体差异等原因所引起的疾病。药源性疾病可分为两大类：第一类是由于药物副作用、剂量过大导致的药理作用或由于药物相互作用引发的疾病。该类疾病可以预防，其危险性较低。第二类为过敏反应、变态反应或特异反应。这类疾病较难预防，其发生率较低但危害性很大，常可导致患者死亡。

2. 药源性疾病成因的伦理分析　药源性疾病已经成为一种新的流行病，而不合理用药、滥用药是导致药源性疾病的最主要原因。不合理用药和滥用药的问题已引起世界各国的关注，各国纷纷采取相应的措施，对药物的安全和疗效进行必要的监护，实际上滥用药物是一个重要的道德问题。引起药源性疾病的原因主要有以下三个方面。

（1）医师方面的原因：医师业务生疏、技术水平低、缺乏进取心、责任心不强是不合理用药、滥用药的根本原因。主要包括：①医师忽视患者用药史及特异体质；②忽视药物相互作用及配伍禁忌；③误用药物，如把无明确治疗目的的药物任意引进处方；④用药方法不当；⑤剂量不当；⑥用药种类过多。

（2）患者自身的原因：患者在遭受疾病痛苦的折磨时，常常寄希望于药物。但由于患者掌握的医药知识甚少，对药物的性能及毒害作用了解不够，往往会发生如下情形：一是乱吃药；二是迷信偏方，迷信进口药、昂贵药；三是不遵医嘱用药。

（3）社会及经济的原因：现行药政管理制度尚不完善、药物广告虚假宣传、医药商店不需处方就可随意买到药物、医院片面追求经济效益等是社会性药物滥用的原因。

无论药源性疾病的问题是由哪种原因引起的，归根到底，这并非单纯的技术、水平问题，更大程度上是一个复杂的伦理道德问题。

（三）避免过度医疗的伤害

1. 过度医疗的概念　过度医疗是指医疗机构及其医务人员在诊疗活动中，违反诊疗规范或超越疾病本身实际需要，故意实施的不必要的诊断、治疗行为或过程。它有两个基本特点：一是所实施的

诊疗项目对于该疾病是多余的、不必要的，甚至是有害的；二是作为一种行为或过程，不包括未成为实践的诊疗计划或设想。

以下行为不应视为过度医疗：①对于某些复杂和难以诊治的疾病，要求进行必要的重复检查才能确诊的治疗；②为抢救危重患者的生命，采取的某些可能不一定有实效和十分有把握的治疗；③在别无选择的情况下，为了探索其他有效的治疗方法而选用的某些试验性治疗；④为防范某些疾病传播或病情的扩大，避免更大的风险，对患者采取某些轻微的过度诊断或治疗；⑤当下虽没有疾病征兆，但为预防病症发生而采取的某些治疗；⑥疾病虽已治愈，但为了防止复发或预防某些并发症的产生而给予的治疗。

2. 过度医疗的伦理分析　过度医疗的形成与医疗保健服务的特点密切相关。例如：疾病发生发展及诊治效果的不确定性，增加了医患双方的风险防范意识；患方对医学知识的匮乏及其在医患关系中的被动地位，使其无法对医方进行有效的监督；医方作为医疗服务的提供者，又是医疗需求的决策者和实施人，有可能人为地制造医疗需求等。

过度医疗主要表现为以下情形：①对某种疾病的诊断措施超过了其实际需要，超越了学术界公认的可行的适宜的诊断方法和手段；②采用了超常规的、多余的、无效的，甚至有害的治疗方法和手段，如扩大手术指征和手术范围、放宽放疗和化疗的标准、盲目地采用生物治疗等；③诊治费用超过了医学界公认的诊治要求的一般标准；④超越了特定患者体力和财力的承受度；⑤对属于正常生理范围的现象，或虽有异常但这种异常可以通过自身调节很快得以恢复正常的现象进行医疗干预；⑥对某些死亡征兆已经很明显或死亡不可逆转的患者仍进行挽救生命的无效治疗等。

对过度医疗的理解，一般来说，需考虑以下因素：①医疗机构及其医务人员在诊疗活动中违反诊疗规范或超越疾病本身的需要，实施了不必要的检查和治疗；②对患者有损害，包括财产损害、人身伤害和精神损害；③过度医疗行为与患者损害之间存在因果关系；④医疗机构及其医务人员有主观故意，即明知医疗行为过度而仍然实施。

过度医疗不但增加了患者的经济负担，造成卫生资源的浪费，而且有可能给患者带来不应有的痛苦与不适，影响医疗机构的信誉，引发医患矛盾。

3. 过度医疗的伦理对策

（1）提升医务人员的医学道德素养：实施过度医疗与医务人员的医学道德素养存在着内在的必然联系。防范过度医疗的伦理对策应该从提升医务人员的医学道德素养入手，使医务人员诚信待患、以人为本，在实践中自觉杜绝过度医疗。

（2）加强对医务人员的道德评价和监管：医疗机构应该把医务人员的医德作为考核的重要指标，通过建立医务人员医德档案、公开评价指标和考核办法、自觉接受监督等方式不断强化对医务人员的评价和监管，打造一支医术高超、医学道德素养过硬的医疗队伍。

（3）强化医疗机构的社会公益责任：加强医疗机构社会公益责任的评价管理，使医疗机构能够及时发现自身在服务中存在的问题和不足，并针对现存的问题进行整改，确保医疗机构社会公益责任的有效落实。

（4）完善医疗监督体制机制：完善医疗监督体制机制要从明确监督主体、规范监督制度、落实监督职责等层面进行。

（四）避免无效治疗的伤害

1. 无效治疗的概念　无效治疗（futile treatment）是指在现有医学科学技术条件下已经失去治疗价值，不可能达到治疗目的的治疗措施和行为。

尽管医学进步很快，但人类对很多疾病仍然知之甚少，无效治疗的情况在医疗实践中仍屡见不鲜。无效治疗分为四类：①生理无效。即如果一种医疗干预不能达到预期的生理效果，那么，就可以判定此种医疗干预无效。例如，当心肺复苏不能使自主心搏恢复时，就是心肺复苏无效。②临床无效。即尽管对患者提供某种医疗干预，但患者还会在不久的将来（几天或者几周）死亡。例如，有些

心搏停止的患者在实施心肺复苏后虽能恢复自主心搏，但仍未能长期存活，则判定为心肺复苏无效。③致命性疾病无效。即患者所患疾病是致命性的，即使进行了医疗干预，患者也在不久（几周或者几个月，但不超过一年）死亡。例如，通过心肺复苏使晚期肝硬化患者恢复自主心搏，甚至可以出院，但其由肝病所决定的短期寿命不会改变，因为心肺复苏对晚期肝硬化不会产生任何效果，即心肺复苏无效。④质量无效。即如果医疗干预不能给予可接受的生命质量改善，那么，这种医疗干预就是无效的。例如，持续性植物状态患者获心肺复苏治疗后虽可长期存活，但这种生存状态仍不能为人们接受，仍属心肺复苏无效。

2. 无效治疗的伦理分析　临床上的无效治疗分为完全意义上的无效治疗与治病救人意义上的无效治疗。完全意义上的无效治疗指医方能够给予的旨在消除疾病、减少患者痛苦、促使恢复健康等所有的医疗措施都无实际意义，它是终止治疗、放弃治疗的医学前提。

无效治疗概念是针对过度治疗而提出的。在当代社会，医学伦理学界重视患者的自主权，认为只有患者或其代理人才有资格决定是否采用生命维持疗法。在此背景下，无效治疗概念应运而生，其主要目的在于对抗过度治疗现象，从而对医疗行为进行合理规范与引导。

医学伦理学界强调患者享有自主权，强调只有患者或其代理人才有权作出是否使用生命维持疗法的决定。提出并使用无效治疗概念在于克服过度治疗。

认定无效治疗的直接后果是临床医师将随之作出放弃治疗的选择。有关无效治疗的争论，就其根本来说，是医师是否有权单方面决定不给予患者某种特定治疗。

3. 无效治疗的伦理对策　首先，对医务人员、患者及其家属进行“优逝”教育。应从促进医务人员转变观念做起，树立“优逝”的理念，进而指导患者及其家属认识死亡权利、死亡标准和死亡尊严，放弃无效治疗并不是对患者不管不顾，而是调整治疗方向，采用安宁疗护的方式减少患者的痛苦，让患者有尊严地离开人世。其次，全面评估患者的具体病情。经上级医师或相关医疗组织认可，准确作出无效治疗的结论，防止任何差错的出现。再次，切实细致地做好与患者及其家属的沟通，力争得到患者及其家属的认同，做好患者及其家属的心理安抚，尽可能地提供各种非医疗的服务，减轻患者和家属的悲痛，警惕医患纠纷的发生。最后，医师应忠于医学科学，遵循患者利益第一的原则，不能因各种不纯动机向患者提供无效治疗。

（五）避免不合理的防御性医疗的伤害

1. 防御性医疗的概念　防御性医疗（defensive medicine）是指医务人员为降低医疗风险、减少风险责任、加强自我保护而对患者实施超出规范化诊疗常规的检查、诊断、治疗以及规避高危患者或高危诊疗程序的医疗行为。该行为作为一种诊疗过程，并非诊治疾病本身的需要，而是为构造一个完整的防御体系，以应付可能的医疗诉讼。防御性医疗行为受到公众普遍谴责，但又难以避免，可以分为两类。

第一类是积极型防御性医疗行为。表现形式是医师积极主动地为患者做各种各样非必要的检查、治疗或者邀请专家会诊，在实施医疗行为时，虽以客观的立场对待，但不轻易运用医疗干涉权加以必要合理的主观引导，甚至在知情同意的过程中，要求进行公证。

第二类为消极型防御性医疗行为。表现形式是医师对于有较大风险的危重患者，不采用实践已经成熟或正在成熟过程中的但可能具有一定风险的医疗技术，而是拒绝为他们治疗，积极主动为患者转院。

2. 防御性医疗的伦理分析　不可否认，为了避免可能发生的医患纠纷或医疗诉讼，医务人员会更加认真、仔细地记录病情，向患者做更详细的病情解释工作，筛选检查更为细致，做更多的审核工作，开展更多的患者满意活动。这些医疗行为有助于提高患者服务满意度和医疗质量，无疑将有益于患者的康复。但防御性医疗也会造成以下几个问题。

（1）患者会承受额外的医疗风险：任何医疗干预都对患者的身体具有一定的侵袭性，易导致对人体的损害。为防御性医疗而实施非必要的检查、治疗等往往给患者带来痛苦和压力。

（2）诊疗费用增加及资源不当使用：防御性医疗行为常导致有限的医疗卫生资源的严重浪费，增加医保和患者的负担，一定程度上又加剧了看病难、看病贵问题，从长远看，不利于卫生事业的健康发展。

（3）使医患关系雪上加霜：防御性医疗导致医务人员谨小慎微，为了减少麻烦，他们宁愿花费更多的时间去讲述治疗的副作用，宁愿告知患者最差的结果，让其作出最坏的打算。这会在一定程度上限制医师的思维，影响其发挥创造性，使诊疗工作变得机械、刻板，把临床变战场，人文关怀荡然无存，甚至把患者作为潜在的诉讼对象加以戒备。

（4）延缓医学的发展：防御性医疗回避了高风险的手术和其他治疗措施，不仅可能使某些危重患者丧失治疗机会，还阻碍了对某些疾病治疗的探索。

3. 防御性医疗的伦理对策

（1）加强医务人员职业道德教育：在临床实践中医师的职业道德尤为重要，应该教育医师具备抵制防御性医疗行为的意识和能力。

（2）提高医务人员科研技术水平：过硬的医疗技术是服务好患者的基础，也是有效减少防御性医疗的重要举措。医疗机构要提高医务人员参与科技创新的积极性，只有医疗技术水平的大力提升，获得社会的信任，才能从根本上消除防御性医疗行为。

（3）重建医患信任关系：沟通是重建医患信任关系的基础，有效的医患沟通可以避免大多数无谓的医患矛盾，缓解医师的压力，减少防御性医疗行为的发生。同时还要听取患者或家属的意见和建议，为他们解决困难，增强患者和家属对疾病治疗的信心和依从性，保证医疗工作的顺利进行。

（4）建立风险应对机制：医疗机构应建立健全内部责任督导及责任承担制度，将考核评价结果与劳动分配制度改革有机结合起来，通过制度的规范和职业道德约束，有效减少医师实施防御性医疗行为。

（六）避免医疗技术滥用的伤害

1. 医学技术滥用的概念　医学技术滥用（abuse of medical technology）是指不从疾病适应证的需要出发，不顾患者身体安全（包括远期效果）、不考虑患者的经济负担，过度、重复、超量使用技术的行为。

医学技术的发展给许多患者带来了福音与希望，对提高人类健康水平作出了贡献。高新科技迅猛发展并进入医学领域，源于医学对高新科技的巨大需要。但高新医学技术在使用过程中容易出现背离医学目的、道德失范的现象，即医疗技术的滥用。这种现象较为常见，比如抗生素、剖宫产、心脏支架、B超、CT等的滥用。医学技术滥用的表现主要有：①不按常规或不遵从一般规律使用医学技术，不从适应证的需要出发诊断和应用治疗技术，任意扩大技术的使用范围和提高技术使用的等级；②没有必要地重复多次使用高新技术设备；③滥用新药、进口药，没有必要地联合用药，滥用抗生素；④对没有手术指征或可不用手术治疗的患者使用手术治疗等。

2. 医学技术滥用的伦理问题

（1）由于医学技术的滥用，导致医疗费用迅速上涨，直接导致经济能力与巨额医药费之间的矛盾，加之一些医疗机构盲目追求经济收益，过度使用高新技术，加重了患者的经济负担，使医保和患者难以承受。

（2）医学高新技术的广泛使用，加剧了卫生资源分配不公。这促使医疗卫生资源迅速向大医院、大医疗中心集中，进一步扩大了地区、城乡和社会不同阶层在卫生保健条件方面的差距。

（3）增加了患者的痛苦，使得医源性、药源性疾病增加，给患者的健康带来不利的影响。

（4）使得一些医疗部门轻易地获取高额利润，由此极易滋生医疗腐败，导致医德滑坡，降低医疗部门的美誉度。

3. 医学技术滥用的伦理对策

（1）遵循最优化原则：严格掌握适应证，坚持科学标准，不随意扩大医学技术的使用范围。坚持

从病情出发，追求适应证最佳、手术最恰当、疗效最理想、损伤等副作用最小、费用较低，让绝大多数人看得上病、看得起病、看得好病，是医务人员使用医学技术最重要的目标。

（2）依法管理医疗技术：各级医院应有明确的分工和相应的技术建设标准，以制止盲目攀比医学技术的现象。应尽快完善有关医疗道德和科技伦理规范，防止利用医学技术搞创收。

（3）遵循知情同意原则：医务人员在制订诊疗决策时，应坚持由简到繁、由廉到贵的原则，避免不必要的检查。决定选用某种医疗高新技术之前，医师必须向患者及其家属说明情况，将该技术的必要性、使用过程及方法、有效性或成功率、副作用、所需费用等一一告知，让其自主选择。

（4）要避免技术依赖：医学技术广泛用于临床以后，医师越来越依赖高新技术和设备，同患者在心理、情感方面的交流愈来愈少，医患关系物化现象越来越严重，因此一定要克服对技术手段的完全依赖。

（七）正视放弃治疗

1. 放弃治疗概念　放弃治疗（withholding or withdrawing treatment）是指根据临床诊治标准，医师结合患者本人或其家属、代理人的意愿，对濒死患者或生命质量极低且不能恢复意识的患者，放弃人为延长生命的支持措施。放弃治疗包括最初不提供生命支持措施和提供后撤除支持措施两种情形，前者涉及应不应当提供，后者涉及应不应当撤除。

狭义上的放弃治疗包含两个最基本的方面：①放弃治疗的对象必须是不可治愈的濒死患者。这既包括那些经一切治疗措施都无法阻止其心跳、呼吸停止的患者，也包括那些心跳、呼吸虽未停止，但已不能恢复意识的患者；②不给予任何人为的维持生命的治疗，即不供给维持生命的营养和液体，这是不同于终止治疗的关键点，后者是不采取针对病因的根治性措施。

2. 放弃治疗的伦理问题

（1）放弃治疗权问题：生存作为人的基本的自然权利，同时也是一种义务，放弃治疗即意味着选择死亡，那么人有无放弃治疗的权利，医方有无权利执行放弃治疗，需探讨。

（2）条件限制问题：受医学科技发展水平的限制，以及医患双方在治疗期望、价值观念等方面的差异，对放弃治疗往往存在不同的看法和认识，甚至产生冲突。

（3）利益取舍问题：患方和医方对是否放弃治疗会有着不同的立场，甚至存在利益冲突。

（4）权利冲突问题：在选择是否放弃治疗时，患者的自主权与生命权、知情权与保密权、家属的代理权与患者的自主权、医方特殊干涉权与患者自主权之间等，都可能出现伦理冲突。例如，脑昏迷患者难以明确表达自己的意愿；重度残疾婴儿的个人意愿更无从谈起，如果代理人基于其自身利益而非患者的最佳利益作出放弃治疗的决定，医方总是难以处理。

3. 放弃治疗的伦理对策

（1）尊重患者的自主权：患者本人最终拥有是否放弃治疗的权利，对于无民事行为能力或限制民事行为能力患者，需要由其监护人或代理人履行其放弃治疗的权利。只有在医务人员作出符合放弃治疗的科学和伦理审查和评估后，才可由代理人决定是否同意实施。

（2）履行知情同意：履行放弃治疗的知情同意程序，只有签订知情同意书后，医师才能实施放弃治疗措施。医务人员应履行其告知义务，向患方详尽地、客观地介绍病情及各种可能发生的情况，帮助患方正确选择。

（3）明确适应证：只有符合以下条件的终末期患者才可以考虑放弃治疗。①患者处于持续无意识状态；②患者继续治疗的负担超过任何好处；③公认的科学数据提示成功复苏的机会相当渺茫。

第二节 | 临床诊断伦理

疾病的诊断是通过医师对患者进行病史采集、体格检查及各种辅助检查等方式，获得疾病相关资料后，分析、综合、归纳并形成对疾病的概括性判断的过程。在疾病诊断的过程中，医师需要具有精湛

的专业技能，还需严格遵守问诊、查体、辅助检查等环节的伦理要求。

一、问诊的伦理要求

问诊是医务人员用语言或非语言的方式与患者或相关人员进行有效沟通，以全面了解患者所患疾病的病史信息的方法。

1. 举止端庄，态度和蔼　问诊是医师接触患者的首要环节，是医患关系建立的开始。唐代名医孙思邈在《备急千金要方·大医精诚》里对医师的言行举止作出如下论述："夫大医之体，欲得澄神内视，望之俨然，宽裕汪汪，不皎不昧，省病诊疾，至意深心。"从大量的调查数据可以看出，患者对于衣着干净整洁、言谈举止得体、态度诚恳和蔼的医师信任感更强，更倾向于毫无保留地倾诉自己身体和心理层面的种种不适，甚至是个人隐私；而对不注重仪表、态度生硬的医师信任感降低，患者对涉及敏感的问题有可能不会如实回答，势必不利于之后的诊断和治疗。

2. 言语得体，通俗易懂　问诊是通过医患之间有目的的对话来获得疾病诊断的依据。作为医师，良好的专业技能固然重要，但恰当的言语沟通是准确诊断的基础，因此，医师需要根据患者的具体情况采用适中的语速和患者交流，太快的语速有时会让患者听不清楚问题，造成错误的回答，也会使患者产生不自主的焦虑；适中的语速既能够使患者听清问题，也能拉近医患关系，更利于医师充分获取疾病的信息。同时，医师要用通俗易懂的话语和患者交流，尤其对于老年人和医学常识欠缺的不同年龄阶段的患者，尽量避免使用医学专业词汇，建立起有效的沟通，才能顺利获得准确的信息。希波克拉底提出："医师有三大法宝，语言、药物和手术刀。"良好的语言不仅有利于疾病的诊断，也有利于医师与患者之间的有效沟通，更有利于患者的康复。

3. 专心倾听，正确引导　患者对病情的详细自述，是真实反映疾病变化过程的重要依据。医师耐心倾听患者的病史叙述，并能够及时给予回应，对于重点关注的细节给予适当的引导，这不仅是尊重患者，也是明确其疾病发生发展的全过程，这对于后续的诊治有着重要作用。如果患者的叙述脱离了病情主题，医师可以礼貌地提醒患者回到主题，这样可以节约时间，提高效率，但要避免暗示或诱导。

二、体格检查的伦理要求

体格检查是指医师运用自己的感觉器官和简便的诊断工具对患者的身体形态结构和功能发展水平进行检查，是简便实用、应用广泛、行之有效的诊断方法，是诊断的重要环节。在体格检查中，医师应遵循以下伦理要求：

1. 全面系统，认真细致　在体格检查过程中，医师应根据患者情况按照一定的顺序进行详细的系统检查，不遗漏任何部位，对于重点部位、可疑体征，要反复检查或请上级医师核查，做到认真细致、一丝不苟。对于急危重患者，尤其是昏迷患者，可以重点检查，待病情稳定后再进行补充检查。

2. 尊重患者，保护隐私　在体格检查中，医师势必需要接触患者身体部位，医师应当尊重患者，在检查前充分地告知患者检查的必要性，征得同意后依次暴露和检查所需部位。需要暴露和检查患者隐私部位时，应尽可能做到遮掩；在检查异性患者时态度要庄重，切忌有轻浮的语言或表情，还应有家属或第三者在场，以免发生不必要的误解。

3. 力求舒适，减少痛苦　体格检查可能会带给患者一定的不适甚至痛苦，医师在检查时应关心体贴、手法轻柔，以减轻患者的痛苦。在触诊疼痛敏感部位时要用语言转移患者的注意力，边检查边安慰，获取阳性体征后马上停止，减少患者不必要的痛苦。室内温度较低时应注意保暖，尽量少地暴露患者的体表部位，触诊、听诊前应先把手和听诊器捂暖再接触患者的身体。

三、辅助检查应用的伦理要求

辅助检查包括实验室检查和特殊检查，是指借助化学试剂、仪器设备及生物技术等手段进行检查

和辅助诊断的方法。辅助检查能够更大程度地提供诊断证据，有时甚至是决定性证据，但是同时实施多项辅助检查一般会增加患者的经济负担，有创检查还会给患者带来痛苦。在辅助检查中应该遵循以下伦理要求。

1. 合理选择，充分告知　医师在选择辅助检查时，应该充分考虑可能会给患者带来的各种后果。医师应该正确选择那些对诊断有必要的辅助检查项目，而不能做“撒网式”检查。另外，医师在选择辅助检查时，一定要按照知情同意程序，允许患者自主决定是否采取该种检查措施。对起决定性诊断作用的辅助检查项目，若患者拒绝，医务人员切不可强行使用，要做好解释、劝导工作。

2. 爱护患者，减轻痛苦　辅助检查的选取原则一般为：简易的检查先于复杂的检查；无创检查先于有创检查；低廉的检查先于昂贵的检查。在明确诊断的前提下，可选择简单的检查，尽量不选择复杂的检查；无创检查可以达到目的就避免做有创检查；尽量减少患者的经济负担。这既是医疗诊断的需要，也是尽量减少患者痛苦、合理利用有限卫生资源的需要。对于会引起患者不适的辅助检查项目，医师应该尽量做到操作轻柔，谨慎处置，并要做好安全保护，不能让患者在遭受病痛折磨的同时，再遭受医疗器械的折磨。

3. 综合分析，加强协作　为了避免辅助检查的局限性，需要从疾病的各个角度出发进行分析，这就要求医师对各种辅助检查的结果和患者的病史、体格检查的资料综合分析，才能作出正确的诊断，切忌片面夸大辅助检查的诊断价值。同时临床医师应当加强同医技人员之间的相互协作，共同完成对患者的诊断。如果辅助检查与临床检查出现不一致的地方，双方应当积极沟通，通过讨论达成共识，最终作出准确的临床诊断。

第三节 | 临床治疗伦理

临床治疗是指医师通过药物、手术、心理、康复及饮食营养治疗等方法，帮助患者恢复身体和心理健康的医学过程。临床治疗是临床工作的核心，也是临床工作的最终目标。临床治疗伦理贯穿于治疗过程的各个环节，严格遵循临床治疗伦理要求对治疗目标的实现具有重要的意义。

一、药物治疗的伦理要求

1. 对症下药，安全有效　16世纪瑞士医师帕拉塞尔苏斯（Paracelsus）说过：“所有物质都是毒物，非毒物是不存在的，只是剂量大小区分是毒物还是药物。”在药物治疗中，医师应根据临床诊断及患者病情需要，选择对应的药物进行治疗，即所谓的对症下药。医师既要综合考虑药物的性能、适应证和禁忌证，做到对症用药、合理配伍，又要根据疾病的种类、病程、患者的个体差异而使用不同的药物和剂量，力求在安全的前提下，用最少的种类及剂量达到治疗目的。对诊断不明确的患者应避免滥用药物；严格掌握抗生素的使用指征，避免滥用造成耐药性及毒副作用；坚决杜绝为追求经济效益使用大处方、大包围治疗。

2. 合理配伍，细致观察　适当的药物联合治疗，可以克服单一药物的不足，从而使药物治疗发挥最大的效应。在联合用药时，要注意药物的合理配伍，不能违反配伍禁忌，避免增加毒副作用或减弱治疗作用等。为达到合理配伍，首先要掌握药物的配伍禁忌，其次要限制药物的种类、数量和剂量。在用药过程中，不管是联合或单独用药，都应细致观察，随时发现用药过程中出现的各种不良情况，以便及时调整。

3. 节约费用，减轻负担　医师在选择药物治疗时，要充分考虑到药物治疗可能给患者带来的经济负担，在力争达到治疗目的的前提下尽量使用常用药、国产药，尽量不用贵重药、进口药，这也将影响患者对治疗药物的依从性。

4. 特殊药品，充分告知　如治疗某些疾病必须使用毒副作用大、价格昂贵的特殊药品，这时必须充分告知患者及其家属药物使用的必要性、可能出现的严重副作用及具体经济负担，必要时签署知情

NOTES

同意书，在患者充分知晓的情况下谨慎选择此类特殊药品。

二、手术治疗的伦理要求

手术治疗是临床治疗中一种重要的治疗方法。患者接受手术治疗是在疾病风险大于手术本身风险的前提下所作出的选择，其对手术本身的破坏性、手术过程中可能出现的风险性以及手术后可能出现的健康问题难免存在焦虑和紧张情绪。这些客观和主观因素，决定了在选择手术诊疗时会遇到更具体的伦理问题，需要更详细的伦理理论指导和规范要求。手术前、手术中和手术后各有不同伦理要求。

1. 术前全面评估，认真准备

（1）评估手术必要性：医师应根据患者的病情和手术特点，对手术治疗与保守治疗、创伤代价与手术效果进行全面的权衡。由于手术具有损伤性、风险性等特点，医务人员在选择治疗方案时，必须把患者的健康利益放在首位，严格掌握手术指征。当不同医师对治疗方案存在分歧时应当及时会诊，集体论证手术的必要性。可做可不做的手术、无治愈希望的手术、不具备手术条件等情况下不宜选择手术治疗，任何以经济利益为目的的手术治疗都是违背医学道德的。

（2）充分沟通，知情同意：在确定采用手术治疗时，医师必须与患者或家属充分沟通，获得知情同意。医师需客观地告知患者或家属手术治疗的必要性、术中可能出现的风险、术后可能的并发症、手术治疗的预后等情况，并和患者或家属进行充分的讨论，确定其对手术相关情况全部理解。在患者知情的基础上，医师应充分尊重患者的选择，保护患者的利益，患者或家属同意并在手术同意书上签字后，方可进行手术。在特殊状况下，如需要紧急手术治疗的昏迷患者无法及时联系到家属时，可按照相关规定，经批准后进行救治，但应做好相关的记录备查。

2. 术中认真负责，严格规范操作

（1）敬畏生命，认真负责：参与手术的医务人员都应秉持敬畏生命的理念，认真负责地进行麻醉、手术及护理，对于意识清醒的患者应给予安慰并告知手术进展情况。在手术全过程中考虑各个环节，遵守无菌操作规程，术中急救器械和药品应当准备齐全、位置固定、标签清晰，手术缝合前认真清点纱布、器械，注意观察患者术中生命体征变化等，避免差错。

（2）精神集中，处置果断：手术治疗具有高风险性及有创性等特点，医师应当在术中保持精神高度集中，全面观察手术视野中各种情况及生命体征，对可能发生的意外做好应对准备。如果术中遇到突发情况，手术医师、麻醉医师要保持镇定、果断处置，遇到疑难问题应紧急通知相关科室会诊。

（3）密切配合，相互协作：手术治疗是一个复杂的过程，是手术医师、麻醉医师、器械护士、巡回护士等医务人员共同实施的综合技术活动，需要团队成员各司其职方能完成。麻醉医师应认真监测患者各项生命体征，及时告知手术医师患者各项指标变化；器械护士应及时提供合适的手术器械，相互配合，共同保证手术的顺利进行。

3. 术后严密观察，促进康复

（1）严密观察，精心护理：医护人员在术后应严密观察患者各项体征变化，精心护理，避免发生各种术后并发症，发现异常情况及时处理，尽可能减少或避免术后可能发生的意外。

（2）人文关怀，促进康复：患者术后不仅经历了手术创伤，还经历了心理应激，常常会出现各种躯体、心理上的各种不适，医务人员应加强人文关怀，给予患者足够的心理照顾，尽早开始康复治疗，争取让患者早日恢复。

三、心理治疗的伦理要求

心理治疗（psychotherapy）是运用心理学的方法，通过语言或非语言因素，对患者进行训练、教育和治疗，以减轻或消除身体的症状，改善心理精神状态，适应家庭、社会和工作环境。在心理治疗中，应遵循以下伦理要求。

（一）尊重患者，建立信任

心理医师应该充分尊重每一位患者，杜绝任何形式的歧视，包括种族、民族、肤色、宗教、职业、性取向、血缘或者生理缺陷等。在尊重患者的知情同意权及决定权的前提下，患者才会坦诚地与医师进行良好的沟通，积极配合治疗，医患之间才能建立良好互信的关系，这也是心理治疗成功的关键。

1. 尊重患者的知情同意权　心理治疗的第一步是获得患者对治疗的知情同意，心理医师有义务告知患者以下情况：咨询的特点、性质、预期疗程、费用、保密范围等，如果来访者是在没有被充分告知的情况下作出的知情同意，在法律上被视为无效同意。

2. 尊重患者的决定权　患者有权决定是否接受评估和治疗，是立即开始还是稍后进行，有权改变治疗方法或者终止治疗。来访患者的性别、民族、国籍、宗教信仰、价值观、性取向等因素不影响心理医师对患者的治疗。对于与自己有着不同的社会文化背景和价值观念的来访者，心理医师必须充分认识、接纳和尊重他们的社会文化、经济背景和价值取向，避免把自己的价值观和看法强加给来访者；心理医师不应以自己的社会文化和经济背景来开展工作，在制订治疗方案时先入为主，影响、干扰或者试图改变来访者的自主选择；当治疗师不能接受来访患者的个人文化和价值观念时，应将患者转诊，以免耽误治疗时机、影响治疗效果。

（二）客观评估，科学治疗

心理治疗有其科学的理论基础。在心理治疗过程中，心理医师要将扎实的理论充分运用到实践中，用规范、恰当、系统的方法为患者开展治疗。要客观地评估患者心理状况，避免将自己个人的意识和情绪掺杂进治疗过程。应以冷静、理智、清晰的态度帮助患者作出适当的调整与改变，以达到心理治疗的目的。

1. 运用心理治疗的知识和技巧开导患者　对于任何一个来访患者，心理咨询与治疗师都必须采用规范、恰当、系统的程序和方法，并严格按照这些程序和方法开展治疗工作。只有通过规范作业才能避免出现临床伦理问题。只有熟练掌握了心理治疗的知识，才能在与患者的交谈中了解心理疾病的发生、发展机制，从而作出正确的诊断。只有熟练掌握了心理治疗的技巧，才能在诊断的基础上，有针对性地进行相应治疗，并取得较好的效果。

2. 以专业的态度处理与咨询者或患者之间的专业关系　心理医师不得与来访患者发生任何形式的亲密关系。如果建立的专业关系超越了专业界限，应立即终止专业关系并采取适当措施，例如寻求同行的建议。

3. 关注患者的同时更应关注自我保健　心理咨询和治疗是一种情绪劳动，个人内在环境很容易受到来访者的情绪感染和干扰。当意识到个人的生理或心理可能受到了来访者的影响并对来访患者造成伤害时，应寻求其他专业人员的帮助，警惕自己的问题对服务对象造成负面影响的可能性；必要时应限制、中断或终止临床专业服务。

（三）保护隐私，严格保密

在心理治疗过程中，对于患者一切可识别的信息，特别是患者的治疗记录和其他相关资料，都应保密。在未获得患者的知情同意或者授权时，心理医师不应与第三方分享处于保密状态的患者信息，甚至是对患者父母、配偶都需要保密。当遇到特殊情况，如有证据表明患者可能会对自身或对他人构成人身威胁时，心理医师可以转告家属或他人，以履行其对于患者的责任以及肩负的社会责任。

1. 保护患者隐私　在心理治疗过程中，不可避免地会涉及患者的隐私，而且诊疗本身可能就是隐私的一部分。因此，保护隐私在心理治疗临床实践中显得尤为重要。患者向心理医师倾诉的信息，特别是秘密或隐私，不能泄露，甚至对患者的父母、配偶也要保密，否则会失去患者的信任，使心理治疗难以继续进行下去。心理医师有责任保护来访患者的隐私，但是同时也要认识到保密要求在内容和范围上受到法律和专业伦理规范的限制。

心理医师应清楚地了解保密要求有限度，在以下情况发生时保密将不会受限：患者有伤害自身或伤害他人的严重危险时、患者有致命的传染病等且可能危及他人时、未成年人在受到性侵犯或虐待时、患者行为违反法律时等，在这些情况下，医务人员可以在患者事先知情的情况下，转告其家人或他人。在通常情况下，患者能理解医务人员的行为是出于保护自己或他人的生命，其行为是符合医德要求的。

2. 医学科研需要的隐私保护　对于心理诊疗过程中涉及的内容，例如心理咨询或在治疗过程进行录音、录像或演示等，心理医师只有在得到患者的书面同意时，才能进行相应的处理或应用。因研究或教学工作需要，心理医师对心理咨询或治疗的案例进行讨论，或采用案例进行教学、科研、写作等工作时，应隐去可能会识别出患者身份的有关信息。

3. 青少年心理咨询的特殊要求　在青少年心理咨询中，除了需要向青少年来访者解释保密的伦理要求外，也需要对其监护人进行解释和介绍，并对保密事宜作清晰详尽的说明，以确保各方对保密有同样的理解，有利于来访者配合咨询和治疗。

四、康复治疗的伦理要求

康复治疗的伦理要求与医学康复中存在的伦理问题密切相关，如何针对特定的患者制订个性化的康复方案，如何借助专业康复团队和患者家庭成员的共同协作，实现对不同康复程度患者的帮助，需要遵守以下伦理要求。

1. 理解尊重，平等相待　需要康复治疗的患者，常常会因躯体的功能障碍，伴随着不同程度的自卑、悲观、失望、敏感、多疑等心理问题，医师需要面对并重视患者的这种双重创伤。康复医师要给予患者充分的理解与同情，尊重他们的人格与尊严，建立和谐的医患关系，鼓励患者积极主动参与治疗。

2. 坚持治疗，加强指导　康复治疗一般来说是长期的过程，由于康复医师进行治疗的时间有限，因此应指导患者实施自我康复治疗或指导家属在日常生活中帮助患者进行康复治疗。康复医师应鼓励患者坚持治疗，并加强对患者及其家属的康复知识教育、康复方法与行为训练，全程指导患者的康复治疗。

3. 热情关怀，耐心帮助　患者由于身体功能障碍，在日常生活中会遇到常人难以想象的困难。康复医师应在生活细节上给予患者关怀和帮助，在治疗过程中对他们一点一滴的进步随时加以鼓励，增强患者战胜疾病的信心。对待短期效果不理想的患者，康复医师需要耐心引导，避免向患者或家属传递消极情绪，影响患者治疗的信心。

思考题

1. 临床医学伦理有哪些一般原则？
2. 体格检查中要求遵循的伦理规范有哪些？
3. 手术前要求遵循的伦理规范有哪些？
4. 2023 年 4 月，患者韩某，男，59 岁，以腹泻、呕吐收治入院，入院后完善相关检查，诊断为肝癌晚期，已经不符合手术指征。在等待制订化疗方案的时候，患者突发肝癌结节破裂，大出血不止。患者的子女面对毫不知情的父亲束手无策，只能苦苦哀求主管医师，请求进行介入治疗。虽然患者已经不太符合介入治疗的指征，且即便是介入治疗也是杯水车薪，何况介入治疗的费用对这个普通家庭来说，并不是小数，很可能最终人财两空，但是看到出血不止的患者，面对苦苦哀求的家属，医师还是决定背水一战。手术情况和预想的一样，患者的肿瘤结节已经引起

了很明显的周围粘连，在射线显影下，出血点仍然难觅踪迹。手术已经进行了将近2小时，然而手术部位还没有明确。不得已，医师只能将所有可能出血的部位都进行了修补，反复观察半小时，未见患者有呕血、便血，宣布手术结束。回到病房，患者平稳了两小时，之后又呕血不止。事实证明，手术彻底失败。

请运用临床医学伦理一般原则、临床治疗的伦理要求对该案例进行解析。

（巩守平）

第九章 生育政策与生殖技术伦理

本章数字资源

生育和生殖虽然是个人行为，但是具有一定的社会效应。因此，生育和生殖又是社会问题，人的生育和社会的人口问题都与医学关系密切，医学干预和辅助生殖技术的发展改变了人类的自然生育规律并影响了社会的人口变化，从而成为一个医学伦理问题。

第一节 | 生育政策伦理

随着我国人口形势的发展与变化，生育政策不断更新完善。我国曾经通过计划生育政策落实生育控制，促进人口长期均衡发展，避免人口无限增长。而近年来，生育支持政策体系的建立逐步成为当前我国人口发展和生育政策修订的工作重点之一。

一、生育政策概述

（一）生育控制和积极生育

18 世纪末至 19 世纪初，欧洲进入人口快速增长期，出现了就业压力及城市贫困人口增多等现象，“生育控制（birth control）”思想在这一背景下产生。1798 年，英国经济学家马尔萨斯（Malthus）在《人口原理》一书中提出了“生育控制”的思想。生育控制，即依据社会经济发展的客观要求，由政府对生育的数量进行预先设计，从而有计划地控制人口增长。20 世纪初，美国学者玛格丽特·桑格（Margaret Sanger）推动了节育思想的广泛传播，在此影响下，绝大部分发展中国家和部分发达国家实施了控制人口增长的生育政策，如印度、英国、日本等国先后开展大规模的节育运动。

“生育控制”的实现很大程度上依赖于家庭生育决策。家庭内部的生育计划被称为“家庭计划”（family planning），即以家庭为单位，由夫妇自主决定生育子女的数量和生育间隔，由政府或家庭计划生育机构提供指导和适当的辅助措施。尽管实施了“家庭计划”，由于缺乏有效的避孕知识和方法，仍有很多妇女非意愿妊娠，产下计划外的子女，导致家庭子女数过多。

我国的人口和生育政策包括控制人口数量和提高人口质量，该政策的重点随社会发展变化而调整，即由控制人口数量逐步转向提高人口质量，由生育调节逐步转向以生殖健康服务为中心。

近年来，我国人口发展逐步呈现少子化、老龄化等趋势性特征。为促进人口长期均衡发展，我国不断优化生育政策，全面实施一对夫妻可以生育三个子女政策，积极落实生育支持措施，建设生育友好型社会。

（二）我国的生育政策演变

中华人民共和国成立后，我国人口迎来了高速增长期。1949 年到 1970 年，全国人口由 5.4 亿人增长到 8.3 亿人。为应对人口过快增长给经济社会发展带来的压力，我国于 1978 年修订并实施的《中华人民共和国宪法》第五十三条规定：“国家提倡和推行计划生育。”计划生育第一次载入我国宪法。随后各项政策和倡议陆续提出，鼓励每对夫妇生育一名子女。2018 年 3 月 11 日，第十三届全国人民代表大会第一次会议通过《中华人民共和国宪法修正案》，其中第四十九条保留了“夫妻双方有实行计划生育的义务”。

计划生育的实施，有效控制了人口过快增长的势头，创造了较长的人口红利期。进入 21 世纪后，长期的低生育率导致的人口结构性问题等开始显现，于是我国开始逐步探索两孩生育政策。2013 年

12月，中共中央、国务院印发《关于调整完善生育政策的意见》，启动实施一方是独生子女的夫妇可生育两个孩子的政策，即单独两孩政策。2015年10月，党的十八届五中全会作出全面实施一对夫妇可以生育两个孩子的重大决策，即全面两孩政策。

2021年6月，《中共中央 国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》颁布，启动实施一对夫妻可以生育三个子女政策。2021年8月，第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修正《中华人民共和国人口与计划生育法》，其中第十八条规定："国家提倡适龄婚育、优生优育。一对夫妻可以生育三个子女。"三孩政策正式入法。

从只生一个好到全面三孩，党和国家始终坚持人口与发展综合决策，即根据我国人口发展变化形势适时调整生育政策。现阶段，我国正着力落实积极生育政策，加快建立生育支持政策体系，降低生育、养育、教育成本，推动构建生育友好型社会，为实现适度生育、促进人口长期均衡发展提供有力支撑。

（三）生育政策的伦理依据

1. 科学的人口理论支持计划生育　人口理论是解释和说明人口现象、人口过程和人口规律的学说体系。马克思主义人口理论，把人口现象、人口过程和人口规律放在生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的客观矛盾中加以考虑和研究，形成了科学的人口观，它是我们制定生育政策的主要伦理依据，其内容主要有以下几个方面：①"两种生产"理论，即物质生产和人口生产；②社会生产方式决定人口发展的观点；③人口对社会发展发挥作用的观点。马克思主义人口理论为生育控制提供了有力的科学支撑，这也是我国制定人口和生育政策的理论基础之一。

2. 应对人口形势变化　第七次人口普查数据显示，我国大陆地区60岁及以上人口达到2.64亿人，占比达18.70%。根据国家统计局发布的《中华人民共和国2023年国民经济和社会发展统计公报》，2023年我国全年出生人口902万人，人口出生率为6.39‰。出生人口为1978年以来的最低值，人口发展呈现少子化、老龄化的特征。为促进人口均衡发展，2021年，我国实施全面三孩生育政策，即一对夫妻可以生育三个子女，这成为生育政策调整的一项重要举措。

3. 促进人口长期高质量均衡发展　现实生活中，先天性疾病、遗传性疾病威胁着不少家庭和人群。我国每年出生的先天残疾儿童数量高达80万～120万，有必要采取适当的生育控制措施提高人口质量，这不仅关系到家庭幸福，还关系到国家富强和民族繁荣，符合人类生存质量的要求。

4. 医学科学的发展为生育控制提供技术支持　医学科学的发展，为人类的生育控制提供了大量有效、实用的技术手段，为人口数量控制与质量提高提供可能。20世纪中叶以前，由于医学发展的局限，人们只能采用人工流产等办法来进行生育控制。随着避孕和绝育技术的运用，医学科学技术在控制人口增长上起到了重要作用。积极发挥医学技术在节育优育中的正面作用也是医学自身价值的体现。

二、生育控制措施伦理

（一）避孕及其伦理

避孕（contraception）是指基于社会和个人的某些医学或非医学需要，运用一定的技术或方法防止怀孕的一系列措施。

避孕主要有两类方法：一类是自然控制法，即根据女性生殖系统周期性的生理变化，避开排卵期而行性生活，以达到避孕目的；另一类是人工控制法，即通过口服避孕药、使用避孕套、放置阴道避孕环等达到避孕目的。避孕是人类控制生育的重要手段，已经为人们普遍接受，但同时也引发了一些伦理争议。

1. 避孕将"性"与"生殖"分离开是否应该　传统的反对避孕者认为，避孕切断了性交与生殖之间自然而神圣的联系，是不道德的，性的目的是生殖。支持避孕者认为，尽管生育是婚姻和性生活的结果，却不是其唯一目的，婚姻和性生活的目的是多方面的，而且是否避孕也是人们的自主权。

2. 避孕是否会导致性行为的混乱　反对避孕的观点认为，广泛使用便利、经济的避孕工具，会导致人们在性生活上的“滥交”，引起性关系混乱以及婚姻、家庭关系的破裂。支持避孕者认为，人们应从社会环境、文化氛围以及人们的生理、心理的变化中去寻找性关系混乱的根本原因，而不应归咎于避孕技术的应用和推广。加强青少年的性健康教育，进行正确的道德观念引导，建立相应的道德与法律规范，对于避免性关系混乱是最重要的。

（二）人工流产及其伦理

人工流产（induced abortion）是指以人工手段有意终止妊娠。一般可以分为治疗性人工流产和非治疗性人工流产。前者通常是因为孕妇患有某种疾病不能继续妊娠或因妊娠危及孕妇的生命健康而终止妊娠；后者涉及的原因较多，例如在妊娠期胎儿被诊断出患遗传性疾病或胎儿畸形等。人工流产只能作为节制生育的补救手段，生育控制主要依靠的措施应是避孕。

人工流产争论的焦点在于“胎儿是不是人”，或者说，“胎儿什么时候才具备和在多大程度上拥有了人的权利”。支持者的观点认为受精卵、胚胎和胎儿尽管是生命，但还不是人，因而人工流产在伦理上可以接受。人们为了更大的价值，例如母亲的生命和健康、避免缺陷儿的诞生等，进行人工流产，这也是孕妇的权利。反对人工流产的观点认为胎儿就是人，任何形式的人工流产都是不道德的。此外，随着“受精卵—胚胎—胎儿”的发育进程，人工流产也必须受到一定的限制。我国在贯彻实施计划生育政策和具体措施时，也严格禁止大月份胎儿的引产。

（三）绝育及其伦理

绝育（sterilization）是指用手术等医学方法使人长久或永久失去生育能力。其方法通常是对男性输精管或女性输卵管进行切断、结扎、电凝或环夹等，阻止精子与卵子相遇。绝育的目的包括治疗、避孕、控制人口的社会需要、优生等。

一般来说，如果患有某种疾病，怀孕会给妇女及胎儿带来严重伤害，在获得夫妇知情同意的情况下，通过绝育避免怀孕是合乎伦理的；出于控制人口的社会需要和夫妇避孕的需要，夫妇自主选择绝育也是能够得到伦理辩护的；但为了消极优生而强制痴呆、智力障碍的人绝育，则存在很大的伦理争议。患有严重的遗传性疾病的人群，既难以保障后代的健康和正常成长，给父母、家庭带来沉重的负担，也不利于整个社会人口质量的提高。应该通过健康教育来帮助个人、家庭作出理性的决定，由他们自行选择，强制绝育的做法是难以得到伦理辩护的。

三、生育控制伦理原则

生育控制是人类对自身的生育权利从自然选择转向人工选择的开端，这不仅仅是一个单纯的技术问题，也是一个伦理问题，影响到生命的延续、家庭的稳固、社会的发展、国家的兴旺和人类的进步。因此，在生育控制中应遵循一定的伦理原则。

1. 有利原则　生育控制应有利于育龄男女的身心健康，有利于人的全面发展，有利于家庭的幸福和生活质量的提高。

2. 尊重原则　人不仅仅是生育控制的对象，也是生育控制的主体。在生育控制中要将人本身看作目的，而不是将她或他仅仅当作达到其他目的的手段。因此要尊重女性和男性在生育问题上的自主权。

3. 公正原则　应公正地对待所有育龄女性和男性，而不能因性别、年龄、民族、社会地位、经济状况、文化程度及其他方面的不同而在提供服务方面有所区别。

4. 公益原则　生育控制的根本目的在于提高人类的生育质量和人口素质，避免人口压力过大及其带来的社会问题。需要个人为集体、社会利益作出一定的牺牲，医务人员必须严格贯彻执行国家人口和计划生育法律法规，不能使用各种违反伦理、法律的生育控制手段。

5. 不伤害原则　在实施生育控制过程中坚决杜绝有意伤害和责任伤害，防范无意但可知的伤害，把可控伤害降到最低程度；不滥用辅助检查、药物，不随意实施手术。

第二节 | 优生优育伦理

优生优育有利于提高人口质量，节约社会资源，促进家庭幸福。生育保健、产前诊断、遗传咨询等现代医学技术的发展使优生优育成为可能，但也应警惕可能导致的种族歧视、基因控制等潜在问题。

一、优生及其伦理价值

（一）优生概述

优生（healthy birth）是指通过医学手段改良人的遗传素质、提高人的体力和智力水平的生育措施。优生分为消极优生和积极优生，前者又称预防性优生，是指防止有遗传性疾病和先天性缺陷的个体出生；后者又称演进性优生，是指促使体力、智力更加优秀的个体出生。

1883 年，受查尔斯·罗伯特·达尔文（Charles Robert Darwin）的进化论和格雷戈尔·约翰·孟德尔（Gregor Johann Mendel）的遗传学的启发，英国人弗朗西斯·高尔顿（Francis Galton）在《人类的才能及其发展研究》一书中，着重阐述了个体差异，从遗传的角度研究个体差异形成的原因，正式提出了优生学说。20 世纪初出现的国际性优生运动，引发了很多社会问题。

从 20 世纪 50 年代开始，优生优育思想进入了新的发展阶段，许多国家开展优生优育工作，制定优生法律。“提高人口素质”是我国人口政策中关于优生的重要内容之一，《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国母婴保健法》和《婚姻登记条例》等法律法规中均有涉及优生的重要规定。

（二）优生的伦理价值

1. 有利于提高人口身体素质　中国残疾人联合会 2021 年发布的统计报告显示，我国残疾人总数已超 8 500 万人。造成残疾的主要原因之一是遗传性疾病代际遗传。在严峻的人口素质形势下，应该通过结婚管理、生育控制、生育保健等优生措施，提高人口素质。

2. 有利于节约有限的社会资源　开展优生工作，可以最大限度避免和减少先天性缺陷和遗传性疾病婴儿的出生，以减少相关抚养费用，有利于节约大量有限的社会资源，创造更多的社会财富。

3. 有利于家庭幸福　健康是最大的幸福，优生可以使每一个家庭更幸福、美满。通过优生优育最大限度地避免残障婴儿出生，无疑有利于这些家庭的幸福。

（三）优生的伦理争议

1. 优生给人类带来的不一定是好处　优生的目的在于增加人类“好”的基因，减少“不好”的基因。但是，“什么是‘好’的基因”本身就是一个问题。例如镰状细胞贫血患者为致病基因纯合子，但该基因的杂合子携带者更易在疟疾流行的环境中生存。可见，一些所谓的“坏”基因也不是一无是处。甚至有人认为优生给人类带来的不一定是好处。

2. 优生政策是否是对个人生育权利的过度干预　优生是一种社会政策，而生育是每一个人的权利，社会公众的优生选择往往受优生舆论的影响。因此，有人认为优生政策是社会对个人行为的过度干预，限制了人们应有的自由和权利。例如 1931 年前后，美国超过 30 个州通过了强制绝育措施，对象包括“身心有缺陷者”“性反常者”“瘾君子”“酒鬼”等，这样的优生措施变成了处罚和遗弃社会边缘人群及患者的工具。

二、优生措施及其伦理

（一）消极优生措施及其伦理

1. 结婚管理　根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国母婴保健法》和原卫生部《异常情况的分类指导标准（试行）》等规定，结婚管理措施分为两类。一是禁止结婚。《中华人民共和国民法典》规定，直系血亲或者三代以内的旁系血亲禁止结婚。一方患有重大疾病的，应当在结婚登记前

如实告知另一方；不如实告知的，另一方可以向人民法院请求撤销婚姻。在司法实践中，重大疾病的判定一般参考《中华人民共和国母婴保健法》的规定，主要包括：①严重遗传性疾病，是指由于遗传因素先天形成，患者全部或者部分丧失自主生活能力，后代再现风险高，医学上认为不宜生育的遗传性疾病；②指定传染病，是指艾滋病、淋病、梅毒、麻风病以及医学上认为影响结婚和生育的其他传染病；③有关精神病，是指精神分裂症、躁狂抑郁型精神病以及其他重型精神病。二是暂缓结婚。《中华人民共和国母婴保健法》规定，经婚前医学检查，对患指定传染病在传染期内或者有关精神病在发病期内的，医师应当提出医学意见，准备结婚的男女双方应当暂缓结婚。

2. 生育控制　根据《异常情况的分类指导标准（试行）》等规定，生育管理措施分为两类：一是可以结婚但禁止生育。包括男女任何一方患有严重的常染色体显性遗传病、婚配双方患有相同的严重染色体隐性遗传病、婚配的任何一方患有多基因病等情况，因为这些男女的后代很可能显现这些疾病，所以可以结婚但应禁止生育。二是可以结婚但限制生育。例如严重的性连锁隐性遗传病（指血友病、进行性肌营养不良），女性携带者与正常男性婚配，应做产前诊断后决定是否保留胎儿。

3. 生育保健　生育保健措施主要分为两个时间段，即婚前孕前和孕产期。婚前孕前保健包括婚前卫生指导、卫生咨询和医学检查等服务内容。例如对准备结婚的男女双方进行关于性卫生知识、生育知识和遗传病知识的宣传教育；提供有关婚配、卫生保健等问题的医学意见；对于可能影响生育的疾病，例如严重遗传性疾病、指定传染病和有关精神病等进行检查，并提出医学意见，采取相应的措施。

孕产期保健包括对孕育健康后代以及严重遗传性疾病和碘缺乏病的发病原因、治疗和预防提供医学意见，为孕妇、产妇提供卫生、营养、心理等方面的咨询和指导，以及产前定期检查，监护胎儿的生长发育，提供咨询和医学指导等。

4. 遗传咨询　遗传咨询是指应求询者的要求，咨询医师提供给求询者或其家庭成员的有关罹患遗传病的信息和知识，以便求询者自主决定采取有关消极优生措施。其目的不是治疗疾病，而是提供有关的遗传信息，而这些信息对于求询者作出有关优生决定是至关重要的。遗传咨询引发的伦理问题主要有以下几个方面。

第一，各方利益的平衡。遗传咨询之后作出的决定涉及夫妇、未出生孩子以及其他家庭成员的利益。由于未出生孩子的利益是潜在的，咨询后的决定直接涉及夫妇的利益，因此平衡各方利益的原则是求询夫妇的利益和需求优先。

第二，咨询医师与求询者价值观的平衡。在遗传咨询的过程中，咨询医师往往根据自己的价值观提出医学处理意见，但这种意见可能不符合求询者的价值观，在进行充分解释后，咨询医师最终应该尊重求询夫妇的价值观，不能将自己的价值观强加于对方。

第三，保密与讲真话的平衡。对于如何控制遗传咨询中形成的遗传信息，涉及“为求询者保密”和“对求询者保密”两个问题。其一，应该为求询者保密，泄露秘密会导致其在就业等各方面受到歧视。其二，对于某些遗传信息，应该对求询者保密。例如求询者患有抑郁症，告知信息会加重病情甚至导致自伤。咨询医师应该以保护求询者最大利益为原则，可以采取直接告知家属或选择恰当的时机、方式和场合告知等策略。

5. 产前诊断　产前诊断是指通过某些医学方法检查胎儿是否正常，如有异常，则根据其性质和程度采取继续怀孕或终止妊娠的措施。产前诊断的非侵袭性方法有超声诊断、母亲血样化验、妊娠早期的筛查等，侵袭性方法有绒毛膜取样、胎盘取样、羊水穿刺、胎儿血样化验等。另外，还有第三代试管婴儿技术在胚胎植入前进行的遗传检测。产前诊断引发的伦理问题主要有以下两个方面。

一方面是产前诊断后如何作出优生决策。运用产前诊断，如果是阳性结果，往往会导致有缺陷的胎儿被人工流产。但作出这个决定并不容易，尤其是在对缺陷的轻重程度认识不全面、存在某些不确定性和仅有一定概率等情况下，选择将更加困难。通常由医师提出医学意见，最终由求询夫妇知情同

意或自主决定。

另一方面是产前诊断能否进行性别鉴别。许多产前诊断措施能够对胎儿进行性别鉴别，但是否应该进行鉴别同样是一个伦理问题。基于优生医学需要而进行的产前性别鉴别是合乎伦理的，例如对于有些伴性遗传病，可以通过产前诊断进行胎儿性别鉴别，通过人工流产限制相应性别胎儿的出生。而实施非医学需要的胎儿性别鉴别，容易造成出生婴儿性别比例失衡的结果，是不合乎伦理的。

（二）积极优生措施及其伦理问题

1. 积极优生的医学措施　第一，通过生殖技术进行积极优生。美国著名遗传学家缪勒（Muller）曾建议让一些“杰出的”男子多次提供精子，然后通过对妇女人工授精产生更为“杰出的”后代。伴随人工授精及试管婴儿技术的发展、精子库的建立，在有限范围内可以使缪勒的设想得以实现。第二，通过基因增强技术进行积极优生。基因增强（gene augmentation）是通过基因治疗技术使人体增加物种原先不具备的新能力，包括增强认知、形态、体能，使形态更美、寿命更长，有更好的头脑、身体素质等。这些基因增强技术主要包括改变体细胞或生殖细胞的基因结构。因为此项技术很难控制可能给人类带来的后果，目前严格禁止应用于人体。

2. 积极优生引发的伦理问题　第一，积极优生是否可能？积极优生中的首要伦理问题是这些措施是否能够真正产生积极优生的效果。积极优生目前大都处于设想和尝试阶段，带有一定的不确定性。“人的性状和能力的形成是遗传物质起主导作用还是后天造就”在生物学、医学和教育学领域一直存在着争论。“基因决定论”夸大了遗传物质的功能，忽视了社会、文化和教育等环境因素，以及个人的主观努力等自由意志的作用。人类的智力发展不单单取决于基因，而是遗传因素与社会环境相互作用的结果。第二，积极优生是否应该？“积极优生是否可能”需要科学来证实，如果积极优生不具可能性，那么进行积极优生就是不合伦理的；即使积极优生成为可能，也需要确定伦理准则。如果积极优生成为可能，“人性准则”则是其伦理的前提。所谓人性准则，是指积极优生应该符合普遍人性及其规律。由于积极优生给人带来的是好处还是坏处、优生的程度和极限尚不确定，因此这种“不确定性”就决定了积极优生不能超过普遍人性。

第三节 | 辅助生殖伦理

辅助生殖技术是帮助解决不孕不育症患者“能不能”生育的问题，而辅助生殖伦理是解决医学技术“该不该”实施的问题。一方面，医务人员需通过伦理评价和价值判断，防止辅助生殖技术的滥用；另一方面，传统伦理观也要与时俱进，以更好地引导、规范新技术的应用，并促进技术的进步。

一、辅助生殖技术概述

生殖技术又称人类辅助生殖技术（assisted reproductive technology，ART），是指运用医学技术和方法代替自然的人类生殖过程的某一步骤或全部步骤的手段，对配子、合子、胚胎进行人工操作，以达到受孕目的的技术。此类技术可在一定程度上治疗不孕不育症，以达到生育的目的，也是生育调节的手段。该项技术主要包括人工授精、体外受精、卵胞质内单精子注射、植入前遗传学诊断、精液冷冻、胚胎冷冻等。

（一）人工授精

人工授精（artificial insemination，AI）是指收集丈夫或自愿捐精者的精液，由医师注入女性生殖道，以达到受孕目的的辅助生殖技术。人工授精实际上替代了自然生殖过程中的性交。按照精液的来源不同，可以分为夫精人工授精（artificial insemination by husband，AIH）和供精人工授精（artificial insemination by donor，AID）。前者又称同质人工授精，即用自己丈夫的精子进行的人工授精；后者又

称异质人工授精，即用自愿捐精者的精子进行的人工授精。由于冷冻技术在这个领域中的运用，可以把精液冷冻在液态氮中长期保存，于是诞生了储存精子的机构——精子库（sperm bank），又被称为“精子银行”。

（二）体外受精

体外受精（in vitro fertilization，IVF）是指用人工方法让卵子和精子在人体以外受精和发育的生殖方法。体外受精代替了自然生殖过程的性交、受精和自然植入子宫三个步骤。目前，在体外完成人类胚胎和胎儿的全部发育过程还只是一个设想，可以做到的是把发育到一定程度的胚胎移植到母体子宫中，进一步发育直到诞生。因此，体外受精和胚胎移植技术总是结合在一起应用的。由于受精是在实验室的试管中进行，通过这种方式诞生的婴儿，通常又被称为试管婴儿。由于可以激发排卵，受精卵的数目可能超过移植的需要，在这个领域同样可以使用冷冻技术，于是诞生了冷冻卵子库和冷冻胚胎库。

（三）卵胞质内单精子注射

卵胞质内单精子注射（intracytoplasmic sperm injection，ICSI），即所谓第二代试管婴儿技术，是1992年比利时自由大学中心医学专家创立的辅助受精技术，该技术借助显微操作系统将单一精子直接注射到成熟卵子内使其受精，显微注射前精子无须发生顶体反应，对精子浓度、活动度、形态等参数要求低，仅需数条精子即可获得较高的受精率、胚胎移植率，利用附睾和睾丸的精子也能取得和正常精子相似的妊娠率。因此，ICSI技术的发展使少弱精子症、无精子症等方面的不育治疗取得了突破性进展，已成为严重男性不育患者的最有效治疗方法。此项技术主要适用于严重的少、弱、畸形精子症及梗阻性无精子症、生精功能障碍、精子无顶体或顶体功能异常等患者。但ICSI是一种侵入性操作，对卵子有一定创伤，治疗费用较高，而且其子代的安全性还需长期跟踪随访，不能也不应取代常规IVF，应严格掌握适应证。

（四）植入前遗传学诊断

植入前遗传学诊断（preimplantation genetic diagnosis，PGD），即所谓的第三代试管婴儿技术，它是在常规试管婴儿技术的基础上，对获得的胚胎进行遗传学方法检测，在医师指导下挑选合适的胚胎移植入母体子宫，以防止患遗传性疾病胎儿的出生。第三代试管婴儿技术应用至今已有20余年的历史，目前通过PGD技术可检测上百种疾病，包括染色体异常、单基因遗传病或性连锁疾病，如染色体平衡易位、罗伯逊易位、血友病、多囊肾、克兰费尔特综合征等。随着检测技术及基因诊断的发展，PGD技术对优生工作发挥着越来越重要的作用。

二、辅助生殖技术的伦理价值

（一）治疗不孕不育

发展生殖技术的初衷就是为了解决不孕不育问题，换言之，辅助生殖是其最基本的价值。当前在临床上已经运用的生殖技术有着不同的价值，人工授精技术主要解决男性的不育问题：AIH适用于男性性功能异常、不能进行正常性交者，或适用于男性精液中轻度少精、弱精或其他轻度男性不育者；AID适用于男性精液中无精子或男女为同一染色体隐性杂合体者。

在体外受精-胚胎移植技术中，第一代试管婴儿技术主要解决夫妻双方中因女方输卵管阻塞而产生的不孕难题，还可以解决女性宫颈黏膜不利于精子通过以及其他不明原因导致的不孕不育症问题，使用供者卵还可以解决女性无卵或卵子功能异常问题。第二代试管婴儿技术则主要解决夫妻双方中因男方极度少精、弱精或阻塞性无精而产生的不育难题。

（二）实现优生优育

对于患有遗传病的夫妇，使用他人的生殖细胞进行辅助生殖，可以实现优生。例如第三代试管婴儿技术，通过胚胎筛选预防遗传病，对有遗传病的夫妇通过体外受精发育成的胚胎进行筛选，而后将没有遗传病基因的胚胎移植到女方的子宫里，就可以有效地实现优生优育的愿望。

NOTES

（三）提供“生殖保险”

利用现代技术将生殖细胞或受精卵、胚胎进行冷冻保存，通过人工授精或体外受精-胚胎移植来生育孩子，也被称为“生殖保险”，目前主要采用超低温冷冻技术预先保存男性精子以期预防未来生育风险，在有生育需求时将精子安全复苏以供辅助生殖治疗需要。

三、辅助生殖技术引发的伦理争议

（一）如何确定配子、合子和胚胎的道德地位

生殖技术首先引发了精子、卵子、受精卵和胚胎的道德地位如何确定的问题。即它们是否具有独立的道德地位？是提供者的物质、身体部分还是具有独立道德地位的个体？它们是否属于提供者的财产？提供者可否因此获得报酬？提供人类辅助生殖技术的医疗机构给予有关当事人经济补偿是否属于变相的商业化？与此相联系的是生殖技术能否商业化的问题。

在某些国家，提供精子的人获得经济报酬已经成为常规。我国也有人建议精子可以商品化。主要理由是，我国的精子库普遍存在捐献者过少的问题，精子商品化可以大大增加精子的供给量。但更多人认为精子商品化可能造成供者不关心自己行为的后果，有意或无意地隐瞒自己的生理或心理缺陷；精子库可能由于竞争或追求利润最大化而忽视精子的质量，或者为了追求高质量，只提供一类世人认为“最佳的”精子，使人类基因变得单调而缺乏多样性等。

（二）如何确定家庭人伦关系

AID 提出的一个新问题是“谁是父亲”，随着 AID 与体外受精-胚胎移植技术的结合，扩大为“谁是父母”的问题。父亲可分为“遗传父亲”“养育父亲”及两者合一的“完全父亲”；母亲可分为“遗传母亲”“孕育母亲”“养育母亲”及三者合一的“完全母亲”。

辅助生殖技术除用于已婚的不孕不育症患者外，在某些国家和地区还允许帮助未婚男女和同性恋者生儿育女。这样可能会对已有的家庭模式、子代的成长、人伦关系等带来前所未有的挑战。

2006 年 7 月，英国立法规定单身妇女和同性恋女性可以采用人工授精、体外受精生育。我国 2003 年公布的《人类辅助生殖技术和人类精子库伦理原则》则明确规定，不允许单身未婚女性使用辅助生殖技术。

（三）自然法则可否违背

生殖技术合乎伦理的基础是遵循自然生殖法则：凡是符合自然法则的，就被认为是道德的；凡是不符合自然法则的，就被认为是不道德的。在人类遗传学和生殖生物学中，迄今为止一直遵守着一条法则，即由父母通过性细胞中遗传物质 DNA 的结合而产生子代。质疑者认为，生儿育女是爱情、婚姻的永恒体现，而生殖技术切断了生儿育女和婚姻的联系；如果把生育变成了“配种”，把家庭的神圣殿堂变成了一个生物学实验室，同时把人类分成技术繁殖的和自然繁殖的两类，那么是否严重挑战了自然生殖的法则呢？

生殖技术还可能导致近亲婚配。在生殖技术应用中，对精子、卵子的捐献者通常是保密的，这样就有可能出现捐精者、捐卵者、人工授精后代、试管婴儿后代相互之间近亲婚配。而人类两性关系发展的历史早已证明，近亲通婚往往容易将双方生理上的缺陷传给后代。

（四）错用或滥用的可能

“错用”是指生殖技术操作者的动机原本是好的，但其效果却带来种种问题。“滥用”是指由生殖技术操作者的不良动机而造成的种种问题。例如，精子库管理不善导致的精子去向不明、“一精多用”等问题，可能带来潜在的风险和家庭伦理问题。

（五）代孕的伦理争议

代孕技术作为一项辅助生殖技术引起了社会热议，目前仍存在诸多伦理争议。支持合理使用代孕的一方认为，存在生殖障碍的育龄夫妇比例不断递增，代孕给了这一类人群新的希望，能够使他们拥有一个带有夫妇自己基因的孩子，维护家庭幸福。反对代孕的一方将代孕与出租器官联系在一起，

认为代孕行为实质上就是出租子宫，将女性作为生育机器，这是对女性的极大侮辱，违背家庭伦理，践踏人格尊严。不同国家和地区对于代孕的态度也有所不同，如中国、法国、瑞典、德国、新加坡等是完全禁止代孕的，而美国等主张有限开放代孕。

代孕不同于传统的生殖方式，其涉及的当事人不仅仅是传统意义上的父母双方，通过代孕分娩的婴儿在遗传学上和生理学上拥有两位不同的母亲，现有的亲子关系规则并不能完全有效地作出复杂的亲子关系认定，代孕子代归属较难判定。代孕母亲的法律地位是否等同于传统父母的问题在法律上尚无定论，但代孕母亲的地位问题已在现实生活中引发了不少的纠纷，如代孕母亲追讨代孕子女的监护权的案件屡屡发生。商业代孕合同在履行时也存在隐患，如代孕母亲产下生理缺陷婴儿后其抚养责任的归属、多胞胎的胎儿归属等。如果在此类问题上双方不能妥当处理，势必会将责任推向社会。

四、辅助生殖技术应用的伦理准则

（一）我国辅助生殖技术伦理制度建设概述

我国的生殖技术研究和临床应用进展很快，人工授精、体外受精-胚胎移植技术已经在临床广泛运用，但同时也带来了不可忽视的问题。为了规范生殖技术的研究和临床运用，卫生部于 2001 年颁布实施了《人类辅助生殖技术管理办法》，并于 2003 年修订推出《人类辅助生殖技术规范》《人类精子库基本标准和技术规范》《人类辅助生殖技术和人类精子库伦理原则》。2019 年国家卫生健康委员会相继发布《辅助生殖技术随机抽查办法》和《关于加强辅助生殖技术服务机构和人员管理的若干规定》。2021 年国家卫生健康委员会印发《人类辅助生殖技术应用规划指导原则（2021 版）》，对规范生殖技术的研究和临床运用起到了十分重要的作用。

（二）我国辅助生殖技术应用伦理准则

1. 有利于患者原则　①综合考虑患者病理、生理、心理及社会因素，医务人员有义务告诉患者目前可供选择的治疗手段、利弊及其所承担的风险，在其充分知情的情况下，提出有医学指征的选择和最有利的治疗方案。②应选用最佳治疗方案、最佳药物、最佳手术方案等，使供受者受益。③禁止以多胎和商业化供卵为目的的促排卵。④不育夫妇对实施人类辅助生殖技术过程中获得的配子、胚胎拥有选择处理方式的权利，技术服务机构必须对此有详细的记录，并获得夫妇双方的书面知情同意。⑤患者的配子和胚胎在未征得其知情同意的情况下，不得进行任何处理，更不得进行买卖。

2. 知情同意原则　①人类辅助生殖技术必须在夫妇双方自愿同意并签署书面知情同意书后方可实施。②对符合人类辅助生殖技术适应证的夫妇，医务人员须使其了解：实施该技术的必要性、实施程序、可能承受的风险以及为降低这些风险所采取的措施、该机构稳定的成功率、每周期大致的总费用及进口、国产药物选择等与患者作出合理选择相关的实质性信息。③接受人类辅助生殖技术的夫妇在任何时候都有权提出中止该技术的实施，并且不得影响对其今后的治疗。④医务人员必须告知接受人类辅助生殖技术的夫妇关于通过辅助生殖技术出生的孩子接受随访的必要性。⑤医务人员有义务告知捐赠者对其进行健康检查的必要性，并获取书面知情同意书。

3. 保护后代原则　①医务人员有义务告知患者通过人类辅助生殖技术出生的后代与自然受孕分娩的后代享有同样的法律权利和义务，包括后代的继承权、受教育权、赡养父母的义务、父母离异时对孩子监护权的裁定等。②医务人员有义务告知接受人类辅助生殖技术治疗的夫妇，他们对通过该技术出生的孩子负有道德和法律上的权利和义务。③如果有证据表明实施人类辅助生殖技术将会对后代产生严重的生理、心理和社会损害，医务人员有义务停止该技术的实施。④医务人员不得对近亲间及任何不符合道德的精子和卵子实施人类辅助生殖技术。⑤医务人员不得实施代孕技术。⑥医务人员不得实施胚胎赠送助孕技术。⑦在尚未解决人卵胞质移植和人卵核移植技术安全性问题之前，医务人员不得实施以治疗不育为目的的人卵胞质移植和人卵核移植技术。⑧同一供者的精子、卵子最多只能使 5 名妇女受孕。⑨医务人员不得实施以生育为目的的嵌合体胚胎技术。

4. 社会公益性原则　①医务人员必须严格遵守国家相关法律法规，不得对不符合国家相关法律法规规定的夫妇和单身妇女实施人类辅助生殖技术。②医务人员不得实施非医学需要的性别选择。③医务人员不得实施生殖性克隆技术。④医务人员不得将异种配子和胚胎用于人类辅助生殖技术。⑤医务人员不得进行各种违反道德的配子和胚胎试验研究及临床工作。

5. 保守医疗秘密原则　①互盲原则：凡使用供精实施的人类辅助生殖技术，供方与受方夫妇应保持互盲，供方与实施人类辅助生殖技术的医务人员应保持互盲，供方与后代保持互盲。②医疗机构和医务人员对使用人类辅助生殖技术的所有参与者（例如卵子捐赠者和接受者）有实行匿名和保密的义务。匿名是隐匿供者的身份，保密是隐匿受者参与配子捐赠的事实以及对受者有关信息的保密。③医务人员有义务告知捐赠者不可查询受者及其后代的一切信息，并签署书面知情同意书。

6. 严防商业化原则　①医疗机构和医务人员对要求实施人类辅助生殖技术的夫妇，要严格掌握适应证，不能受经济利益驱使而滥用人类辅助生殖技术。②供精、供卵只能以捐赠助人为目的，禁止买卖，但是可以给予捐赠者必要的误工、交通和医疗补偿。

7. 伦理监督原则　①为确保以上原则的实施，实施人类辅助生殖技术的机构应建立生殖医学伦理委员会，并接受其指导和监督。②生殖医学伦理委员会应由医学伦理学、心理学、社会学、法学、生殖医学、护理学专家和群众代表等组成。③生殖医学伦理委员会应依据上述原则对人类辅助生殖技术的全过程和有关研究进行监督，开展生殖医学伦理宣传教育，并对实施中遇到的伦理问题进行审查、咨询、论证和建议。

（三）我国人类精子库管理伦理准则

1. 有利于供受者原则　①严格对供精者进行筛查，精液必须经过检疫方可使用，以避免或减少出生缺陷，防止性传播疾病的传播和蔓延。②严禁用商业广告形式募集供精者，要采取社会能够接受且文明的形式和方法，应尽可能扩大供精者群体，建立完善的供精者体貌特征表，尊重受者夫妇的选择权。③应配备相应的心理咨询服务，为供精者和自冻精者解决可能出现的心理障碍。④应充分理解和尊重供精者和自冻精者在精液采集过程中可能遇到的困难，并给予其最大程度的帮助。

2. 知情同意原则　①供精者应是完全自愿地参加供精，并有权知道其精液的用途及限制供精次数的必要性（防止后代血亲通婚），应该签署书面知情同意书。②供精者在心理、生理不适或其他情况下有权终止供精，同时在适当补偿精子库筛查和冷冻费用后，有权要求终止使用已被冷冻保存的精液。③需进行自精冷冻保存者在签署知情同意书后，方可实施自精冷冻保存。医务人员有义务告知自精冷冻保存者采用该项技术的必要性、目前的冷冻复苏率和最终可能的治疗结果。④精子库不得采集、检测、保存和使用未签署知情同意书者的精液。

3. 保护后代原则　①医务人员有义务告知供精者，对其供精出生的后代无任何的权利和义务。②建立完善的供精使用管理体系，精子库有义务在匿名的情况下，为未来人工授精后代提供有关医学信息的婚姻咨询服务。

4. 社会公益性原则　①建立完善的供精者管理机制，严禁同一供精者多处供精并使5名以上妇女受孕。②不得实施无医学指征的X、Y精子筛选。

5. 保守医疗秘密原则　①为保护供精者和接受者夫妇及所出生后代的权益，供精者和接受者夫妇应保持互盲，供精者和实施人类辅助生殖技术的医务人员应保持互盲，供精者和后代应保持互盲。②精子库的医务人员有义务为供精者、接受者及其后代保密，精子库应建立严格的保密制度并确保实施，包括冷冻精液被使用时应一律用代码表示，冷冻精液的接受者身份对精子库隐匿等措施；接受者夫妇以及实施人类辅助生殖技术机构的医务人员均无权查阅供精者真实身份的信息资料，供精者无权查阅接受者及其后代的一切身份信息资料。

6. 严防商业化原则　①禁止以营利为目的的供精行为，供精是自愿的人道主义行为，精子库仅可以对供精者给予必要的误工、交通和其所承担的医疗风险补偿。②人类精子库只能向已经获得卫生部（现国家卫生健康委员会）人类辅助生殖技术批准证书的机构提供符合国家技术规范要求的冷

冻精液。③禁止买卖精子，精子库的精子不得作为商品进行市场交易。④人类精子库不得为追求高额回报降低供精质量。

7. 伦理监督原则　①为确保以上原则的实施，精子库应接受由医学伦理学、心理学、社会学、法学、生殖医学、护理学专家和群众代表等组成的生殖医学伦理委员会的指导、监督和审查。②生殖医学伦理委员会应依据上述原则对精子库进行监督，并开展必要的伦理宣传和教育，对实施过程中遇到的伦理问题进行审查、咨询、论证和建议。

现代生殖医学提供了越来越多能有效干预人类自然生育行为的手段，例如生育控制、优生优育和辅助生殖等。这些措施虽给人类带来了福音，但也引发了一些伦理问题。生殖医学技术服务都是由医务人员提供的，因此，作为生育控制的专业技术“守门人”，医务人员应该明确和积极承担起在生殖医学事业中的重大道德责任，严格遵守国家制定的伦理准则和法律法规，处理好技术应用中的特殊医患关系问题。对于其中充满伦理争议、尚无“标准答案”的问题，应该充分发挥伦理智慧，积极而慎重地应对，并通过伦理委员会讨论后表决，以集体的力量和智慧尽可能妥善解决问题。

思考题

1. 试论述生育政策的伦理依据。
2. 分析消极优生和积极优生中的具体伦理问题。
3. 简述辅助生殖技术和人类精子库的伦理准则。

（袁蕙芸）